

中

章朝民 张连同 主编

医秘验方再验荟萃

科学普及出版社

89019

中医秘验方再验荟萃

袁惠民 张连同 主编

科学普及出版社

C0152358



内 容 提 要

本书精选了近10余年各种中医药期刊上发表的、并经反复验证和作者亲自验证的有效秘验方约200首。涉及内、外、妇、儿、五官等临床各科病证100余种。每首方又设方名、来源、组成、用法、主治、疗效、验证及按语等内容。

该书所选验方均有出处，疗效，验证也均有临床病例。适用于中西医临床医生，尤其是乡村医生及中医药爱好者。

(京)新登字026号

中医秘验方再验荟萃

袁惠民 张连同 主编

责任编辑：高秀英

封面设计：赵一东

技术设计：赵丽英

*

科学普及出版社出版（北京海淀区白石桥路32号）

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

国防科工委印刷厂印刷

*

开本：787×1092 毫米 1/32 印张：7.25 字数：161千字

1992年9月第1版 1992年9月第1次印刷

印数：1—7900册 定价：3.80元

ISBN7-110-02388-5/R·268

副主编 王汝新 韩其江 范立孝 杨建国

编委 (以姓氏笔划为序)

马吉诗 王汝新 孔祥福 石宝营

孙仕田 许国华 朱培训 朱培楨

张连同 范立孝 杨建国 赵胜利

袁惠民 韩其江 魏会东

编写说明

一、本书在编写过程中为使体例一致，以方便读者阅读参考。排列顺序按人体部位自上而下，尽量用西医病名。在不损原意的原则下，对部分处方的名称、书写形式及病例作了适当的变动或增删。

二、本书所载中药，除方药中明确规定特殊加工炮制者外，一般采用中药房的药典规范的药材制品。

三、本书药方中药物用量统一用克表示。除儿科部分外，一律为成人剂量，故应用时对幼儿及年老体弱者宜酌情减量。

四、中药名称存在着“同名异药、同药异名”现象，在使用时若发现与原著验方药名等不符合者，可根据来源查对原著。

本书在编写过程中得到各级领导和王开贞等老师们的支持帮助，在此表示谢意。

由于我们水平有限，疏漏与不妥之处在所难免，恳请同道和读者批评指正。

编 者

1991年5月

目 录

内 科 部 分

1. 神经性头痛·····	1
2. 神经性头痛·····	2
3. 偏头痛·····	3
4. 偏头痛·····	4
5. 慢性头痛·····	5
6. 眩晕·····	6
7. 失眠·····	8
8. 鼻衄·····	9
9. 支气管炎·····	10
10. 慢性支气管炎·····	11
11. 支气管哮喘·····	12
12. 毛细支气管炎·····	14
13. 咳嗽·····	15
14. 百日咳·····	16
15. 顽咳症·····	17
16. 病毒性心肌炎·····	18
17. 心悸脉结·····	20
18. 冠心病·····	21
19. 胃脘痛·····	23

20. 嘈杂	24
21. 消化道溃疡	25
22. 消化道溃疡	26
23. 胃及十二指肠溃疡	27
24. 各种呕吐	28
25. 神经性呕吐	29
26. 胃出血	30
27. 出血症	31
28. 各种出血症	32
29. 阴虚胁痛	34
30. 慢性结肠炎	35
31. 久泻久痢	36
32. 虚性便秘	37
33. 遗尿症	38
34. 遗尿症	39
35. 排尿异常	40
36. 急性肾炎	41
37. 肾炎水肿	42
38. 慢性肾炎蛋白尿	43
39. 严重水肿	44
40. 糖尿病	46
41. 轻中型糖尿病	47
42. 乳糜尿	48
43. 血淋	50
44. 阳痿	51
45. 阳痿	52

46. 阳痿不育	53
47. 精淤症	55
48. 阴寒证	56
49. 血小板减少性紫癜	58
50. 血小板减少性紫癜	59
51. 特发性血小板减少性紫癜	61
52. 瘰病	62
53. 癫痫	63
54. 癫狂症	64
55. 半身麻木	66
56. 多发性神经炎	67
57. 外感发热	68
58. 多种发热	69
59. 昏迷	71

外 科 部 分

60. 慢性毛囊炎(劈脑疳疮)	73
61. 脓疱疮(黄水疮)	74
62. 白发	75
63. 脱发	77
64. 斑秃(油风)	78
65. 脂溢性皮炎	79
66. 酒刺(痤疮)	80
67. 面部“印斑”(蝴蝶影)	81
68. 男性乳房发育症	83
69. 腋臭	84

70.	胆结石	85
71.	胆结石	86
72.	慢性胆囊炎	87
73.	胆道蛔虫症	88
74.	胆道蛔虫症	90
75.	巨大胃柿石症	91
76.	泌尿系结石	92
77.	前列腺肥大	93
78.	前列腺炎	94
79.	前列腺炎	96
80.	各种息肉	97
81.	各种痔病	98
82.	痔疮	100
83.	痔疮发炎、肿痛	101
84.	蛲虫病	102
85.	宿食结于肠间	102
86.	睾丸鞘膜积液	104
87.	睾丸鞘膜积液	105
88.	阴囊湿疹	106
89.	带状疱疹	107
90.	带状疱疹	108
91.	带状疱疹	109
92.	跌打损伤	110
93.	肥大性脊柱炎	112
94.	损伤性腰腿痛	113
95.	脊髓癆	114

96.	骨质增生·····	115
97.	痛痹·····	117
98.	坐骨神经痛·····	118
99.	坐骨神经痛·····	119
100.	腹壁静脉炎·····	121
101.	鹤膝风·····	123
102.	关节扭伤·····	124
103.	血栓闭塞性脉管炎·····	125
104.	急性淋巴管炎·····	127
105.	下肢溃疡·····	128
106.	无名肿毒·····	129
107.	手癣·····	130
108.	手足皲裂症·····	131
109.	骨髓炎·····	132
110.	银屑病·····	133
111.	银屑病·····	136
112.	皮肤瘙痒症·····	138
113.	皮肤瘙痒症·····	139
114.	顽固性皮肤瘙痒·····	140
115.	丘疹性荨麻疹·····	141
116.	痱子·····	142
117.	湿疹·····	143
118.	慢性湿疹·····	144
119.	热毒痈肿、血肿·····	145
120.	肌痛症·····	146
121.	扁平疣·····	147

122.	各种癬症·····	148
123.	淋巴、骨、关节结核·····	149
124.	水火灼烧伤·····	150
125.	冻疮·····	151

妇 科 部 分

126.	白塞氏三联综合症·····	153
127.	习惯性流产·····	154
128.	白带病·····	155
129.	外阴瘙痒·····	156
130.	阴痒·····	158
131.	不孕症·····	159
132.	子宫肌瘤·····	160
133.	产后缺乳·····	162
134.	乳腺炎·····	163
135.	急性乳腺炎·····	164
136.	急性乳腺炎·····	165
137.	急性乳腺炎·····	166
138.	妊娠恶阻·····	167

儿 科 部 分

139.	儿童癫痫小发作·····	169
140.	小儿热病后期口腔溃疡·····	170
141.	小儿口腔溃疡·····	171
142.	小儿口糜·····	172
143.	小儿流涎·····	173

144.	小儿支气管哮喘	174
145.	百日咳	176
146.	小儿疳积	177
147.	小儿疳积	178
148.	麻疹后下痢	179
149.	小儿脱肛	180
150.	小儿疝气	181
151.	小儿高热	182
152.	婴儿湿疹	183

五 官 部 分

153.	春季卡他性结膜炎	185
154.	红眼病	186
155.	肝热目赤肿痛	187
156.	化脓性中耳炎	188
157.	化脓性中耳炎	189
158.	酒渣鼻	190
159.	过敏性鼻炎	191
160.	梅核气	193
161.	寒性咽痛	194
162.	急性咽喉炎	195
163.	慢性咽炎	196
164.	声带息肉	197
165.	口腔溃疡	198
166.	溃疡性口腔炎	199
167.	顽固性口腔溃疡	200

168.	复发性口腔溃疡·····	202
169.	口腔溃疡·····	203
170.	牙周炎、牙髓炎·····	204
171.	各种牙痛·····	205
172.	各种类型牙痛·····	206
173.	三叉神经痛·····	207
174.	面神经麻痹·····	208
175.	面神经麻痹·····	209
176.	面肌痉挛·····	210
177.	流行性腮腺炎·····	212
178.	流行性腮腺炎·····	213
179.	流行性腮腺炎·····	214
180.	腮腺炎·····	215
181.	腮腺炎·····	216
182.	流行性腮腺炎·····	217

内科部分

1. 神经性头痛

方名：加味乌星散

来源：任应秋，《中医杂志》，1980；(10)：22。

组成：制川乌、南星、细辛、地龙各3克，菊花6克，冰片0.9克。

用法：先煎川乌、南星、细辛、地龙四味，菊花最后入，稍煎即成，分2次服，冰片另研极细，分做2份，临服时冲入1份。

主治：神经性头痛。

疗效：上方为任应秋教授治疗神经头痛的经验方，服后略休息，头痛即止。治疗多例每能应手取效。

验证：柯氏用上方验治头痛（包括外伤后头痛、偏头痛、经期头痛、神经性头痛等）50例，一般服六剂左右头痛可止。其中15例随访3个月至半年头痛均未复发。病例：李××，男，42岁，1980年11月12日来诊。5年前因翻车伤及头部，诊为“脑震荡后遗症”，随之头痛频发，夜寐艰难，经服中西药效差，舌淡红，苔白，脉弦，投加味乌星散三剂，

头痛即止，夜寐转安，再服三剂巩固疗效。随访7个月头痛未见复发。(柯联才，《中医杂志》，1981；(11)：76。)

按：神经性头痛是一种慢性病。往往反复发作，迁延不愈，痛或在一侧，或在颠顶，多因生气、受风、感寒以及天气变化而引起发作。脉见沉细微弦，并无任何热象，以阳气虚损者多，故方中用川乌、细辛祛风散寒通经止痛，地龙活血通络止痛，菊花平肝熄风清利头目，借冰片芳香走窜通窍止痛，故取效迅速。

2. 神经性头痛

方名：头痛塞鼻散

来源：吴震西，《中医杂志》，1982；(2)：68。

组成：川芎50克，白芷50克，炙远志50克，冰片7克。

用法：上药共研细末，装瓶密贮勿泄气。用时以绸布或的确良布一小块，包少许药末，塞入鼻孔，右侧头痛塞左鼻，左侧头痛塞右鼻。

主治：神经性头痛（偏头痛）。

疗效：吴氏用上方治疗偏头痛百余例，皆取得了满意的疗效。一般塞鼻3~5分钟后，头痛即逐渐消失，有的塞鼻得嚏后，自觉七窍畅通而痛止。复发时再用仍有效。病例：顾××，女，43岁，患偏头痛1年多，每月发作1~2次，每次持续3~4天，发作时不能坚持工作，因畏服煎药，单纯给予上方治疗，按此法塞后即可止痛，痛发时再塞又可取效，连塞2日即可痊愈，时过半年未再复发。

验证：吴氏用上方验治3例偏头痛，均获良效。病例：

郭××，女，37岁。患右侧偏头痛2年多，时轻时重，缠绵难愈，经服中西药未见效。笔者曾辨证为肝火上攻所致，用龙胆泻肝汤加味三剂，效果不佳，即试用“头痛塞鼻散”，同时，将其粗渣和食用醋调成糊状，于睡前敷于患侧太阳穴处。按原方原药组成配制一料药，用了不到一半，患者偏头痛即痊愈。(吴文群，《中医杂志》，1983；(1):78。)

按：偏头痛现代医学大多认为属血管神经性或神经性头痛。方中取治疗头痛常用药川芎和白芷，配远志养心安神祛痰通络，再加入芳香开窍的冰片，制成散剂塞鼻，故对偏头痛及鼻窦炎等引起的偏头痛，均有迅速止痛效果。

3. 偏 头 痛

方名：生萝卜汁

来源：《如宜方》

组成：生萝卜汁、蚬壳。

用法：取生萝卜汁1蚬壳、仰卧注鼻中，左痛则注之右，右痛则注之左，或注之左右皆可。

主治：偏头痛。

疗效：沈括之“以此法治人，不可胜数”。沈括是位实验家，其言是可信的。《名医类宗》亦记载了外治的方法，很值得采用。即是：仰卧左头痛注右鼻孔，右头痛注左鼻孔，或不拘左右随意注亦可。而“数十年患，皆二注而愈。”

验证：笔者曾用此法，治愈2例偏头痛患者。病例：李××，男，偏头痛20多年，屡医无效，观其面，憔悴不华，且有瘀斑，左侧无痛时，面色蜡黄，难以忍受，常自

语，不如一死了之而去后患。且平素烦躁不安，初给用通窍活血之类，皆无效。一偶然机会，翻阅《中药大辞典》时，载《如宜方》“生萝卜汁1蛭壳，仰卧，随左右注鼻中。”正值萝卜收藏季节，物美价廉，取材方便，随即一试，2次后，头痛竟减，嘱其连用几次，顽痰痼疾，竟然豁愈。病人无不欣然。(王汝新，惠民地区中医院)

按：偏头痛亦有称为头风者，属中医难症之一。且病程较长者，真是病人头痛，医者更头痛。

萝卜汁药源丰富，便于应用，《本草纲目》云“散瘀血”。《中医大辞典》云“化痰热。”综偏头痛病机，“瘀”与“痰”并见者为多，且难治，故用萝卜汁，散瘀、化痰与痰热俱去，清窍通利，故头痛愈矣。

4. 偏 头 痛

方名：新加牵正散

来源：吴平，《新中医》，1988；(12)：32。

组成：白附子、全蝎各6克，当归、柴胡各12克，僵蚕、川芎、白芷各10克，蜈蚣各1条。

用法：水煎服。风痰偏重加半夏、防风、制南星、陈皮，肝火偏亢加龙胆草、山栀、黄芩、丹皮，久痛入络加赤芍、穿山龙、桃仁、红花。

主治：偏头痛。

疗效：吴氏用上方治愈5例。病程最长者10年，最短5个月，治愈天数，最长15天，短则5天。病例：何××，女，78岁，1987年10月5日诊，头右侧掣痛，时发时止，腮部尤

重10多年。虽经住院治疗无明显好转,经用中西药治疗罔效。现其症状:头右侧掣痛,逢恼怒加重,腮肿发热。近一周来头晕眼胀,口不能张,彻夜不眠,口苦咽干,舌边尖红,苔薄黄,脉弦。辨为肝火上扰,风痰阻络。用上方加龙胆草、栀子、黄芩、秦艽、赤芍各10克,五剂而愈。

验证:王氏用上方验治6例,疗效甚佳。病例:刘××,男,40岁,驾驶员,患有偏头痛(又名头风),头右侧掣痛,时发时止,腮部尤重10余年,经多方治疗罔效,经用上方加味,四剂而愈,至今未复发。(王万才,《新中医》,1990;(8):封三。)

按:偏头痛又名偏头风,其痛暴发,痛势甚剧,或左或右,多见于西医血管神经性头痛。方中全蝎、僵蚕、蜈蚣类药以搜逐瘀,通络止痛,白附子能祛风化痰,善“引药势上行”。而治头面之疾,川芎、当归、白芷活血行气而治头痛,柴胡升发阳气引药直达病所,瘀祛化痰,风熄络通而头痛自止。

5. 慢性头痛

方名:清上蠲痛汤

来源:程方,《新中医》,1980;(1):50。

组成:当归、川芎、白芷、羌活、独活、麦冬、黄芩、防风、蔓荆子、苍术各3克,细辛、干姜各2克,菊花、甘草各1.5克。

用法:可加重用量另加大黄适量,水煎服。

主治:慢性头痛。(亦可治三叉神经痛)。

疗效：日本矢数道明氏用上方治愈1例长达15年慢性头痛患者。病人为50岁妇女，48岁停经，头痛已15年，形体消瘦，脸色苍白，时觉头中扑通之落水声感，长期服镇痛药而胃感不舒，时有胸闷烦躁，身或灼热，动则心悸，甚而呼吸不畅等，投上方共服21天，多年的头痛减轻，此后仅发作2次，但病症很轻。连服4个月头痛几乎全无。

验证：耿氏用上方（适当加量），5年来治疗慢性偏正头痛50余例，效果满意。并试用于三叉神经痛，效果亦很好。

病例：卜××，男，60岁，郝寨乡后岗村人。1985年5月10日就诊。自述7天前右侧面部出现短暂、阵发性闪电样剧痛，如刀割火燎，每次发作数秒至1分钟左右，1日内可发作多次，在村卫生所治疗无效，用药不详。根据典型发作症状，诊为三叉神经痛，经用清上蠲痛汤原方加量，两剂后基本痊愈，为巩固疗效，再服两剂，随访至今未复发。（耿录海，《新中医》，1987；（4）：封三。）

按：方中川芎、蔓荆子、菊花、细辛、羌活、防风，白芷皆为治头痛常用药，配独活、苍术祛风除湿，配干姜温经，大黄泻下祛瘀，配黄芩、麦冬清解上焦之热，诸药合用，祛风除湿，活血止痛，兼清上焦之热，故对慢性偏正头痛及三叉神经痛有良效。尤其适用于风湿兼上焦有热头痛患者。

6. 眩 晕

方名：大建中汤加味

来源：姜成才，《新中医》，1986；（5）：50

组成：人参、法半夏各6克，蜀椒、白术各9克，干姜12克，饴糖15克（烔化）。

用法：水煎分2次温服。

主治：眩晕（美尼尔氏综合症）。

疗效：病例：周××，女，30岁，教师，1984年5月17日初诊。患者于1个月前因感头晕、恶心、纳呆，自服藿香正气丸、上清丸等药，但疗效不显。3天前眩晕加剧，恶心呕吐。经神经科诊断为美尼尔氏综合症，服药罔效，而来诊。患者面色苍白，眩晕，如坐舟车，耳鸣，恶心呕吐，腹痛便稀，手足不温，舌胖嫩，苔白滑，脉沉弦弱。证属脾胃阳虚，寒湿中阻，清阳不升，浊阴不降之候。拟健运中阳，温化寒湿之法，以大建中汤加味，服五剂后，诸症消失，已康复上班。随访1年，未见复发。

验证：刘氏用上方验治一眩晕患者陈×，病近半年，经中西药治疗效微，而登门求治。表现为眩晕，如坐舟车，腹痛不食，恶心欲吐，手足不温，面色苍白，舌淡胖嫩，苔白滑，脉沉迟。经用上方如法治疗三剂显效，七剂痊愈，随访至今未见复发。（刘思惠等，《新中医》，1989；（1）：封三。）

按：大建中汤源于《金匱要略》，是一首建中补虚的名方，原为“心胸中大寒痛，呕不能饮食，腹中寒，上冲皮起，出见有头足，上下痛而不可触近”者而设。而眩晕一证，有风、火、痰、虚之别，上方所治眩晕是由脾胃阳虚，寒湿中阻，清阳不升，浊阴不降所致，绝不可不经辨证用此方治疗各种眩晕。

7. 失 眠

方名：半夏秫米汤

来源：熊永厚，《新中医》，1983；(11)：22。

组成：法半夏，薏苡仁各60克。

用法：浓煎睡前1次服。心脾两虚加党参，心阴不足加麦冬，痰热扰心加黄连，胃中不和加神曲。

主治：失眠（不寐）。

疗效：熊氏几年来用上方治疗失眠多例均收到满意效果。病例：荣××，女，42岁。1976年10月27日诊治。失眠5年，入睡困难，梦多，易惊醒。一夜至多能睡3~4个小时。形瘦神倦，心悸，口干舌燥，舌红少苔，脉细稍数。症属心阴不足，即以上方加麦冬60克，服药一剂，当夜能睡8个小时。续服三剂巩固疗效。

验证：简氏用上方验治6例失眠患者确有显效。例夏××，女，46岁，工人。1986年4月2日诊。失眠1年多，常每晚只能睡2~3个小时，且多梦，近因上晚班，白天更难入睡，神疲，面色无华，舌淡苔白腻，脉沉缓，予上方加党参30克，服三剂能熟睡5~6小时，再予三剂诸症消失。（简秀成，《新中医》，1988；(12)：封三。）

黄氏也用上方验治25例失眠患者（其中心脾亏虚13例，心阴不足6例，痰热扰心3例，胃中不和3例），病程最短3天，最长1年多，服药少则一剂，多则五剂，显效18例，好转7例，疗效甚为满意。（黄宗良，《新中医》，1984；(10)：封三。）

按：失眠一症，原因很多，思虑忧郁，劳倦过度，心脾血虚，胃气不和等皆可引起。熊氏认为不寐主要责之于胃，在辨证时纵有心脾亏虚、心阴不足、痰热内扰等表现也应以和胃为主，兼顾其它。故选用和胃主方半夏秫术汤。《本草纲目》载：半夏“治目不得瞑”；吴鞠通曰：“半夏逐痰饮而和胃”。现代药理研究证实法半夏对中枢神经有良好的镇静和安定作用。秫米为禾本科植物粟的种子，别名粟米、黄米。味甘微寒，有和胃、安眠、止泻等作用，因药房不备，可用薏苡仁代之。半夏重用60克，浓煎1次临睡服下，除当夜得深熟之睡眠外，未见其他不适。近几年在临床上用半夏60克者病例众多，未见1人有副作用。

8. 鼻 衄

方名：生藕

来源：名医类案。

组成：生藕一节，海巴少许。

用法：生藕一节、捣贴颅囟。更以海巴烧黑至存性为末，鹅管吹入鼻内。

主治：鼻衄。

疗效：邵村张教官患衄血多年，诸治不效且重，任流3昼夜不止，危甚。一道人用上法治疗，2~3次即止。

验证：笔者曾用此简便方法治愈20类鼻衄患者。病例：王××，鼻衄10余年，屡治不验，每因情绪激动或怒气丛生时鼻衄发作，伴头晕头痛，性情急躁易怒，舌红苔黄脉滑数。用上方4次，鼻衄即止。并嘱其常食鲜藕，以善其后。

(王汝新，惠民地区中医院)

按：鼻衄属中医“血证”范围，与肝、肺、胃关系密切，因热者据多。

鲜藕、藕节本属一物，且其功效有相似之处。《药性论》早就指出“捣汁主吐血不止，口鼻并治之”《本草纲目》“能止咳血、唾血、血淋、溺血、下血、血痢、血崩”。以此断言，鲜藕能止血无疑，且入肝、肺、胃经，肺开窍于鼻，故药可循经入鼻，以治鼻衄，又颅囟即颅息穴，属手少阳三焦经，生藕捣烂贴于此处，以降肝胆之火。本例患者，据脉证合参，属肝胆火旺无疑。证机相投，药证相符，用之使肝火得降，火降而不能升之，故衄血愈矣。且海巴味咸，性平，有毒，《本草纲目》载：“治鼻渊出脓血”用以辅之，可使鼻衄愈矣。

9. 支 气 管 炎

方名：款冬花饮

来源：徐永庭，《新中医》，1981；(3)：封三。

组成：炙款冬花9克，晶糖（冰糖）9克。

用法：开水冲泡，时时服之。

主治：支气管炎及外感引起的咳嗽。

疗效：徐氏单用上方或加入其他方剂，治疗支气管炎和感冒引起的咳嗽多例，有较好的止咳作用。病例：徐氏之母素有咯血史（支气管扩张症），1972年冬受寒复发咳嗽，服药日久无效。恐其久咳出血，即购炙款冬花30克，分成3份，用1份加冰糖约10克，冲泡开水一碗（约500毫升左右），嘱

其在1天内频频服完，第二天即咳嗽止。

验证：张氏之女，3岁，患支气管炎，常因感冒而发作，痰鸣吼咳，夜不安寐。经用上方一剂咳减，三剂告瘥。后多次用此方治疗咳嗽均获速效。本人认为再加入等量的紫苑、碧桃干则疗效更佳。（张雪峰，新中医，1989；（3）：封三。）

按：此方味甘不苦，确有良效，具有简、便、廉、验特点，尤适宜于老人及小儿咳嗽。

10. 慢性支气管炎

方名：豆浆水浸膏

来源：苗毅韧等，《新中医》，1987；（3）：30。

组成：黄豆浆水，苯甲酸。

用法：把黄豆浆水先急后慢火浓缩成浸膏状，加苯甲酸防腐，入瓶密封，避光干燥通风处存放。选肩中俞、肺俞、脾俞、肾俞，丰隆皆为双穴，命门。喘息型以定喘易肩中俞。小儿以大椎穴易肩中俞或定喘。以2×1.5厘米薄牛皮纸一块，取黄豆般大小浸膏涂于纸上，照穴贴之，用两条胶布固定。24小时换药，重者可日换药2次。15天为一疗程，休7天，行第二疗程。

主治：慢性支气管炎（以咳痰喘为主症）经X线胸透，排除其他类似疾病）。

疗效：苗氏等报道采用本法治疗慢性支气管炎232例，疗效满意。单纯型116例，其中控制83例，显效8例，好转18例，无效7例，总有效率占94%；喘息型50例，其中控制42

例，显效2例，好转6例，肺气肿61例，其中控制15例，显效15例，好转28例，无效3例；支哮5例，其中控制2例，显效2例，转好1例。病例：薛××，女，58岁。1983年3月30日初诊，罹患慢性支气管炎10年。近4年长年咳嗽，走坡或从事轻度体力劳动时气喘加重。近因感冒病发作，咳喘早晚为著，白粘痰日吐达150毫升之多，滞喉不爽。经胸透诊为慢性支气管炎单纯型急性发作期。当日贴药1次，晚上即见咳喘显著减轻，吐痰爽利。每日贴1次，5次后夜咳止，日吐痰约30毫升。连治3个疗程，1983年6月与1984年11月胸片相比较，肺纹理仍增粗，但边沿清楚，炎症明显好转。随访约1年多，未见咳喘发作。

验证：刘氏用上方验治138例慢性支气管炎患者，确有效验。病例：刘××，女，47岁。患慢性支气管炎17年，每因天气变化诱发咳嗽，喘息不止。必服“舒喘灵”，方能缓解，自接受上法治疗后，停用西药，经治7天，或遇天气变化，亦不感气紧喘息。（刘少文。新中医，1987；（12）：49。）

按：慢性支气管炎是一种常见病、多发病，该法方法简便，疗效满意，且无痛苦，很值得推广应用。关于作用机理，有待于进一步探讨。

11. 支 气 管 哮 喘

方名：宁肺丸

来源：高俊彦，《新中医》，1979；（3）：56。

组成：海藻150克，昆布150克，北沙参150克，百合90克，党参60克，黄芪60克，生地90克，玄参90克，枇杷叶60克，

半夏60克,茯苓90克,陈皮60克,旋复花45克,蛤粉150克,瓜蒌仁450克,黄芩90克,麻黄45克,百部60克,杏仁60克,桔梗60克,钩藤90克,萎皮60克,马兜铃60克,白果100粒,小青蛙(干品)300克,紫河车90克。(1号宁肺丸)。

用法:上药共为细末,炼蜜为丸。每次6~9克,每日2~3次,连服1000~4000克。

主治:成年人及小儿支气管哮喘病久体弱者。

疗效:高氏自1969年自制宁肺丸,治疗支气管哮喘数百例,随访2~5年患者40例,病情多数获得改善,不少病例多年未见复发。病例:陈××,男,45岁。患支气管哮喘5年。于1970年9月给1号宁肺丸1500克分服。服药后1年内未发作。翌年起每年秋季给药1500克分服,连续3年。至1977年11月追访,7年未见复发。

验证:韩氏用上方验治一例患有16年哮喘的病人。病例:何××,女,17岁,农民,1983年4月来诊。其母代诉:1岁时起病常发作,气候变化时更严重,喘声不断,大汗淋漓,口唇紫黯。历年经中西医治疗效不显,发育不良,17岁尚未来月经。见面色无光,消瘦,肌肤枯槁,语声低微,舌质胖淡,苔白,脉沉细,唯觉肺脉独盛,即处以宁肺丸1号方,炼蜜为丸,每日服2次,坚持服药。从去年6月间起,服药至今年6月,症状大为减轻,只偶发哮喘,余症渐次消除,神焕肌腴,形貌大异,经水适来患者异常高兴。(韩济舟.新中医,1984,(12):56。)

按:哮喘的原因很多,治病的方药也不少。上方主要根据“脾为生痰之源,肺为贮痰之器及肺为肾之母,肺病日久,肾必受累等理论,治肺为主,兼顾脾肾。组成药品较

多，主要以清肺化痰，止咳平喘，健脾滋肾等药组成。小青蛙具滋补强壮作用，常用来治疗跌打损伤、小儿哮喘、疳证等病证。制作干品方法：剖腹又肠杂，蒸熟晒干即可。

12. 毛细支气管炎

方名：桃花散

来源：冯秀兰，《新中医》，1988；（1）：33。

组成：石膏9克，川贝15克，朱砂3克。

用法：上药分别研细过100目筛，然后混合均匀备用。

1岁以内小儿内服每次0.25~0.3克，2~3岁0.5~0.75克，4~5岁1克，6岁以上1.5~2克，日3次。

主治：毛细支气管炎。

疗效：冯氏自1982年用上方治疗2岁以内的小儿毛细支气管炎150例。其中显效135例，低效15例。显效率90%以上。病例：陈×，女，5个月，1982年11月15日入院就诊，憋喘3天。查体：体温38.5℃，脉搏150次/分，呼吸60次/分，呼吸急促，口周发绀，面色发灰，双肺可闻及哮鸣音，肝肋下2厘米。入院后用青霉素抗感染、氨茶碱654-2解支气管痉挛及吸氧、镇静等措施治疗。但仍烦躁不安，咳喘加重。经口服桃花散0.25克，日3次，服药第二天上午症缓解，肺部哮鸣音明显减少，第五天全部消失，第七天痊愈出院。

验证：魏氏用上方验证10余例小儿支气管炎均有效。病例：张×，男，5岁，1988年3月1日就诊。初患麻疹后咳嗽伴低热，面青唇紫，两肺可闻及干湿罗音，X线检查两肺

门阴影增大，诊为小儿支气管炎，曾肌注链霉素，口服咳必清等，无效后改此方而后愈。

按：方中石膏为清热要药，对于肺热咳喘有较强作用，配伍川贝有润肺止咳化痰之功，加朱砂能镇静安神，防止热极抽风，三药研末口服方便，无刺激性气味，婴儿服用可把药粉放在乳头上吮吸。由病毒引起的毛细支气管炎应用抗菌素无效者，可应用此方。

13. 咳 嗽

方名：姜汁蜂蜜饮

来源：谢卫，《新中医》，1987；（2）：27。

组成：生姜30~50克，蜂蜜适量。

用法：将生姜捣烂取汁为1份，再加蜂蜜4份，混匀于碗中，再置锅内隔水蒸热约10分钟，早晚两次分服（上为成人1日量，儿童酌减），连用2天。

主治：咳嗽（风寒或虚寒咳嗽，无论新久）。

疗效：谢氏用上方治疗咳嗽20余例皆愈。病例：郑×，女，22岁。头痛鼻塞流清涕，咳嗽，咯少量白稀痰，咽痒数天，检查仅见咽部轻微充血，余无特殊，经对症处理，诸症减，唯咳嗽咳痰加重，入夜更甚，用多种抗菌素、止咳药治疗均无效，后用上法，当晚睡前服1次咳嗽顿减，夜寐安宁。次日再服1次，咳止痰消。

验证：何氏用上方验治多例疗效颇佳。病例：刘××，男，32岁，军人，反复咳嗽时轻时重已2年，干咳少痰，咽喉发痒且有异物感，夜间及清晨起床时咳嗽加重，接连不

断，且感胸闷气闭，服中西药无效，1987年5月24日应用上方，连服2天咳嗽大减，又服3天竟获痊愈，至今未复发。

(何克哲，《新中医》，1988；(5)：封三。)

按：咳嗽一症，原因甚多，上方仅适用于风寒或虚寒性咳嗽，以咳嗽咯痰稀白，或伴恶寒、咽痒，或咳嗽夜甚，口不渴等症为宜。生姜汁能解表温肺，化痰止咳；蜂蜜味甘性平，有滋养调肺止咳之功。二药合用，辛散甘缓，共奏散寒补中，化痰止咳之效。

14. 百 日 咳

方名：顿咳汤

来源：彭家礼，《北京中医学院学报》，1983；(4)：33。

组成：蜜炙杷叶15克，白芥子25克，若参15克，麻黄7.5克，大黄2.5~5克。

用法：前三味用水350毫升煮沸后，加入大黄再煎至45毫升，此为1周岁小儿1日量，分3次温服，其他年龄可酌情增减。

主治：百日咳。

疗效：彭氏报到用上方治疗本病224例，疗效显著。病例：史××，男，3岁。患儿三周前因感冒风寒而咳嗽，曾用抗菌素及治疗咳嗽药反见加重，呈阵发性、痉挛性，并伴有“鸟啼样”吸气声，情绪激动而诱发，伴呕吐粘涎及胃内容物，偶有鼻衄，大便干燥，面色无华，两眼睑浮肿。西医诊断为百日咳，经用顿咳汤三剂咳减大半，吐衄消失，大便泻数次；继投顿咳汤三剂，大黄减量，再诊仅微有咳痰；又

投顿咳汤二剂，减大黄加杏仁5克，隔日一剂，病告愈。

验证：笔者用上方验治近30例，疗效满意病例：郭××，女，4岁，咳嗽半个月，呈阵发性痉挛性发作，伴有“鸡鸣”样吸气音，每遇寒冷及情绪刺激等诱发，呕吐、痰涎及胃内容物，有时鼻衄，双眼结膜下出血，面色晦暗，两眼睑浮肿，大便干燥。经西医诊断为百日咳。用顿咳汤两剂后，未再鼻衄，咳嗽减轻，五剂后咳嗽大减，大便稀。继投顿咳汤三剂，大黄减量，咳嗽基本控制，眼结膜下出血由红转黑。又投顿咳汤减大黄加百合6克三剂，隔日一剂，病告痊愈。（朱培桢，博兴县第二人民医院。）

按：百日咳属祖国医学中的惊咳证，多因感受时邪风寒，内伏热痰，表里合邪，搏结于气道使肺气肿逆所致。治应以宣肺气，豁痰清热，解痉止咳为法。本方麻黄与杷叶能使肺复宣发肃降之职；白芥子善祛酸痰，并能镇咳止痉。大黄通大肠，腑气通肺气自降、痰咳自平大黄与白芥子同用，又有下痰气，使之大便而去之功。苦参苦寒，清热解毒，并可制麻黄、白芥子之热弊。故此方有宣降肺气，豁痰清热，解痉止咳之功。对百日咳痉咳期每每奏效。

15. 顽咳症

方名：治顽咳方

来源：迟良义，《医学科普》，1990，（6）。

组成：通宣理肺丸（济南中药厂），云南白药（云南白药厂）。

用法：通宣理肺丸2丸，用温水烱化成药液，内加云南

白药0.5克,1次服下,首次加服保险子一枚。每日2~3次。

主治:顽咳症。

疗效:迟氏报道用上方治疗23例顽咳症,取得满意效果。一般1~2天见效,5~8天可痊愈。

验证:笔者持上方治疗18例因感冒后引起的顽咳不止,疗效显著,多用药数天痊愈。病例:杨××,司机,1991年元月16日就诊:感冒一周后,咳嗽频作,昼轻夜重,咽有痒感,但无发热及呼吸困难。曾用多种抗菌素,镇咳药达1个多月无效。更服本方2天咳减,一周后顽咳消失,诸证悉平。

按:“顽咳”一证,一般指咳嗽在半个月以上,经多种方法治疗效果不明显者。其病因多由外感风寒,风热等引起。失治误治,邪郁于肺,肺气不宣,久则气滞血瘀,瘀阻肺络;或因肺气素虚,宣降失司,复感外邪,肺气郁闭致久咳不止。通宣理肺丸方中苏叶、麻黄、前胡宣肺达表;杏仁、桔梗、枳壳宣降肺气;陈皮,半夏,茯苓,甘草理气化痰止咳。黄芩一味,清肺热共收发表宣化之功;表解痰化肺气畅调,诸证自愈。云南白药,具有活血化瘀,止血止痛等功效。诊对“久病必瘀”之特点,依“活血以行气,化瘀能行滞”,故用通宣理肺丸加云南白药治疗顽咳收到满意效果。此法简便易行,疗效满意,便于临床推广应用。(许国华,博兴县中医院。)

16. 病毒性心肌炎

方名:病毒性心肌炎基本方

来源：孙明异等，《中医杂志》，1986；（9）：22。

组成：党参30克，黄芪50克，白术20克，炙甘草5克，麦冬15～30克，五味子10～20克，桂枝10～25克，生地30克。

用法：水煎早晚2次分服。胸痛者加丹参30克，桃仁15克，红花15克，降香15克；下肢浮肿者加制附子15克，肉桂10～20克，苡仁40克，车前子15～20克（包）；周身肌肉关节疼痛者加防己20克，细辛5～10克。

主治：病毒性心肌炎。

疗效：孙氏等以上方为基本方加减治疗该病21例，疗效较好。病例：曲××，男，19岁。平素易患外感，1976年4月外感后数日，突感心悸、胸闷，劳累后加重。急至医院检查，经作心电图，示室性并行心律，室性融合波，ST段下移。经西医疗疗半个月，症状缓解，心电图示室性融合波消失。但一周后又复发，心电图与症状同前，后到中医科治疗。证见：心悸胸闷，气短乏力，时头晕，舌有瘀斑、尖赤、体稍胖，苔薄黄，咽峡充血，脉促滑稍弱，漏脉13次/分。证属心阳虚，心络瘀阻，热毒内蕴，治以益气活血、清热解毒。药用：黄芪50克，党参40克，丹参30克，红花20克，川芎15克，苦参20克，茯苓25克，水煎，早晚各1次。连用1个多月，症状减轻，咽部已无充血，脉转见细滑无力而结，心电图示室性早搏4次/分。由此看来，热毒已清，余邪未尽，气阴两伤，以上方加减，继服15剂，症状缓解，早搏消失，再进七剂以巩固疗效。随访至1980年10月，未复发。

验证：李氏用上方验治病毒性心肌炎，竟获良效。病例：张某，女，45岁，1986年8月28日住院。查体：体温

37.6℃，血沉80毫米/小时，心律不齐，期前收缩8次/分，心电图示ST及T改变。诊为病毒性心肌炎，予青霉素80万单位肌注每日3次，能量合剂、板蓝根注射液及激素等药物治疗38天无明显疗效。1986年10月10日，患者来余处就诊：患者体胖，面色晄白，心悸，胸闷心慌，睡眠差，腹胀纳差，肌肉、关节痛，舌尖红，苔黄略腻，脉数，结代。嘱停服一切西药。治以益气通阳为主，以上方加减（党参30克，黄芪30克，白术20克，麦冬15克，五味子15克，苦参20克，桂枝10克，炙甘草6克，板蓝根30克，薏仁30克，白芍15克，谷芽30克，水煎，每日一剂，分3次服。四剂后，自觉胸闷、心悸减轻。16剂后，诸症消失，心电图ST及T正常，血沉20毫米/小时，再服10剂以固疗效。（李孝年，《中医杂志》，1987；（8）：67。）

按：病毒性心肌炎为临床上常见病，治疗颇感棘手。孙氏等认为该病以心肺气阴两虚为本，以瘟毒内侵为标，因情志、疲劳，外感等因素而诱发。方以党参、黄芪、白术、炙甘草补益心肺之气，用麦冬、生地、五味子滋补心肺之阴，桂枝宣通阳气，共奏益气通阳之功。随证酌加清热解毒、活血祛瘀等药以增强疗效。

17. 心悸脉结

方名：补阳还五汤加减

来源：王泽银，《新中医》，1985；（11）：41。

组成：黄芪50克，赤芍、当归、酸枣仁、丹皮、茯苓、白芍各10克，川芎、桃仁各8克，红花6克。

用法：水煎服。

主治：心悸（脉结）。

疗效：王氏用上方治疗心悸脉结收效良好。病例：王××，男，46岁，1983年元月6日初诊。自诉心慌气短，心胸不舒，病程已2年多，稍劳累则症状加重，伴头晕失眠，食少倦怠，小便微黄，大便2日1次，口不渴，面色淡白，精神不振，舌质暗红、边尖有瘀点，苔薄黄，脉跳5至7次停跳1次，曾服多种中西药疗效不显。改用炙甘草汤服五剂后症状依然。细审之，前方不效，原因是只注意其气阴之虚，忽视血瘀之实。故改用上方服五剂后，心慌气短渐平，心胸稍舒，睡眠好转，精神亦振，舌质同前，脉跳12~17次一停药获初效，上方桃仁增至10克继服20剂，症状基本消失。

验证：王氏1985年10月收治1心悸患者，生病半年多易数医，用中西药罔效，经上方如法稍加味，二剂显效，六剂收功。（王克庆，《新中医》1986；（5）：54。）

按：心悸一证，以虚证多见，虚实夹杂者亦不少。虚者多用炙甘草汤等治疗，而上方以虚中夹实者为宜。方中重用黄芪以补气，当归、赤芍、桃仁、红花、川芎、丹皮活血通经，佐以枣仁、白芍、茯苓养心血，宁心神，诸药合用，使心气旺盛，血脉流畅，则结代除而心悸愈。

18. 冠心病

方名：三参菊花饮

来源：谢建裕，《新中医》，1987；（4）：5。

组成：丹参、党参、参三七、白菊花。

用法：其用量按心悸、闷、痛三大证的轻重并结合苔脉及血压，分别侧重。以悸、闷为主，重用党参、白菊花；以痛为主，重用丹参三七；血压偏高者，重菊花轻党参；痛证不著，可去参三七。上药以沸水泡服，十分简便。

主治：胸痹（冠心病、肺心病等）。以心悸、胸闷、疼痛为主症。

疗效：谢氏报道用上方治疗89例以悸、闷、痛为主症的心病患者，收到满意效果。89例中冠心病74例（伴高血压23例，风心病9例，病毒性心肌炎4例、肺心病2例。病情最短9个月，最长30年。治愈12例，有效69例，无效8例。药后缓解症状最短7天，最长1个多月。病例：泮××，男，61岁，患冠心病10多年，伴有高血压病。经常心悸、胸闷、睡眠欠差，劳累后心前区可出现隐痛闷窒及针刺感，因长期服用西药症状未见明显改善，后转服中药。服本饮（赤丹参30克，党参10克，三七粉2克冲服，白菊花15克），每日一剂，以沸水泡10分钟后代茶饮，服至质淡，服药7天后，患者睡眠明显改善、悸闷痛消失。续服2个多月后，复查心电图示正常范围，原饮去三七粉，间服约1年，血压亦转正常，现已3年多，随访一直稳定。

验证：杨氏用上方验治9例（其中冠心病5例，风心病1例，肺心病3例），疗效确切。病例：刘××，男，65岁。患冠心病15年，有高血压病史10年，血压一般在23~27/14~16kPa。经常心悸、胸闷，活动劳累后心前区可出现隐痛及针刺感。曾长期服西药症状未见明显改善，遂请吾诊治，嘱服三参菊花饮（丹参30克，菊花15克，党参10克，三七粉2克冲服），每日一剂以白开水沏泡10分钟后代茶饮，

服至质淡，服5天后，症状明显改善，10天后悸闷消失，连服1个月，心电图提示正常。现已2年多，一直稳定。(杨德明，1991；(1)：50。)

按：胸痹是指胸部闷痛，甚则胸痛彻背，短气，心悸等为主症的一种疾病，多见于西医冠心病、肺心病，高心病等。方中丹参三七活血祛瘀，是中西医公认的治心脏病的专药，党参补脾益气，善治气短心悸，菊花平肝明目，四药配用代茶饮，疗效确切，使用方便，值得推广。

19. 胃 脘 痛

方名：百合汤

来源：步玉如等，《中医杂志》，1982；(8)：16。

组成：百合30克，乌药9克。

用法：用水2杯，煎七分服。

主治：胃脘痛（属气郁化火，或热积中脘服热药无效或增剧者）。

疗效：步氏等数十年来用上方治疗胃脘痛，每获良效。

病例：王某，男，40岁，胃脘灼痛，吞酸，口苦，便干，舌苔黄，脉滑数。服苦寒清热之剂，病反复不愈，后改用百合汤，服四剂后，热痛基本消失，连续服数次获痊愈。

验证：唐氏用上方验治于临床，颇有疗效。病例：于××，女，29岁，工人，1982年10月19日初诊。胃脘灼热刺痛20年左右，痛无一定规律，大便常偏稀，噎气呃逆间有发作，经治疗时好时差，未能根治。查其舌红无苔，右脉沉软左脉沉细软微滑，遂按气郁化火，中热阴伤胃痛，以百合汤

加味（百合30克，乌药12克，白蒺藜15克，川楝子10克，白芍15克，炙甘草10克），服两剂灼痛若失，便稀噫呃亦瘥，继服四剂，至今随访旧恙未作。（唐宗儒，《中医杂志》，1983；（7）：79。）

按：胃痛属气郁偏寒者多见，属阴虚或偏热者也不少见。方中百合味甘平，《神农本草经》中载：“主邪气腹胀心痛”。且甘润微寒，兼能清热。乌药辛温行气止痛，《本草从新》谓其能“疏胸腹邪逆之气，一切病之属气者皆可治”。两药一凉一温，柔中有刚，润而不滞，故对胃脘痛属气郁化火之热痛为最适宜。

20. 嘈 杂

方名：加味小陷胸汤

来源：李克绍，《山东中医杂志》，1982；（1）：42。

组成：黄连9克，半夏6克，瓜蒌半个，枳实3克，栀子3克。

用法：水煎服。

主治：嘈杂痞胀。

疗效：李克绍教授用上方治疗痰火嘈杂兼觉痞胀的患者，每收良效。

验证：本人于今年2月，突患胃肠炎。症见腹痛，腹胀，溏便，每天大便5~6次，入夜尤甚。先后服黄连素、胃友、普鲁苯辛等药物，均无效，经用李克绍教授书中所列小陷胸汤，稍事加减，服二剂后，迁延月余的胃肠病豁然愈。（何锐，《山东中医杂志》，1986；（5）：45。）

按：“嘈杂”是胃肠病中一个症状。是形容胃中像发酵一般，懊恼不宁，有难以说清的感觉。还可伴有胀满、痞硬、嗳气、恶心等症状。上方所治嘈杂是因痰火郁滞胃脘所致。方中用黄连、栀子清热，以半夏、瓜蒌消痰，以枳实消痞散满。也可根据病情酌情加减。

21. 消化道溃疡

方名：胃散一号

来源：梁乃津，《新中医》，1982；(5)：11。

组成：延胡1000克，海螵蛸 2000 克，五灵脂 600 克。

用法：上三味共研成粉末，每次 3 克，温开水送下，1 日 3 次。

主治：消化道溃疡（胃脘痛，胃酸多或有反酸者）。

疗效：上方是广东省著名老中医梁乃津治疗胃脘痛，胃酸偏高，反酸或有反酸史的效方，经临床应用效果显著。

验证：俞氏用上方验治十二指肠球部溃疡效果良好。病例：李××，男，49岁，工人，患十二指肠球部溃疡10多年，经常发作，疼痛缠绵不休，伴嗳气、泛酸、纳差。经用各种制酸治胃药均无效，经用上方当日疼痛缓解，3日消失，以后痛作服用俱有效。（俞瑜等，《新中医》，1990；(10)：56）。

按：延胡活血行气，散瘀止痛，所含成分延胡乙素有良好的镇痛作用；五灵脂活血散瘀止痛，尤善治胃与十二指肠溃疡病出血疼痛；海螵蛸也叫乌贼骨收敛止血，制酸止痛专用于胃酸过多反酸，三药合用具有良好的制酸止血，散瘀止痛作用。

22. 消化道溃疡

方名：重楼煲猪肚

来源：张玉其，《新中医》，1986；(2)：6。

组成：重楼20克，新鲜猪肚1个。

用法：将重楼切碎，用冷水先浸透，塞入洗净猪肚内，然后将猪肚两端扎紧。放入煲内加2500毫升的清水，并加适量食盐，文火慢煲至约1500毫升，将猪肚捞起，倒出药渣。把猪肚切成片状，再放入煲内，待沸后便可分次服食汤肉。每隔4天一剂，一般服三剂，严重者可服四~五剂。

主治：消化道溃疡。

疗效：张氏5年多来用上方治疗本病25例，疗效满意。

病例：余××，男，28岁，农民。因患胃脘痛多年，经X线钡餐检查，诊为十二指肠球部溃疡。曾服中西药4年多，均未获效。经用上方二剂后，疼痛消失。为巩固疗效，嘱其每隔一周服一剂，连服三剂。半年后，X线钡透检查未见溃疡病灶。迄今未见复发。

验证：曹氏用上方验治13例，疗效甚佳。病例：陈××，男，43岁，干部，患胃脘痛5年，有时大便色黑，伴食欲不振，神疲乏力等，经钡餐检查，诊为“十二指肠球部溃疡”，曾服中西药治疗，疗效不佳。用上方四剂后痛解，连服半月诸症消失。(曹述文，《新中医》，1988；(12)：封三。)

倪氏等用上方验治胃及十二指肠球部溃疡7例，疗效甚佳。(倪健锁等，《新中医》，1987；(8)：封三。)

按：重楼又称蚤休，七叶一枝花，味苦性寒，有清热解

毒，消肿散瘀，镇静镇痛等作用；猪肚能补虚损健脾胃，取其以形治形之意，合用既能增强消炎镇痛，消肿散瘀之效，加速溃疡愈合。并且制法简单，经济实惠，易为患者接受。

23. 胃及十二指肠溃疡

方名：白芷甘草汤

来源：张甫圣，《山东中医杂志》，1982；(3):165。

组成：白芷30~60克，甘草15~30克。

用法：水煎服。胃部冷痛，喜得温按，进食痛减，舌淡苔白，脉沉迟，属脾胃虚寒者，加桂枝9克，白芍18克；胃部胀痛，连及两胁噎气稍舒，舌苔薄白，脉弦，属肝气犯胃者，加香附、柴胡、白芍各9克；胃部刺痛，入夜尤甚，舌暗有瘀血点，脉涩，属瘀血阻滞者，加五灵脂，生蒲黄各9克，丹参15克；胃酸过多者，加乌贼骨30克。

主治：胃、十二指肠溃疡和慢性胃炎所致的胃痛。

疗效：张氏用上方加味治疗40例胃及十二指肠溃疡和慢性胃炎所致的胃痛，有良好止痛作用，尤其对十二指肠溃疡所致的较剧烈胃痛，疗效最佳。

验证：孟氏用上方验治于临床证实有效。病例：朱××，男，8岁，因腹痛时发而来诊，患者曾做过肝功、大小便、脑电图等检查，未见异常。然腹痛时发时止，痛无定时，每次发作呈昏迷状态，肢冷头面汗出，约半小时自行缓解，平素无异常表现，脉弦紧，舌淡苔薄，投白芷甘草汤加味（白芷25克，甘草15克，川楝子4.5克，元胡6克，白术9克，生白芍9克，清半夏6克，乌梅6克），服二剂后，发作时间缩

短，疼痛减轻，继服三剂，腹痛奇愈，随访半年，未见复发。(孟祥才，《山东中医杂志》，1983；(6):65。)

按：白芷味辛性温，有祛风止痛、消肿排脓、除湿止带等功效，故临床上多习惯用于治疗头痛、牙痛、痈肿及带下等疾。《滇南本草》载：“白芷能止胃冷、腹痛、寒痛”。甘草补脾益气、缓急止痛，二药合用则有良好止痛作用。二药用量较大，经张氏应用，未见明显的不良反应，而白芷用量少于30克，往往影响疗效。

24. 各种呕吐

方名：止呕验方

来源：陈尚书等，《新中医》，1984；(12):28。

组成：粳米20~30克（炒黄），煨姜15~20克（将生姜从中剖开放入少量食盐，用湿纸包裹煨熟），蜂蜜30克（用纱布过滤），食盐1~2克（炒爆为宜）。

用法：先将炒好的粳米放入器皿中加水250毫升，用文火煮至米粒开花，将煨姜切成姜末伴煮至稀粥样，再加入炒好的食盐，使稀粥有点咸味，将蜂蜜加入调匀，即可服用。让患者先进3~5匙，待10分钟后，再徐徐服之，服药后一般半小时许呕吐即止。

主治：各种呕吐。

疗效：陈氏等报道用上方治疗各种呕吐20余例，疗效较好。病例：颜××，男，60岁，农民。素患哮喘，每次发病则呕吐频繁。先为食物残渣，后为大量涎沫及胃液，食入即吐。用鲁米那、氯丙嗪等药均无效，改用上方而止呕效果

显著。

验证：富氏用“止呕验方”临床验治5例，疗效确切。
(富彦相，《新中医》，1991；(2)：封三。)

按：呕吐是临床常见病症，上方药味简单，收效理想，
做成药粥，便于服用，遇此症不妨一试。

25. 神经性呕吐

方名：吴茱萸汤加味

来源：张俊杰，《新中医》，1978；(1)：31。

组成：吴茱萸9克，太子参15克，生姜9克，大枣5
枚，茯苓15克，半夏15克。

用法：水煎服，日一剂。

主治：神经性呕吐（功能性呕吐）。

疗效：张氏以吴茱萸汤加味治疗神经性呕吐多例，均收到较满意的疗效。病例：运××，女，25岁。间断呕吐1年多。患者于1年前开始呕吐，最初症状较轻，经用上方三剂症除，再服二剂以巩固疗效。1年后随访，一直未发作。

验证：蒲氏用上方验治神经性呕吐百余例，均获良效。
病例：柴××，女38岁，农民。间断呕吐3年多，四处求医，打针吃药均不见效。经试用上方，服药三剂症除，半年后随访，一直未发作。(蒲永庆，《新中医》，1989；(1)：封三。)

按：吴茱萸汤是《伤寒论》中的方剂，主要用治肝胃虚寒，浊阴上逆所致的胃痛或头痛，痛时欲吐，或干呕，或呕吐涎沫等症。神经性呕吐又称功能性呕吐，虽无器质性病变，但呕吐时好时犯，常以多种刺激而诱发，往往经久不

愈。用具有温肝暖胃降逆止呕作用的吴茱萸汤再加止呕圣药半夏和健脾渗湿的茯苓，止呕作用更为显著。方中用参可根据病情而定，若气虚甚者以用人参或党参为好，若气阴两伤则以用太子参为佳。

26. 胃 出 血

方名：三七郁金汤

来源：梁繁荣，《中医杂志》，1982；(12)：14。

组成：三七7~10克，郁金10克，熟大黄10克，牛膝10克。

用法：水煎服，每日一剂，每剂水煎2次分服。若虚脱加入人参，呕逆暖气加代赭石，胃痛甚而且胀者，加檀香或降香，痛连两胁加川楝、白芍，懊恼烦满加炒山栀，胃脘虚冷加砂仁，胃阴虚，舌光无苔加石斛。

主治：胃出血，以呕血、黑便为主症。

疗效：上方是陈松筠老中医治胃出血的经验方，经梁氏临床观察20余例，疗效颇佳。病例：胡××，男，60岁。有慢性胃炎病史已5年，2天前因劳累而突然呕血。先夹有食物残渣，后全为鲜血，大便色黑结硬，兼见头晕、汗出、口苦、乏力。因服中西药均无效，前来就诊。大便隐血试验：强阳性；血色素：6克/100毫升，脉象小而涩，舌质稍紫，舌苔薄黄。诊断为慢性胃炎合并出血。即予上方加茅根15克。服药一剂，输血300毫升，呕血立止。守方连服五剂，隐血试验转为阴性。后调理月余，诸恙悉退而愈。

验证：王氏用上方重复验治3例均获效。例谢××，

男，47岁，本厂职工。自述近10多天来，胃脘部阵发性疼痛（既往有胃溃疡病史），3天前晨起解黑便，经化验检查：大便潜血（++）。即给予静注止血敏、肌注安络血，口服维生素K等治疗。次日仍解黑便数次，至第三日上症仍未缓解，要求中医治疗。患者胃脘部隐痛不适，口苦，小便黄，舌红苔微黄腻，脉弦滑数。拟止血祛瘀，疏肝理脾佐以清化为治，以上方加减（三七10克，白芨10克（研末冲服），郁金10克，熟大黄10克，牛膝10克，川厚朴10克，炒山栀10克，藿香8克，茯苓12克。二剂，水煎分服，服一剂后，次日患者告知，昨夜解出黑色稀便甚多，今晨又解大便一次但色已转黄，且胃脘痛诸症亦大减，继以调理肝脾而瘥。（王志军，《中医杂志》，1984；（7）：80。）

按：胃出血多见于消化道溃疡，以吐血便血为主症，是属急腹症之一。方中三七既能散瘀止血；又能消肿定痛；郁金行气祛瘀，凉血止血；熟大黄泻下解毒作用减，收敛止血功效增；牛膝引热下行，诸药合用有凉血止血，祛瘀收敛等功效，用治胃出血有良效，可使部分病人免于手术之苦。

27. 出 血 症

方名：秘红丹

来源：石向明，《山东中医》，1982；（6）：363。

组成：大黄细末3克，油肉桂3克，代赭石细末20克。

用法：将大黄、肉桂细末和匀，用代赭石细末煎汤送服。

主治：出血症（吐血、衄血、肛裂出血等）。

疗效：石氏用此方治疗吐衄血及咳血、便血多例，屡试屡验。一般1~3次即愈。

验证：孙氏用上方治疗鼻衄、肛裂出血各两例，效果极佳。病例：丁××，男，大便带血鲜红、肛门痛半年多，经用高锰酸钾坐浴，外敷依克度软膏，疗效欠佳。检查肛门，胸膝位于十点至一点处有皮肤粘膜小裂口5~6条，有鲜血外渗，予上方服一剂后血止，服三剂后来医院检查，肛门裂口愈合，随访2月未再复发。（孙世福，《山东中医》，1983，（6）：65。）

按：秘红丹是张锡纯《医学衷中参西录》的方。经反复验证对各种出血症均有良效。方中大黄苦寒沉降，除有泻下通便作用外，还能清泻血分实热，外用或内服对外出血和内出血都有明显止血作用；代赭石苦寒体重，有平肝降逆，凉血止血之功，《医学衷中参西录》曰：“治吐衄之证，当以降胃为主，而降胃之药，实以赭石为最效”，又曰：“无论吐衄之证，种种病因不同，疏方皆以赭石为主，而随证制宜，佐以相当之药品，吐衄未有不愈者”；肉桂辛热与大黄、赭石反佐配伍，以防苦寒太过伤脾胃。综合此方以治吐衄及血热妄行引起的各种出血症为最宜。

28. 各种出血症

方名：童便饮

来源：胡建华，《新中医》，1988；（3）：36。

组成：7岁以下健康男孩的新鲜中段小便100毫升，陈醋10ml，白糖适量。

用法：小便100毫升，兑陈醋10毫升加白糖适量炖温顿服，1日服2~4次，血止后减半量巩固1~2天。

主治：各种出血症。

疗效：胡氏自1981年用上方治38例出血症（上消化道出血8例，活动性肺结核咯血2例，支气管扩张症咯血2例，急性白血病齿衄1例，非外伤性鼻出血25例），治愈36例，无效2例，治愈率94.7%。止血时间一般首次即能控制血势，平均1.9天可全愈，临床症状也获改善。病例：杨××，女，39岁，干部，1982年元月24日入院治疗，由于上消化道大出血收入外科病房。入院后经用脑垂体后叶素、6-氨基己酸、止血芳酸、正肾素等药，输全血6次共计2400毫升，仍不能止住血。于2月8日邀余会诊，经用童便100毫升，兑陈醋10毫升，加白糖适量一次服下，1日服3次，连用2天，大便隐血转阴。

验证：上方经兰氏临床验证，确有疗效。病例：王××，男，81岁，农民，咳嗽痰血及吐血约一碗，血色鲜红，皮肤有斑点，大便略干燥，舌红少苔，脉弦紧。如法服用上方4次，辅以中药一剂告愈，药用：生地10克，白芍、大黄各9克，丹皮、柴胡、黄芩、血余炭（冲）、白芨各6克，甘草3克，阿胶（烊化冲）12克。（兰友明，《新中医》，1988；（10）：56。）

按：童便味咸性寒，能清热泻火。《本草衍义补遗》曰“降火最速”。《本草纲目》谓“人尿滋阴降火甚速”。《名医别录》说童便有“止血消瘀”之功。也未发现毒副作用。至于兑陈醋，加白糖，主要是为了矫味。醋具有防腐解毒之功，酸主收敛而有助于童便止血。现代分析其成分无毒，临床应用安全，故对血热及瘀血等引起的出血均有疗效。

29. 阴 虚 胁 痛

方名：加味一贯煎

来源：章真如，《新中医》，1984；(2)：25。

组成：生地、枸杞子、麦冬、当归、川楝子、白芍、郁金各10克，北沙参15克。

用法：水煎服。胁痛较甚者加延胡索，腹胀者加木香、青皮，失眠者加珍珠母、夜交藤，舌质紫黯加丹参、赤芍。

主治：阴虚胁痛。

疗效：章氏用上方治疗胁痛属阴虚者多例，效果满意。

病例：马××，男，54岁。胁痛反复发作3年。1960年患肝炎，经治疗后基本痊愈，但在工作劳累、气候异常、情志失宁的情况下，胁痛时有发作。近3年来发作较频，甚至影响工作和睡眠，曾服不少保肝药及疏肝理气中药未见效，且疼痛不断增剧，精神负担颇重，渐见睡眠不安，纳谷不香，口干苦，舌质红，苔薄黄，舌中有裂纹，脉弦细。给予加味一贯煎治疗，服药共20剂，胁痛消失。

验证：虞氏用上方验治1例阴虚胁痛患者确有疗效。病例：曹××，男，57岁，胁痛1年多，肝大肋下2.5厘米，余无异常。近来两胁痛不止，情绪不佳，纳呆，寐差，消瘦，舌质黯红，苔薄黄，脉弦细，即用加味一贯煎，服四剂证大减，再服四剂诸症悉除。(虞振英，《新中医》，1984；(11)：封三。)

按：肝经布两肋故胁痛多责之于肝。胁痛以肝气郁滞者居多，而上方所治之症是以肝阴不足所致的胁痛。方中以生

地滋阴养血以补肝肾；以沙参、麦冬、当归、白芍、枸杞子滋阴养血柔肝止痛；川楝子苦寒疏泄肝气以止痛；郁金行气祛瘀以止痛；诸药合用共奏滋阴柔止痛。

30. 慢性结肠炎

方名：苦参液

来源：韦荣贞，《新中医》，1989；(7):36。

组成：苦参30克。

用法：上药加水500毫升，文火煎至80~100毫升，每晚临睡前保留灌肠。据直肠镜的病变部位的深浅而定灌肠时的深浅。如部位较高时灌完后把臀部抬高些以便药液充分流入。灌完后睡觉，防止药液排出，第二天排便。

主治：慢性结肠炎。

疗效：韦氏用上法治疗本病10例，疗效可靠。病例：惠××，男，52岁。10年前因冒风寒到车站接人，回来后即感腹痛，腹泄稀便，经西药治疗稍好，因未坚持服药，病情反复发作，愈加严重，大便日达10次，住院经西药治疗无效，患者倦怠无力，消瘦，经用上法每日保留灌肠1次，经4个疗程病痊愈，追访至今3年多未见复发。

验证：吴氏用上法验治数例慢性结肠炎，疗效尚佳。病例：潘××，女，38岁，农民，患慢性结肠炎8年之多，经常昼夜腹泻腹痛，尤以夜间为甚，不论春夏秋冬，痛苦难忍，并明显消瘦，乏力，面部萎黄，服中西药乏效。经用上法连用2个疗程，腹部不痛，大便成形而愈。(吴永成，《新中医》，1990；(2):封三。)

按：慢性结肠炎是以腹泻、下利脓血便、粘液血便，消瘦，腹痛等为主要症状，反复发作，长期不愈。苦参味苦性寒，有清热利湿，祛风杀虫及解毒等功效。据现代药理研究，所含苦参碱对痢疾杆菌、大肠杆菌、变形杆菌、乙型链球菌及金黄色葡萄球菌均有明显的抑菌作用。水煎保留灌肠，可起到直接而持续的治疗作用。

31. 久泻久痢

方名：红枣汤

来源：郑恩弘，《新中医》，1986；（6）：26。

组成：红枣5枚，红糖60克。

用法：煎汤服，日一次。

主治：久痢不止及久泻不止。

疗效：郑氏用上方治疗小儿下痢日久或久泻不止5例皆愈。病例：一小儿久痢不止，痢下赤白，红少白多，红色不鲜，伴有乳白色粘液，饭食如常，睡露睛，舌苔白，用他方无效，经用上方，连服两次而痢止。

验证：黄氏用上方验治3例均获效。病例：李××，男，37岁，农民，1986年9月7日诊。下痢赤白已5天，经口服肌注多种西药未见效，症见下痢红白相间，日10余次，能忍无窘迫，腹隐痛喜按，面色淡漠，精神不振，四肢乏力，不思饮食，微渴，喜热饮，舌淡苔白润，辨属寒湿痢疾，用红枣汤（红枣红糖各50克），加水600毫升，煎至400毫升去渣，分2次服。次日喜告：“服头次腹痛减，2次服后即止”。（黄巨田，《新中医》，1987；（6）：56。）

按：红糖、大枣均属甘温之品，甘能补气益脾，温以散寒止痛，二者合用，共收健脾温中之功，并有活血之效，对久痢不止的虚寒痢，以下痢白色粘液或伴少量血色，无里急腹痛，舌淡苔白为主症最为适宜。

32. 虚性便秘

方名：白术通便汤

来源：杜光华等，《中医杂志》，1982；（12）：79。

组成：白术60克，生地20克，升麻5克。

用法：水煎服。

主治：虚性便秘。

疗效：上方是魏龙骧老中医治虚性便秘的经验方，取效甚佳。病例：赵××，教师。素有陈旧性肺结核，服抗痨药物时，常伴有大便干结如羊粪，或有便意感而虚坐努责。曾用大黄、芒硝之类泻下药，麻仁、当归之类润下药，但始终排便困难。改用上方，二剂便通。

验证：金氏受上方启发，用李东垣的升阳除湿防风汤（白术10克，苍术15克，防风10克，茯苓15克，白芍6克）治疗习惯性、顽固性便秘。凡经常便秘，虚坐努责，甚或下坠，便中带血或虚人不任攻伐者，用此方效果满意。（金宏达，《中医杂志》。1983；（4）：79。）

按：便秘一症，虚实皆有，临床上以实症为多，但虚性便秘亦不少见。在治疗上实症宜攻下，虚症宜润补。上方所治之便秘是由于脾虚运化失司所致，因此攻下、润下均无显效。方中重用白术增强脾运，有人认为白术少量则健脾止泻，大量则运脾阳而通大便，白术对水液代谢有“双相调

节”作用；生地取增液润肠，升麻取其升举脾阳，升清降浊。此方治便秘确有独到之处。

33. 遗尿症

方名：治遗尿验方

来源：武世昌，《新中医》，1983，（7）：43。

组成：鲜猪脬两个，茯苓、桂圆肉各30克。

用法：将猪脬反复几次清洗干净，茯苓、桂圆肉研末各取15克，装入猪脬内，放入瓷器，上笼蒸2～3小时，睡前将猪脬同药一起吃尽，每2天晚上再吃1次。

主治：遗尿症。

疗效：武氏曾用上方治疗7例遗尿症，其中痊愈6例，显效1例。病例：任××，男，19岁，于1981年2月18日就诊。主诉：睡中遗尿，精神不振已15年，多方求医不能痊愈。舌质淡，苔白，脉细弱。按上法连服二料后即效，半年后随访未见复发。

验证：颜氏用上方验证4例小儿遗尿症，全部治愈。病例：陈×，男，9岁，1984年1月10日就诊。患儿4岁起遗尿至今，经治疗数年，曾用“金鸡虎丸”、阿托品等疗效不显，就诊前1个多月遗尿更加频繁，每周遗尿5～7次，诊见精神不振、纳呆，反应迟钝，经上方治疗，连服二料，遗尿等诸症消失。随访至今未发。（颜昌隆，《新中医》，1984，（9）：封三。）

按：猪脬即猪尿胞。味甘咸性平，主治遗尿。《本草纲目》载猪脬“治梦中遗溺，疝气坠痛……”。《千金方》亦有“猪

脬洗炙食之，治梦中遗尿，”的记载。茯苓甘淡，补气健脾渗湿；桂圆味甘性温，为补益心脾之良药。三药合用，标本兼顾，故收奇效。

34. 遗 尿 症

方名：四神丸加味

来源：李昌武，《中医杂志》，1982；（2）：14。

组成：猪膀胱一具（去尿）洗净。补骨脂5克，五味子4克，熟肉蔻5克，吴茱萸5克，益智仁5克。（上为小儿量，成人酌加）。

用法：将以上中药装入猪膀胱内，并将其口扎好，用粗针头将猪膀胱刺数孔，放入盆内，加水1.5公斤，煮沸后1小时左右，去渣及汤液，取猪膀胱切片食之。成人1次食完，小孩可分2～3次食完。若服食困难，可取汤服之。

主治：遗尿症。

疗效：李氏报道用上方治疗20例，均获痊愈。服药最多者四剂，少者一剂，一般二～三剂获效。治愈者随访年余，疗效巩固未复发。病例：赵××，男，22岁，1980年5月6日就诊。患者自幼遗尿，幼时家长夜间频呼无效，经常遭受父母斥责，致精神恐惧，夜寐不安。经多方医治无效，现参军入伍，夜间至少遗尿1次，甚则2～3次，苦恼异常。诊其脉沉弱，两尺尤甚，自觉经常腰痛，天寒溲频。投上方二剂获效，四剂痊愈。

验证：薛氏将上方再加乌药、肉桂、石菖蒲三味治疗6例遗尿症均获痊愈。病例：赵××，男，16岁，学生。自幼

遗尿，每夜少则2次，常因天寒劳累加重，经多方医治效果不佳。查其舌淡苔薄白，六脉沉迟，此乃肾阳不足，膀胱气化不利，用上方加味施治（补骨脂9克，肉桂2克，石菖蒲6克，乌药9克，益智仁9克，吴茱萸9克，五味子9克，肉豆蔻7克，猪脬1个，原法煎服），二剂告愈。随访半年未复发。（薛希任，《中医杂志》，1984，（5）：80。）

按：尿液虽由膀胱贮存和排泄，但由肾脏所主司。遗尿一症多由肾阳气虚不固，膀胱气化不利，开合失常所致。方中以四神丸温补肾阳以固其本，再加益智仁增强补肾缩尿之功，妙取膀胱以形治形，引药直达病所。

35. 排尿异常

方名：麝香虎骨膏

来源：付东林，《新中医》，1988年，（5）：43。

组成：麝香、虎骨、豹骨、川乌、草乌、苍术、山奈等。

用法：先将麝香虎骨膏剪成规格约3×3厘米的小方块，再将药块贴在神阙、气海、关元、命门、肾俞、三焦俞、膀胱俞、三阴交等穴位，每次任选3～4个穴即可，48小时换贴1次，可连贴二周左右。

主治：排尿异常（包括少尿、多尿、尿失禁和尿潴留）。

疗效：付氏用上法治疗各种排尿异常，均获良效。病例：洪××，男，64岁，因前列腺肥大引起尿潴留，症见排尿困难，点滴而下，小腹拘急，坐卧不安，取气海，三焦俞，三阴交穴贴药2时许，小便畅快，余恙若失。病例：罗

×，产妇，24岁，尿闭两天，下腹坠痛，呻吟不已，贴膀胱俞、三焦俞、关元穴，1次即能自主排尿。

验证：徐氏用麝香虎骨膏外贴穴位治疗各种原因引起的排尿异常30余例，均获良效。病例：牟××，男，40岁，患泌尿道感染3天，尿急、尿频、尿意窘迫，每10分钟急需排尿1次，甚为苦楚，虽经治疗症状稍减，但尿意仍频数，经用麝香虎骨膏外贴关元、气海、肾俞等穴，翌日排尿即恢复正常。

按：麝香虎骨膏本用来治风寒湿痹、关节痛、神经痛及跌打损伤。外贴穴位用治少尿、多尿、尿失禁及尿潴留等各种排尿异常，扩大了其治疗范围。此法经济、简便、速效，无不良反应。

36. 急性肾炎

方名：温阳利水汤

来源：蒋森，《山东中医杂志》，1984；（5）：8。

组成：菟丝子、山药各15克，白术、茯苓各15克，蝉衣、防风各12克，地肤子20克，益母草30克。

用法：水煎服。若已化热者加连翘、虎杖，水肿退后加鹿角胶、黄芪、金樱子、芡实。

主治：急性肾炎。

疗效：蒋氏用上方治疗酷似风水之急性肾炎48例，疗效颇佳。

验证：李氏用上方门诊观察验治急性肾炎4例，男女各2例，发病5～20天就诊。服药6～15剂，痊愈3例，好转1

例。(李学军,《山东中医杂志》,1986,(5):45。)

按:急性肾炎多属祖国医学风水的范畴。其病因多与脾肾气虚为关。《诸病源候论》云:“风水者,由脾肾气虚弱而为也。肾劳则虚,虚则汗出,汗出逢风,风气内入,还客于肾,脾虚不能制水,故水散溢皮肤,又与风湿相搏,故云风水也”。故方中以菟丝子、山药益肾,白术、茯苓健脾,蝉衣,防风、地肤子祛风,益母草活血利水,合用则奏温肾健脾利水之效。

37. 肾 炎 水 肿

方名:宣肺利水饮

来源:杨扶国,《新中医》,1983,(1):封三。

组成:桔梗4.5克,杏仁、苡仁、猪苓、泽泻、大腹皮各6克,陈皮、木通、五加皮各3克,茯苓9克,葱白一小撮。

用法:水煎服,1日一剂。戒盐。

主治:肾炎水肿。

疗效:杨氏用此方治疗2例均有良效。例如一赵姓男青年,于1973年初开始水肿,诊为肾炎,虽经医院多方治疗,水肿始终未能消退,尿中蛋白最多时达到+++。最后只好回家。至1973年10月,患者头面水肿大如斗,腹部胀大如鼓,阴囊肿大如球,尿量极少,间有气喘,终日卧床不起。用上方加大药量服五剂,小便畅通,肿消其半。患者极为欢喜以致夜难入眠,守原方加远志9克,夜交藤15克,服四剂后水肿全消,已能持拐杖行走。至1974年7月患者健康如常人,尿检已正常。

验证：经杨氏反复验证上方治肾炎确有疗效，后扩充治其他水肿，亦有效。病例：顾××，女，5岁。面及周身浮肿1年多，曾经××县医院诊为“肾炎”，长期给予青霉素、维生素C、强的松、双氢克尿噻、氯化钾等治疗，病情反复，尿蛋白持续为（+~++），易患感冒，感冒后病情诱发加重，患者父母心情焦虑不安，前来求治。症见：周身浮肿，轻度咳嗽，精神萎靡，纳差小便少。用“宣肺利水饮”原方加生白术6克，服药五剂。水肿消退，继服五剂，肿消如常人，尿蛋白消失，再入参苓白术丸巩固疗效，2年后随访，患儿发育正常。（杨广林，《新中医》，1987；（7）：封三。）

按：此方最先见于1978年《新中医》第一期，经杨氏应用后确有一定疗效并将此方取名为“宣肺利水饮”。其组成主要有五皮饮含五苓散加减，除一般行气利水渗湿药外，加葱白以通阳利水，值得一提的是桔梗、杏仁两味宣肺气的药物。因水液代谢与肺脾肾三脏有关，肺为水之上源，若肺气不宜肃降无权不能通调水道也可导致水肿。杏仁、桔梗宣肺疏表，肃降肺气，肺气宣畅，小便自利，此即“提壶揭盖”之法。

38. 慢性肾炎蛋白尿

方名：柿树叶片

来源：丁建弥等，《中医杂志》，1981；（6）：62。

组成：柿科植物柿的干燥叶。

用法：用水煎浓缩，乙醇沉淀后制成口服片剂，每10片相当于原生药30克，服法一般为1日3次，每次4片。

主治：慢性肾炎蛋白尿。

疗效：丁氏等报道用上方治疗18例慢性肾炎蛋白尿定性长期阳性的病人，取得一定疗效。18例中，男女各9例，年龄最大的66岁，最小为21岁。治疗前尿蛋白微量3例，(+)6例，(++)4例，(+++)4例，(++++)1例。经用柿树叶片剂门诊治疗后，疗程最长8.5个月，最短3个月，部分病人曾加用“胎盘组织液”，每周注射1~2次，每次1支。结果：尿蛋白转阴7例，微量8例，(+)3例。未见有任何副作用。

验证：周氏受上法启发，对3例曾系统用过激素及环磷酰胺治疗而蛋白尿始终未能消失的慢性肾炎患者进行治疗，在辨证用药基础上，每剂中药加入新鲜柿树叶30克，这3例病人均在服药2~4个月以后，尿蛋白完全消失。其中追访2例，1年多情况依然稳定。(周嘉善，《中医杂志》，1983；(6):79。)

按：慢性肾炎所致的蛋白尿，目前尚缺少理想的治疗方法和药物。据文献报道，柿树叶中含有大量的维生素C以及黄酮类成分等。有降低血压并增加冠脉流量等作用。对慢性肾炎蛋白尿的作用机理，丁氏等认为是否系黄酮类化合物起到改善肾小球毛细血管基膜的通透性所致，尚待于进一步研究证实。

39. 严重水肿

方名：鲤鱼赤小豆汤

来源：李培根等，《新中医》，1982；(9)：52。

组成：红鲤鱼1条(约250克，去肠杂)，赤小豆200克，

花生仁 150 克，大蒜 2 头，红辣椒（干品）3 枚。

用法：上物混合煲极烂，做饭用，1 日数次分服。

主治：严重水肿症及腹水病。

疗效：李氏用上法治疗重症水肿和腹水病人多例，均获显效。病例：张××，男，19 岁。因患者肝区不适，恶心，尿黄，肝脾肿大肝功及尿三胆异常以“急性黄疸型肝炎”收传染科治疗。经用中药治疗一周，症状加重，二周后黄疸指数骤升至 105 单位，并出现肢肿，腹水，少尿，肝回缩，胆酶分离现象，科内讨论确诊为重症肝炎Ⅱ型。治疗中，腹水一症，虽经用双氢克尿塞，安体舒通，茯苓小豆汤等治疗，未见明显好转，四周后腹围达 87.5 厘米，遂改上方试治。一剂后，尿量显著增加，腹围降至 77.5 厘米，腹胀大减，按之柔软不痛，黄疸指数降至 50 单位，肢肿全消。隔周后再服一剂，腹水消退，腹围缩至正常，肝功能明显好转，黄疸指数降至 15 个单位，后改用西药保肝及中药利胆清肝，行气化瘀之品，治愈出院。

验证：李氏用上方验治小儿肾病综合征所致重症水肿，疗效甚佳。病例：李××，男，4 岁，1987 年 10 月 12 日入院。症见面部及四肢高度浮肿呈指凹性，腹部膨隆，有大量腹水，阴囊似破皮球如拳头大，阴茎水肿明显，体重 20 公斤，腹围 75 厘米，伴恶心，呕吐，低热等症，尿量 1 昼夜约 80 毫升，舌红苔薄黄，中间苔厚腻，即给上方一剂，在 2 天内频服食，患儿 3 天后尿量始增，并伴有小泻，量多每日 6～7 次（大便常规化验正常，无不适感），浮肿从面部、四肢渐退，阴部水肿消失，第六天又给原方半量，尿量 1 昼夜达 1700 毫升，大便转正常，体重降至 13 公斤，腹围正常，患

儿行走自如，又给温阳利水，健脾补肾之品二十余剂善后，临床治愈出院，随访1个月未复发。(李红生，《新中医》，1988；(3):56。)

按：鲤鱼甘平，有利水消肿，下气通乳之效。《纲目》曰：“鲤，其功长于利小便，故能消肿胀，黄疸、脚气、喘嗽，湿热之病。”赤小豆甘酸平，有利水除湿，和血消肿，解毒排脓等作用，《本草经疏》云：“凡水肿，胀满泄泻，皆湿气伤脾所致，小豆健脾燥湿，故主下水肿胀满，止泻，利小便也。”大蒜有行滞气，暖脾胃，消症结等作用。花生仁健脾补虚。辣椒能温中散寒，开胃增食，活跃气血，诸药合用，使水湿之邪从二便而排，使水肿消退。

40. 糖 尿 病

方名：黄连降糖散

来源：刘士杰，《山东中医》，1983；(5):15。

组成：黄连1份，党参（或人参）1份，天花粉2份，泽泻2份。

用法：上药共为细粉，每次服3克，每日3次，开水送服或淀粉纸包服。

主治：糖尿病。

疗效：刘氏自1975～1981年用上方治疗糖尿病20例，治愈8例，好转11例，无效1例，有效率为95%。病例：来××，男，47岁，1975年7月初诊。自1974年3月开始多饮、多食易饥，多尿，乏力。查空腹血糖260毫克%，尿糖+++，经用上方治疗，停药其它药物，服药一周后，自述有好转，

尿糖(+~++);1个月后诸症基本消失,上方服用半年后,方中人参以党参代之,一直服至1981年,几年来查空腹血糖110毫克%左右,尿糖阴性。

验证:刘氏用上方对比治疗观察了65例糖尿病患者,临床治愈11例,好转51例,无效3例,有效率为95%。(刘士杰,《中医杂志》,1985;(1):40。)

按:糖尿病,其病机多属肺胃燥热,气阴虚损。治宜补气增液、养阴清热为主。方中以人参、花粉益气养阴,以滋化源;取黄连、泽泻苦寒泻热、釜底抽薪,以求攻补兼施,阴平阳秘。故对糖尿病收到理想的治疗效果。

41. 轻中型糖尿病

方名:萝卜汁

来源:来春茂,《新中医》,1987;(8):35。

组成:红皮白肉萝卜。

用法:将萝卜捣碎榨取汁,每日服100~150毫升,早晚各服1次,7天为1个疗程,连用3~4个疗程。

主治:轻、中型糖尿病。

疗效:来氏用此方治疗糖尿病23例,痊愈14例,好转6例,无效3例。病例:冯××,女,45岁,1983年4月16日就诊。患糖尿病1年,曾经中西医结合治疗,病情时轻时重,证见口渴腰痛,疲倦无力,汗出尿频,心悸善饥,舌上赤裂,边尖红,脉细数,空腹血糖185毫克%,尿糖(+++).嘱停药,每日饮萝卜汁早晚各1次,每次服半茶杯约100毫升,继服3个疗程21天,检查:空腹血糖85毫克%,尿糖阴

性，其余症状已不明显。自觉胃部略感空虚嘈杂。给予玉竹30克煎服，以益气阴，服半个月后精神转佳，能参加全日劳动。为巩固疗效，嘱继服萝卜汁1个月。观察2年未见复发。

验证：周氏用上法治疗各种糖尿病10余例均获满意疗效。病例：郭××，女，58岁，农民。患糖尿病已10年，曾经数家医院中西医结合治疗，时好转，时加剧，经久不愈，尿糖多在(++)~(++)之间，口渴多饮，多尿，乏力，血压偏高(180/100毫米汞柱)，10年来除服中药外坚持长期服西药“D860”片。经服红萝卜汁治疗后，(停用一切中西药)仅二周时间诸症悉除，尿糖转阴，血压降至正常，能干轻活。现尚在治疗中以固疗效。(周汉青，《新中医》，1988；(1)，封三。)

按：糖尿病多属祖国医学的“消渴症”。明·胡濙《卫生易简方》卷之五消渴方载：“用萝卜生捣汁服大效。”此方对轻中型糖尿病有一定疗效。对重型(空腹血糖在250毫克以上)糖尿病易发生酮症酸中毒，应根据病情辨证论治或到医院治疗。

42. 乳 糜 尿

方名：射干饮

来源：李象复，《中医杂志》，1981；(5)：45。

组成：射干15克。

用法：水煎后加入白糖适量，1日分3次服。或制成水丸，每次4克，1日3次，饭后服。均以10天为1个疗程。

病程较长者加川芎9克，赤芍12克。患乳糜血尿者加生地15克，仙鹤草15克。

主治：乳糜尿。

疗效：李氏用上方治疗104例乳糜尿患者，大多经1个疗程即可痊愈。104例中，痊愈94例，占90.4%，无效者10例，占9.6%。病例：王××，男，54岁，1965年7月就诊。主诉：尿呈乳白色，时发时止，已近1年，感头晕乏力。曾在临沂县医院诊为乳糜尿，经长期治疗无效，服射干煎剂1个疗程后，病即痊愈，随访15年未复发。

验证：宋氏等3年来用上方验治87例乳糜尿，临床治愈74例，占85.1%。3年未复发者41例，占47.1%；2年内复发者11例，占12.6%；3个月～1年内复发者22例，占25.3%。复发者，继服原方仍有效。病例：蒋××，男，57岁，农民。1983年6月19日初诊。1961年确诊为“丝虫病”，一直服用“海群生”。1963年发现阴囊橡皮肿。1983年6月19日尿液化验：乳糜尿试验(++)，蛋白(+)，红细胞(++)。脉沉迟，舌淡有齿痕，苔薄白微腻。药用：射干20克，川芎9克，赤芍12克。服10剂尿液化验：乳糜尿试验(-)；蛋白(-)，红细胞(+)。续服20剂，1986年3月随访未复发，阴囊橡皮肿亦逐渐软化。(宋建华等，《中医杂志》，1986；(11)：66。)

马氏用上方也验治2例乳糜尿患者皆治愈。(马兆奇，《中医杂志》，1982；(8)：79。)

按：乳糜尿多属祖国医学的膏淋，主要症状为小便混浊如米泔，或如脂膏之物，尿出不畅。一般都用清热除湿的萆薢分清饮等方药治疗。射干多用它治咽喉肿痛、扁桃体炎、

支气管炎、肝脾肿等病症。用治乳糜尿古今本草书籍中未见记载。李氏在临床治咽炎时，偶然发现本品对乳糜尿有效，又经104例临床验证收效良好。再经宋氏验治 87 例，马氏验治 2 例，证实确有良效。其作用机理有待于今后进一步研究。

43 血 淋

方名：地髓汤

来源：《本草纲目》引《集要方》。

组成：牛膝根60克。

用法：牛膝根煎浓汁，日饮五服。

主治：血淋。

疗效：《本草纲目》引《集要方》记载，叶青仪亲人患血淋，流下小便在盆内凝如筠蕝久而有变如鼠形，但无足耳。百治不效。一村医用牛膝根煎浓汁，日饮五服，名地髓汤。虽未即愈，而血色渐淡，久乃复旧，后10年复作服之又瘥。

验证：笔者曾遇一血淋患者，小便涩痛，且红，频而急，腹部拘急不适，舌红苔薄黄，脉细数。即给予牛膝60克煎汤服用，嘱其频频饮之，据病人云：1日约饮药液4暖瓶，小便量大增。1日内小便成白色，疼痛明显减轻。嘱其第二日又复前其辙，连用3日病告愈。（王汝新，惠民地区中医院）。

按：血淋属中医淋证范围，盖血淋多与热迫血行有关。《本草纲目》中几处写它治疗血淋、尿血、茎中痛的功效，

牛膝味苦酸，苦酸能泻热，且能下行，故能引热从小便排出。热消血不妄行，血淋亦愈。酸能收涩，而敛亦有固摄血液之效。并嘱其频频饮之。饮水多，尿亦增多，排尿即能泻热，热随尿泄。

本方药味虽少，功效卓著，是简便易行之良方，如遇此，不妨一试。

44. 阳 痿

方名：小茴香炮姜外敷膏

来源：熊鹏飞，《新中医》，1985；(12):23。

组成：小茴香，炮姜各5克。

用法：上药研末，加食盐少许，用少许人乳汁调和(也可用蜂蜜或鸡血代)敷于肚脐，外加脐布贴紧，一般5~7天后去除敷料。

主治：阳痿。

疗效：熊氏用上方治疗阳痿多例疗效满意。病例：高×，男，24岁，身体健壮，素无恙疾。1981年初结婚，婚后不久即患阳痿不举，曾服补肾壮阳中药和激素类药物治疗半年多未效，经用上法以治不久阳痿已愈，性生活正常。

验证：何氏用上法验治3例阳痿患者均愈。病例：龚×，男，26岁，地方干部。结婚1年患阳痿，阴茎时而不举或举而不坚，有时阴茎仅有热感，别无它恙。屡服中药补肾壮阳之品及针灸疗法，均未取得满意效果。经用上方如法治疗，并嘱其暂时避房事1个月，连用20天其效霍然。后又以法用药至35天，并辅以中药内服以巩固疗效。后经随访，阳

痿已愈，房事正常。(何克哲等，《新中医》，1989，(1):封三。)

按：阳痿已肾阳虚者居多。小茴香辛温芳入肝肾脾胃经，得盐则专入肾以暖肾散寒，肾不受邪病自不生；炮姜守而不走善温下元，温肾纳气以暖丹田；人乳蜂蜜皆滋养之品，具补虚润泽调和营卫治五脏不足之效，诸药合用外敷肚脐，使药效直接迅速而持续地作用下焦，故对治疗阳痿有效。

45. 阳 痿

方名：亢痿灵

来源：陈玉梅，《中医杂志》，1981，(4):36。

组成：蜈蚣18克，当归、白芍、甘草各60克。

用法：先将当归、白芍、甘草晒干研细，过90~120目筛，然后将蜈蚣研细，再将两种药粉混合均匀，分为40包。每次半包至1包，早晚各1次，空腹用白酒或黄酒送服。15天为1个疗程。忌生冷，气恼。

主治：阳痿。

疗效：陈氏报道用上方治疗本病737例，近期治愈(指半年内)655例，占88.9%，好转并继续治疗者77例，占10.4%，无效5例，占0.7%。起效时间最快的在当天，最晚的25天后，一般3~7天见效。收效后仍需服药巩固10~15天。病例：黄××，52岁，工程师。阳痿7年。自从发现阳痿，夫妻感情一般，同房从未成功。既往患神经衰弱，泌尿系常规检查正常，曾用中药、西药、针灸多种治疗，出访

美国、日本时均经治疗，自费医疗花费千元以上均无效。经用“亢痿灵”治疗一周，勃起坚而有力，同房3次均成功。

验证：康氏用上方验治3例阳痿患者，颇有疗效。病例：张××，28岁，自1980年6月初发生阳痿，1年多来，曾用中药治疗无效。于1981年7月10日，改用“亢痿灵”散剂，每日早晚空腹用白酒冲服1包，服药4天后阴茎勃起，9天后同房成功。（康元水，《中医杂志》，1981；（11）：76。）

按：阳痿是指男子虽有性的要求，但阴茎不能勃起，或勃起不坚而妨碍进行正常的性生活者。此病虽不是致命疾病，但给患者精神上造成很大痛苦。陈氏亢痿灵疗效如此好，确为阳痿患者的福音。方中以蜈蚣为主药，其产温有毒，入肝经，走窜力最速，内而脏腑，外而经络，凡气血凝聚之处皆能开之。蜈蚣通经逐邪，开肝经之气血郁闭，使肝气条达，疏泄正常，经络畅通，气血得行。佐以白芍、当归养血活血，补肝柔肝，荣养宗筋，既能养血益精和调阴阳，又能监制蜈蚣辛温走窜伤阴之弊。甘草培补中土，以后天养先天。四药协同，气血兼顾，经腑同治，有补有通，寓通于补之中，共奏疏通肝经郁闭之功，阳痿之症自能痊愈。

46. 阳痿不育

方名：补肾填精方

来源：李志铭，《新中医》，1978；（3）：10。

组成：金英子30克，淫羊藿9～12克，菟丝子30克，破故纸9～15克，熟地15～25克，川断15克，仙茅9克，金狗脊15克，肉苁蓉15～25克，杞子12克，党参15克。

用法：水煎服。气虚者加黄芪，腰痛者加黄精、桑寄生、乌药，早泄者加牡蛎、山萸肉、五味子，脾虚纳少者加山药、云苓。

主治：精子数少，活动率低，阳痿早泄等引起的不育症。

疗效：此方是李氏跟师罗元恺教授治疗男性不育症的经验方，对精虫少、活动率低及阳痿早泄等病均有良效。

验证：杨氏用上方验治精虫少、活动力差患者4例，效果颇佳。病例：高×，男，30岁，1980年5月10日初诊。自诉婚后5年不育，经中西医结合治疗效果不佳。婚前就有头晕耳鸣，腰膝酸软，精神萎靡等症。婚后又因几年无子，求子心切，色欲竭精，复罹阳痿，面色晄白，舌苔薄白，脉沉细无力。精液常规化验：外观灰白，质稀，量1.5毫升，精虫计数0.4亿/毫升，活动率40%，活动迟缓。经用上方（金樱子、菟丝子、黄芪各30克，枸杞子、淫羊藿、破故纸各12克，狗脊15克，肉苁蓉、熟地各18克，山萸肉10克，云茯苓、仙茅各9克，水煎服，每日一剂。连服40剂，精液化验正常，症状基本消失，其爱人于1980年10月已怀孕，（杨景山，《新中医》，1989；（2）：封三。）

按：男子不育症可由生殖器畸形、萎缩，遗精，早泄，精子数少、活动力低，无精子，死精子或精子畸形等原因造成。中医多认为与肾精阴阳亏虚有关。此方主要由补肾益精，温运肾阳等药物组成。其淫羊藿据现代药理研究有促进性腺功能，促进精液分泌等作用。诸药合用，确有“补肾填精”之功。

47. 精 淤 症

方名：活血通精汤

来源：甘肃中医学院。华良才，《新中医》，1983；(12)：33。

组成：当归、鸡血藤、牛膝、益母草、何首乌、骨碎补、续断、金毛狗脊等。

用法：根据病情加减化裁、酌定用量，水煎服。

主治：精瘀症。本病主要表现有两侧肾区、足跟或足掌部、睾丸、两侧少腹部针刺样疼痛，疼痛每于睡眠或休息后加重，适当的活动后缓解。性机能紊乱，多以阳痿为主。无适当刺激而阴茎勃起，性交时却勃起不满意。在无适当刺激下缓慢的渗出精液。性交时射精不爽甚至精道刺痛。精液稠厚，如团块状，不易液化。须发早白或早脱等。屡用补肾填精之品治疗效不好甚至加重。

疗效：华氏用上方加减治疗22例因泌尿生殖系统及长期神经衰弱等患者，而出现精瘀症者，获得较好效果。病例：李××，男，40岁。5年来曾因“神经衰弱”长期失眠，久治不效。注射丙酸睾丸素每日一支，连用12支，失眠更重，甚至彻夜难眠，且腰部刺痛、遗精滑泄之症。多方求治，均为肾虚或心肾两虑论治。自述服补肾填精及养心安神之剂已二、三百剂，丸剂不计其数，病情无好转。详询其年青时有手淫史，又加精神刺激，致成不寐恼恙。腰痛如针刺，双足跟及足掌刺痛，每于休息后加重，活动后减轻，性交射精时精道刺痛。精液常规化验：精液如团块状，精子活动能力低下，并有较多畸形精子。舌质紫暗，脉沉涩。于活血通精之

当归、牛膝、益母草、鸡血藤、制首乌加菖蒲、茯神、夜交藤、合欢花，服20剂，睡眠略有进步，腰足跟刺痛好转，服40余剂后，诸症悉除，精液化验正常。

验证：吴氏用上方验治数例患者有显效。病例：吴××，男，46岁，1984年3月就诊。主诉：反复使用体外排精法避孕达10年之久，今年3月间常觉阴部胀痛，平时常阴茎易勃起，但性交时勃起不满意，射精不畅快，并有早泄，患者有前列腺病史，常使用庆大霉素及清热解毒之药，效不显。即按阳痿治疗，服补肾填精之品而病情加重，即用活血通精法以治（当归、鸡血藤、怀牛膝、益母草、首乌、川续断、骨碎补、狗脊），共服30剂，诸症全消。（吴礼豪，《新中医》，1984；（12）：56。）

按：“精淤”一症在古今文献中尚没见记载。华氏认为此症多见于手淫、长期体外排精、输精管结扎、长期神经衰弱及泌尿生殖系统等疾病。认为这一类病是先天之精的化生、流动和排泄过程有了阻碍产生了“精淤”，故选用入肾经的活血化瘀药物而奏效。此法确有独到之处。

48. 阴 寒 证

方名：加味金匱肾气丸

来源：王汝新，《湖北中医杂志》，1988；（5）：55。

组成：附子、肉桂、丹皮、泽泻、甘草各10克，熟地9克，山萸肉6克，山药、云苓各12克，生龙牡各15克。

用法：水煎服。

主治：阴寒（前阴寒冷）。

疗效：王氏用上方治愈1例阴寒患者。病例：刘×，男，50岁，患者素日性功能低下。1日小便时突然阴茎勃起，旋即手淫精泻，此后渐感阴部寒冷且潮湿，少腹拘急，疲乏无力。自感有一股寒气自下上冲，有撞心欲死之感，同时感觉肛门紧缩上抽，有欲抽进腹中之势，上述症状已持续2个月。经常梦遗，日趋渐甚，迭用镇静剂、谷维素、心得安等西药无效，求治于中医，观其面色晄白不华，舌淡苔薄白，脉虚大。治以温补肾阳，方用金匱肾气丸加味，水煎服，服五剂后，阴部寒冷大减，少腹部渐舒，但仍有遗精，阴下潮湿及寒气攻冲感，舌脉同前。即用：茯苓、桂枝、甘草、大枣汤加味以通阳利水，补土降逆；茯苓30克，桂枝、甘草各10克，大枣10枚，山药15克，生龙牡各30克，五剂，水煎服，并配合金匱肾气丸，每次1丸，日2次，药后诸症消失。

验证：笔者学用上方验治属阴寒证6例，均取得较好疗效。病例：张×，因流产后而致阴部寒冷，小腹空坠，且难以受孕，用本方后，阴寒消失，并顺产一女婴。（孙仕田，惠民地区中医院。）

按：阴寒，指前阴寒冷。《金匱》云“夫失精家，少腹弦急，阴头寒，目眩发落……，桂枝加龙骨牡蛎汤主之。”阴寒患者，必肾阳气亏乏，“肾开窍二阴，”故前阴寒冷，肛门紧缩。肾阳虚少腹温运无力，故少腹拘急。命门火衰，诸脏失温，下焦阴寒上逆，故寒气上冲。重用金匱肾气则阴寒得散，阴阳日趋平衡，诸症悉除。

49. 血小板减少性紫癜

方名：复方益血散

来源：赵宏逵,《新中医》,1983;(12):51。

组成：大鹿含草、还阳参各100克,紫丹参50克。

用法：将上药洗净晒干共为细末取10克,鲜猪肝一市两(或鲜瘦肉),剁细与药拌匀后入白蜜一茶匙加水半小碗,隔饭蒸熟后服用。可视病情轻重,每日1次,或间日1次。10次为1个疗程。

主治：血小板减少性紫癜。

疗效：一般患者在服完等一个疗程后,自觉症状即有明显改善,血小板计数都有不同程度的上升。赵氏报道用上方治疗该病44例,痊愈31例,有效13例。治愈疗程最长的服药16个疗程,最短的服药2个疗程。病例：曾××,女,3⁰岁,常发衄血,双下肢出现紫斑及出血点。血检：血小板2万/立方毫米,血色素4克%,确诊为原发性血小板减少性紫癜,经几个医院治疗达3年多,输血16000毫升,未见明显好转。经用上方12个疗程后,血小板上升至11万/立方毫米,血色素9.5克%,至今5年多未复发。

验证：本人14岁的女儿,从1983年7月开始浑身出现出血点和紫斑,经常流鼻血,精神不振面色苍白。经当地医院检查血小板1.7万/立方毫米,经住院治疗,由于服用大量激素,血小板暂时恢复正常,出院停药后又降至3万/立方毫米以下。经用上方治疗半年多,前后服药共50多包,病情大有好转,经多次复查血小板稳定在8~10万/立方毫米之间。

身上出血点和紫斑全部消失，再未发现流鼻血的现象，食欲正常，精神很好，恢复了学习。（马维骏，《新中医》，1985，（7）：封三。）

按：血小板减少性紫癜是一种比较难治的血液系统疾病。赵氏的“复方益血散”药简效好，服用方便，值得推广应用。方中还阳参为菊科绿茎还阳参别名：竹叶青、万丈深、天竹参、奶浆柴胡，有叶无花参。大叶鹿含草为菊科植物紫贝天葵草。别名：紫背鹿含草、紫背鹿衔草、天青地红、反背红野青菜。

50. 血小板减少性紫癜

方名：黄鼠狼粉

来源：768野战医院三所，《新中医》，1977，（1）：35。

组成：保存1年以上的阴干的黄鼠狼肉。

用法：将黄鼠狼肉切成块状，用阴阳瓦烘干，碾成粉状。每次服3克，1日3次，小儿酌情减量，二～三周为1个疗程，一般二周后血小板明显上升，再巩固一～二周即可停药。

主治：血小板减少性紫癜。

疗效：该所用上法治疗6例全部治愈。最多服黄鼠狼5只，一般服3～4只即愈。病例：陈××，男，11岁。1971年10月20日入院。自1965年开始鼻出血，因小量未在意，1966年春加重，时而四肢及耳廓出现紫块，大小不等。同年5月入××医院，查血小板：3万/立方毫米，周围血象正常。肝功及骨髓象检查均无异常。住院治疗1年多，先后用过激

素、维生素C及中药300余剂，血小板上升不显，波动在3万~4万/立方毫米，出血倾向存在。1966年7月于该院作脾摘除，术后住院3个多月，血小板略有上升，常在4万~6万/立方毫米之间，出院后仍服维生素类治疗。4年来，反复出血倾向仍存在。1971年10月20日入我院。体检：一般情况好，耳廓见紫斑2个，压之不退色，其余正常。化验：血色素11.5克%，红细胞440万，白细胞9000/立方毫米，血小板4万/立方毫米。诊断为原发性血小板减少性紫癜。经服黄鼠狼粉10天，血小板上升至10万，共住院治疗20天，血小板上升至18万，要求出院。4年来未用任何治疗，血小板一直保持在15万以上，全身无出血现象。

验证：王氏用上法验治3例原发性血小板减少性紫癜，疗效确切。病例：高××，男，5岁，1978年8月经××医院诊为原发性血小板减少性紫癜，门诊治疗6个月效不显，于1979年3月8日来诊。诊见面、胸、腹、背及四肢密布出血点，胸背部有紫癜，口腔粘膜、齿龈出血。查血小板计数3.7万/立方毫米，诊为原发性血小板减少性紫癜。投黄鼠狼肉末每次0.7克，日3次，二周后，查血小板计数3.8万/立方毫米，服至15周后查血小板上升至10.8万/立方毫米，出血现象消失。（王书源，《新中医》，1989；（6）：封三。）

按：黄鼠狼粉是民间土单验方，对原发性血小板减少性紫癜这种病机不甚清楚的病，能有如此理想的效果，很值得今后进一步验证和研究。

51. 特发性血小板减少性紫癜

方名：脚汗草汤

来源：宋奇英等，《中医杂志》，1983；（12）：9。

组成：脚汗草100~250克，干品10~25克。

用法：将鲜脚汗草连根茎去净泥土后水煎频服。上药为1日量。

主治：特发性血小板减少性紫癜。

疗效：宋氏等报道用上方治疗本病2例，均收良效。病例：李××，男，10岁。患儿于1976年11月因鼻腔出血不止，全身紫斑，并伴有精神、食欲不振，面色苍白，在当地医院医治罔效，遂往庆阳地区某医院诊治。查血小板3万/立方毫米，进行骨髓穿刺确诊为特发性血小板减少性紫癜。采用激素及输血疗法，经住院治疗半年，病情无明显好转，鼻衄时作，紫斑未退。1977年7月5日来我院服中药观察，用清热解毒、凉血止血、益气摄血及温补脾肾等法施治，3月后仍未见显效，复查血小板2.8万/立方毫米，血红蛋白5克，家长要求出院。回家后经人介绍用脚汗草每日200~250克，水煎频服，服药一周后鼻衄即止，连服20余天，全身紫斑消退，后间断服用三个月，一切正常，复查血小板升至20万/立方毫米，随访5年未见复发。

验证：王氏用脚汗草验治5例特发性血小板减少性紫癜，收到理想效果。5例均有典型临床症状，并经骨穿确诊。治疗方法根据年龄体质每剂用鲜净全草100~250克或干品10~25克，水煎服，每日一剂。有效者服3个月，疗效

不佳者结合中医辨证配方施治。结果5例中，3例显效，好转1例，1例无效。疗程最长者80天，最短34天，平均53.8天。(王军仓等，《中医杂志》，1986；(5):67。)

按：脚汗草多分布于辽宁、河北、山西、陕西等地，当地群众称人粪草，又名刀尖药。药用植物名为墓头回，为败酱科植物异叶败酱与糙叶败酱的根或全草。其性凉味苦微酸涩，具有清热燥湿止带止血等作用。《山西中药志》云：“敛肝燥湿，止血，治妇人髓疽，赤白带下。”经临床应用验证对特发性血小板减少性紫癜确有一定效果，尚须待于临床进一步验证。

52. 瘰 病

方名：香蜜膏

来源：郭绍汾，《新中医》，1981；(11)：6。

组成：麻油、芝麻、冰糖、蜂蜜、核桃、鲜牛奶各120克，大茴、小茴各12克。

用法：先将芝麻、核桃、大茴、小茴，研细末，然后加入麻油、冰糖、蜂蜜及鲜奶，置于文火上，炖约2个小时左右，使之成膏，每服核桃大一团，每日3次。

主治：瘰病。

疗效：郭氏用上方治疗瘰病多例均收良效。病例：李××，男，24岁，1967年4月因谈恋爱不遂而患此病。就诊时头目眩晕，失眠健忘，语言颠倒，精神抑郁，有时几天不吃东西，诊得脉得弦滑，即予“香蜜膏”一料，连服7天，病情大减，又连服两料，病即痊愈，迄今未发。

验证：阮氏用上法验治癔病性失音1例，收效满意。病例：叶×，女，42岁，1984年6月8日诊治。患癔病性失音已3年多。自述因4年前患“乙型肝炎”故情志不遂，先有腹胀，继发失音，甚至不能出声，经多方治疗无效。舌红苔少，脉细弦，用香蜜膏一料，3个月未发，再服一料，至今未见复发。（阮士军，《新中医》，1986；（3）：封三。）

按：上方八味药中有六味是食品。其中麻油可清利三焦；冰糖可除狂，平肝，润肺，清热；芝麻可补中益气，润养五脏，填脑髓，定心惊；蜂蜜可补中润燥，安五脏和营卫；核桃可补气养血；牛奶可调七情、和阴阳养心安神；大小茴香理气开胃利膈。诸药合可具润养五脏，安神定志，理气舒肝之功，故对癔病有效。

53. 癲 痢

方名：牛虱汁

来源：霍列五，《新中医》，1978；（6）：55。

组成：牛虱（水牛身上的，其色黑，夏天常在牛尾，冬天则在牛耳。黄牛身上的不得用，如色红赤或白者有毒，不可误用。）照病人岁数应用，31岁用31枚，余类推，如年未及30岁者，用虱亦须30枚为度，恐太少则力薄。

用法：将牛虱置碗中“研汁”连皮加入好酒适量冲服。

主治：疯狂癲痢症。

疗效：上方是霍氏家传验方，经数十年来用于临床，效果不错，一般服1次即可见效，症重者可服2次，没有不良反应。同时配合给予对症方药治疗，效果更佳。

验证：陈氏用上法验治 2 例 癫痫，果然有效。病例：
罗×，男，38岁。患癫痫病10年，每因情绪激动、劳累、受
凉感冒时诱发。到××医院专科诊治，脑电图报告：呈普遍
性改变，诊断为特发性(原发性)癫痫。即嘱用牛虱38枚置于
碗中“研汁”加入好酒适量冲服。每日 1 次，连服 2 日，即控
制发作，追访至今无复发。陈华显，《新中医》，1981；(3)：
18。

按：癫痫俗名“羊痫风”，是一种严重危害人民健康的常
见病，治疗也比较困难，此法药源丰富，服用方便，在农村
值得推广。用牛虱治癫痫古方未见记载，其作用机理有待于
进一步研究。

54. 癫 狂 症

方名：温胆汤

来源：陈超，《中医杂志》，1984；(11):31。

组成：陈皮、半夏、茯苓、竹茹、枳壳、远志、菖蒲、
炒枣仁、生龙牡、麦冬。

用法：痰涎壅盛者加天竺黄、胆星、明矾、礞石滚痰丸
等；肝郁气滞者加柴胡、香附、郁金、川芎等；痰热伤阴加
沙参、生地、白芍；躁动不安者加莲子、硃砂、琥珀；热盛
心烦者加黄连、黄芩、枝子、川军、龙胆草、石膏等；躁狂奔
走者加石决明、生铁落等；大便干结加元明粉、川军。酌定
用量，水煎服。

主治：癫狂症。

疗效：陈氏用上方治疗30例癫狂症收到显著效果。30例

中16例确诊为精神分裂症或其他精神病。属癫症者26例，狂症者4例。30例中近期临床治愈13例，占43%；显效5例，占17%；有效8例，占27%；无效4例，占13%。总有效率达87%。病例：王×，男，14岁，1979年5月14日初诊。患者于4月22日因与同学闹意见后，感到语言不利，思维不能用语言表达，烦躁，时有恶心呕吐，曾下颌小抽3~4次，即到附近就医，症见好转。一周前又下颌抽搐，去某医院急诊为脑炎而入院，经脑脊液检查为阴性，排除脑炎，但精神症状逐渐加重，精神抑郁，表情淡漠，两眼发直，自知力和计算力差，答非所问，时而痛哭流涕、大喊大叫，甚则动手打人，寐差，食欲不振，口干大便干。给西药镇静剂等不见好转而出院，出院时诊断为精神分裂症青年型。就诊时患者两眼发直，默默不语，呈痴呆状，烦躁面赤，苔白黄腻，脉弦滑数。以上方加减治疗(竹茹、炒枳壳、郁金、黄芩各9克，酒大黄、茯神各15克，陈皮、甘草、炙远志、菖蒲各6克，姜半夏12克，炒枣仁24克，制礞石30克，生龙牡15克)，共随诊8次，服药55剂而愈。

验证：笔者用上方验治多例癫狂症，均收良效。病例：高××，男，56岁，工人。1986年10月5日诊。因与他人闹意见而逐渐病情加重，初见精神抑郁，表情淡漠，沉默痴呆，时而语无伦次，时而喃喃自语，多疑妄想，继而见性情急躁，头痛不眠，喧扰不宁，犯乱无制，大便干结，舌质红降，脉弦滑数。经市、县医院诊为精神分裂症，口服西药无效而改用温胆汤加减方加川军10克，元明粉15克，五剂后诸症明显好转，稍事增减，共服30剂而愈。(马吉诗，桓台花园卫生所。)

按：癫狂症在临床上属于两个不同类型的疾病。癫是疯疯癫癫，喜怒无常，沉默寡言，喜静嗜卧，语无伦次，如痴如醉；狂是躁狂易怒，不寐不饥，神识昏糊，不避亲疏，逾垣上屋，打人骂人，力大过人。多见于西医某些精神分裂症等精神病。方中以二陈汤燥湿化痰，竹茹、远志、菖蒲清热化痰交通心肾，枣仁、龙牡镇静安神，麦冬滋阴液除心烦，枳壳行气导滞，以取气行则痰行三意。诸药合用，清热而不寒，化痰而不燥，适用于胆虚痰热上扰，心神不宁，神明逆乱等症。

55. 半身麻木

方名：桂枝汤

来源：吴玉臣，《中医函授通讯》，1984；（1）：43。

组成：桂枝15克，白芍15克，甘草10克，生姜10克，大枣10枚。

用法：水煎服，取微汗。

主治：半身麻木。

疗效：吴氏报道用上方治疗1例半身麻木患者疗效显著。病例：孟××，男，46岁，干部，左侧半身麻木近1年。发病前身体健康，发病无明显诱因，惟觉左侧半身肢体麻木，出风，恶风。患肢活动自如，肤色正常，肌肉不萎缩，两侧肤温无差别。经握力测验患侧稍弱，舌质淡红，苔薄白，脉缓。经用桂枝汤两剂，麻木减轻，加赤芍10克继服两剂而愈。随访2个月未复发。

验证：笔者用上方验治2例，疗效颇佳。病例：刘×

×，男，40岁，左侧半身麻木5个多月，经西医诊断为植物神经紊乱，用药治疗无效。经用桂枝汤三剂痊愈，随访至今未复发。（朱培桢，博兴县第二人民医院。）

按：桂枝汤本为治外感表虚自汗的要方。由于桂枝具有温经行血，通阳气调营卫之功，白芍有益血养营，舒展筋挛之效，配甘草、大枣，生姜既助桂枝温阳通络，又助白芍益血养营，故对气血不和营卫不调而致的半身麻亦奏效。

56. 多发性神经炎

方名：布精起痿汤

来源：吴承忠，《新中医》，1978，（2）：12。

组成：肥玉竹9克，天门冬4.5克，麦门冬4.5克，怀牛膝4.5克，怀山药4.5克，炙黄柏2.5克，蒸白术4.5克，白茯苓4.5克，炒苡仁9克，炙甘草2.5克。

用法：白术要蒸，兼饭后气而减其燥，黄柏要炙，借蜜炙而和其苦。若加重用量，宜照此比例。水煎服。

主治：痿证（多发性神经炎）。

疗效：吴老中医在几十年的临床诊断中，依照剂量使用治疗痿证，从未有1例失败。但要耐心连服，少则40剂左右，多则80剂左右，无有不愈者。

验证：田氏用上方验治1例痿证，疗效甚佳。病例：牛×，男，26岁，干部，1982年3月就诊。自1977年秋末病起时常觉绵绵发热，自汗，手足心热，未经治疗，数月后四肢发胀，下肢困重，疲倦乏力，口渴喜饮，动则汗出，心悸气短，屡服中西药效不显。1978年2月间突感全身肌颤，举步

不稳，随即扑倒在地，四肢瘫软，住院治疗月余出院。尔后每年春秋两季常发，经数家医院诊为周期麻痹。此次病情加剧，入院来诊。见四肢瘫软，精神萎烦，语声低微，饮食二便均需人扶助，舌质红，苔黄腻，脉滑数无力，即用布精起痿汤加黄芪15克，服五剂后症转，30剂后诸症悉平，再进50剂以固疗效，追访1年零3个月未见复发，正常上班。(田种玉，《新中医》，1984；(2):56。)

按：痿症是指肢体筋脉弛缓，手足痿软无力的一种病症，以下肢不能随意运动及行走者较为多见。可多见于西医的多发性神经炎，进行性肌萎缩，重症肌无力，周期性麻痹，肌营养不良症及其他中枢神经系统感染并发软瘫的后遗症。吴氏布精起痿汤是取水精四布五经并行之意，主要用于肝肾阴虚精血不足而致的痿症。

57. 外感发热

方名：退热散

来源：李云喜等，《新中医》，1980；(6):28。

组成：石膏120克，麻黄3克，桂枝3克。

用法：共研细末，煎水多次温服，2~3小时服1次，1日服完，并保暖令其汗微出。有的患者服二、三次后，体温有反跳现象应坚持不要中断。

主治：外感发热。

疗效：李氏经用上方治疗发热200例，服退热散36小时热退为有效，181例有效。超过36小时热不退者为无效。

验证：唐氏用上方（石膏60~120克，桂枝麻黄各4~5

克)验证100例疗效显著。病例:赵××,男,4岁,高热持续8天,查咽部红肿,白细胞9000~12000/立方毫米,口服小儿阿斯匹林、安宫牛黄丸,静脉点滴和肌注青、链霉素,体温仍在39℃以上,服上方4小时后,体温降至正常。(唐椒贤,《新中医》,1986,(2):42。)

按:此方药仅三味,价格低廉,效果如此显著,关键是重用石膏,不必畏其寒不敢多用。石膏虽有退热作用,但有抑制发汗中枢作用,故加用少量麻黄、桂枝发汗解表增强退热。对外感高热及其他原因引起的发热有明显的退热作用,但对外感风寒、恶寒重发热轻者,不宜应用。

58. 多种发热

方名:青银汤

来源:梁天照,《新中医》,1978,(3):19。

组成:青蒿(后下)3克,银胡10克,桔梗10克,黄芩10克,连翘10克,银花10克。

用法:水煎服。在上方基础上再加一至三味药物,还可治其他多种热性病。

主治:流感、产后、外科手术感染、脑膜炎等多种热性病如:高热寒战,口鼻气热,头痛,骨节疼痛,舌苔黄或薄白,脉数。

疗效:梁氏以上方为主加减治疗流行性感冒,麻疹后久热,外科手术感染发热,产后发热、脑膜炎发热期等原因不明之热等500例,效果尚属满意。病例:何××,男,6岁,1965年9月11日来诊。发热3天,体温39.4℃,头痛目赤,汗

少作渴，舌苔微黄，脉数。诊为流行性感冒，经用青银汤加葛根25克，生石膏25克，至宝丹1克（冲）服两剂热退。病例：徐××，女，30岁，患者于1976年10月19日行阑尾切除，术后第七天开始发热，伴有寒战，持续5天，经用西药抗感染治疗未效，于10月30日邀中医会诊，见体温39.3℃，高热寒战，头晕痛，脸赤唇红，口干渴，身微自汗出，胃纳欠佳，小便短黄，大便稀，舌苔厚白微黄，脉数略弦，伤口感染化脓。诊断：术后感染发热。经用青银汤加石膏25克，蒲公英15克，布渣叶12克。水煎服，两剂后热已退，头晕痛及口干渴均减，胃纳转佳，大便正常，仍有自汗出，舌淡苔白微黄，脉数。以银花12克，连翘10克，黄芩10克，甘草4.5克，杭菊10克，太子参12克，糯根15克，服二剂后热退。

验证：刘氏多年来用上方加减治疗外感发热，夏季热、扁桃体炎发热、原因不明发热，阴虚发热等20余例，均收捷效，十分满意。病例：刘某，男，36，干部。低热20余天，体温37.5～38.2℃，除精神、食欲欠佳外，其他无任何不适。曾经地区医院中西医治疗无效，胸透及三大常规化验无异常发现，诊断：原因不明低热。余运用“青银汤”加减，服二剂热退。（刘传芳，《新中医》，1990，（2）：封三。）

按：发热是机体与外来病邪作斗争的一种生理性反应，是多种疾病中的一个症状。梁氏的“青银汤”方中用青蒿味甘性寒，气味芬芳，入少阳、厥阴经血分，主治留热在骨髓间的伏热；银胡味甘微寒，能清热凉血，退热而不苦泄，理阴而不升阳，疏肝透里，可使热从内达外；桔梗辛微温，宣肺气，散风寒，既能载药上行，又能降气化痰；黄芩苦寒，清热泻火，解毒利湿；银花、连翘轻宣散结，清热解毒。合

用则有清热泻火，凉血解毒等作用，效能全面，多方兼顾，故对凡由细菌、病毒等引起的多种热性病可收满意效果。

59. 昏 迷

方名：点舌方

来源：邓铁涛，《新中医》，1986；（3）：41。

组成：紫雪丹，至宝丹，安宫牛黄丸或苏合香丸等含有冰片，麝香，牛黄等丸散剂。

用法：将丸散适量用水溶化，用棉签蘸药液点于舌上，不停地点，当丸药厚铺舌面时则用开水点化之，化薄后继续点药，约半小时可苏醒。

主治：昏迷。

疗效：邓教授用上法抢救了许多脑出血，心肌梗塞，心衰等严重昏迷病人。例如：1985年9月收治1例严重昏迷（一氧化碳中毒）之患者，经用西医常规方法抢救1天1夜，病情继续恶化，高热神昏，痰涎涌盛，四肢抽搐，戴眼反折，面目及全身浮肿，呼吸喘促张口，口臭难闻，二便不通，舌瘀黯，苔厚浊，脉洪大而数。急用安宫牛黄丸一枚，冷开水10毫升化开不停点舌上。另用大黄，崩大碗各30克，苏叶15克，煎水取汁再化紫金锭3片，保留灌肠1日2次。治疗9天，患者体温降至正常，并从昏迷中苏醒过来。

验证：周氏用上法抢救危症，确有良效。病例：农××，男，76岁，农民。1978年9月16日晚饭后泡脚时突然神志昏迷坠地，左侧上下肢随之僵硬，呼之不应。检查：舌降苔黄，脉弦紧滑。血压240/200毫米汞柱，诊为中风。遂以

点舌法施治，随即取麝香及冰片少许，开水液化，不断以棉签蘸药点于舌上，30分钟后，患者左侧上下肢变软，神志略清，血压亦降至200/180毫米汞柱，同时投人参、生半夏、沙参、地龙各10克，生南星6克，生附子5克，煎服调理，次日下午病人能坐起进食，神志清楚，5天后竟能外出放牛而告痊愈。(周永辉，《新中医》，1990；(1)；封三。)

按：昏迷是属急症危症之一，应分秒必争积极抢救。紫雪丹、至宝丹、安宫牛黄属于凉开“三宝”，均含有麝香，牛黄，冰片等芳香开窍醒神的药物。祖国医学认为心主神明，心开窍于舌，昏迷多属痰热蒙蔽清窍扰乱心神所致。将上药溶化频频点舌，直接作用于心经，故收效迅速。如有条件可配合西医西药抢救。

外科部分

60. 慢性毛囊炎（劈脑疳疮）

方名：胆汁雄黄膏

来源：薛景勋，《新中医》，1983，（7）：29。

组成：雄黄30克，猪胆1个。

用法：将雄黄研极细，把猪胆刺破，取汁同雄黄调成糊状，擦于患部。擦药前剃净头发，用皂角刺、苦参、黄柏各15克，水煎反复洗涤头部，再将胆汁雄黄膏涂上，每日2~3次，以疮疖消散头皮恢复正常为度。擦药期间兼服牛黄解毒片，每次3~5片，每日2次，连服5~7天。注意治疗期间及愈后忌食牛、羊、狗肉半年。

主治：慢性毛囊炎（劈脑疳疮）。

疗效：薛氏用上方治愈2例。病例：李××，男，38岁，1974年4月来诊。患者头部生长米粒样丘疹，此起彼伏，搔痒难忍已12年。曾用过柳酸、九一四、灰黄霉素、氢化可的松等药膏，又注射氯化钙、维丁胶性钙等针药未愈，1972年在四川医学院皮肤科诊为“慢性头皮毛囊炎”，给予软膏擦后，稍有好转。于1974年3月间食牛肉后，病情增剧，丘疹

倍增，搔痒如故而来诊。症见头皮上密布红色丘疹，小者如葶苈子，大者如碎米，部分搔破后见少量脓性分泌物，结有黄色干痂，舌质红，苔黄腻，脉濡数，按上法治疗四周，丘疹完全消失搔痒止。随访3年未复发。（王学敏，《新中医》，1986；（10）：53。）

按：慢性毛囊炎是发生在头皮浅表毛囊口的小脓疮，痒甚初为散在的红色小丘疹，渐为脓性结痂性皮疹。此消彼起，日久不愈，极其顽固。祖国医学称“劈脑疔疮”。胆汁雄黄膏出自《圣济总录》。胆汁味苦性寒，苦能燥湿泻火，寒能清热，雄黄味辛性温，具有祛风、燥湿杀虫，解毒疗疮之功效，若再配以牛黄解毒片内服，清热泻火解毒，内外合治故能奏效。

61. 脓疱疮（黄水疮）

方名：脓疮洗剂

来源：张君喜，《新中医》，1985；（7）：10。

组成：黄柏、生大黄，苦参各30克，蒲公英、百部、银花各20克。

用法：水煎外洗患处。有粘稠渗出液或结痂时，宜先以温热淡盐水轻洗清除，后再用本法，每日3~5次。

主治：脓疱疮（黄水疮）。

疗效：张氏用上方治疗本病60例，痊愈56例，疗程4~8天，平均6天，其他4例用药3天后，因疗效不大而改用肌注青霉素治疗愈者判为无效。病例：王×，男，4岁。6天前觉头顶部有轻度灼痛，即见头顶有铜钱大红片，2日后觉

有痒感且痛，抓后局部有粘液而来诊。自觉轻度发热，查头部散在分布斑片状脓疱疹渗出淡黄色混浊液，并见脓痂附着，周围有炎性红晕。耳后有3个蚕豆大淋巴结可触及，压痛(+)。血检白细胞12500/立方毫米，中性80%，淋巴20%。诊为脓疱疮即用上方洗剂，5个月痊愈，未见复发。

验证：李氏用上方验治15例黄水疮患者，疗效显著。病例：刘××，男，12岁，学生，1987年6月12日来诊。患者头部分布斑片状脓疮，渗出淡黄色混浊液，并见脓痂附着，周围炎性红晕，双耳后淋巴结肿大可触及，压痛。奇痒微痛，轻发热，诊为脓疱疮。经用上方洗剂7日痊愈未见复发。(李昌铭，《新中医》，1988；(11):56。)

按：黄水疮属现代医学的“脓疱疮”，为夏季多发病常见病，以儿童居多，且常群体发病。方取黄柏、大黄清热燥湿解毒，苦参、百部，杀虫止痒，蒲公英、银花、清热解毒，消肿散结，合用外洗可有清热解毒祛湿，杀虫止痒、消炎之功。

62. 白 发

方名：治白发方

来源：关宁远，《新中医》，1976；(6)50。

组成：甘枸杞60克（以宁夏所产为佳，其它产地效力稍逊），胡桃12个（选大者去外壳取仁，炒香切碎），小黑豆250克。

用法：先将枸杞用新铁锅或做饭铁锅（忌用炒菜铁锅和其它锅）加水煎煮至嚼之而无味去渣取汁，放铁锅内另放冷

处4~6小时，使枸杞浓汁，大量合成锅上的铁质色素，再放入黑豆，切碎的胡桃仁同煮，煮至药汁全被黑豆吸收为度，取出放在铁筛中晾干，再用12岁以下健壮儿童尿，截去头尾（取中段尿）适量，拌浸1~2天，干燥后即可服用，早晚空腹或饥饿时随意零食，每次约五六十粒（嚼烂服用）。一般服药3~5料，约2~3月后即可看到明显效果。

主治：白发。

疗效：关氏用上法治疗3例白发均收良效。病例：李×，男，32岁，干部，1973年秋诊。头发白已大半，要求予以治疗，经用上法三料，头发全部转黑，迄今再未发现间白。

验证：笔者用上法验治临床效果确实。病例：赵××，男，23岁，1986年5月5日诊。自5年前头发见白，日趋增多，现已白3/5，因服中药汤剂不方便，故介绍上法（枸杞200克，何首乌200克，核桃仁30克（捣烂），黑豆500克，先把枸杞子、首乌如上法煎煮去渣取汁，再加入捣烂的核桃仁，黑豆同煮至药汁吸收尽，取出晒干或烘干）治疗不到3个月，用药二料，白发先变黄，再由黄变黑色，并且记忆力增强，精力充沛。（袁惠民，滨州卫校。）

按：头发早白是一种常见病。祖国医学认为多与肾精亏虚、血虚有关。方中枸杞味甘性平，既可补肾益精滋阴，又可滋髓达脑益血；胡桃仁状类人脑，其性温味甘气香，能强筋助髓通脑；黑豆形似人肾腰子，味甘性平，能补肾益髓，养肝明目；童便味咸善降，温而不燥，取12岁以下强壮男孩小便，义取肾气未损及稚阳不助相火。诸药合用，而有乌发之功。并且服用方便，宜于长期应用。

63. 脱 发

方名：生发汤

来源：甘肃中医学院 华良才，《新中医》，1984；(5)：23。

组成：制首乌20~30克，生地黄、菟丝子各15~20克，当归、天麻各10克，白芍15克，川芎6克，蛇蜕8克（无蛇蜕可用蝉蜕代之）。

用法：头皮刺痒重者加百部、地肤子、白藓皮各10~15克，头皮脱屑多者加白蒺藜15~20克；阴虚内热重者加丹皮8克，地骨皮12克，贞子10~15克，旱莲草10克。每剂药煎3次，前2次煎出液内服，第三次煎出液洗头。每日一剂。

主治：青年脱发。

疗效：华氏十人用上方治疗青年脱发，效果良好。病例：黄××，男，24岁。1970年10月11日初诊。自述自1968年以来患脱发，日趋严重。近半年来每天脱发甚多，早晨起床时枕头上都有头发数十根。头皮刺痒严重，脱屑甚多，但不敢洗头，因每次洗头、梳头时都大量脱发。经服西药胱氨酸数百片，外搽“20”生发药水多瓶，均未见效。视其头发稀疏，不及常人之半，枯槁无泽。头皮干燥失荣，脱屑甚多，舌红少苔，脉弦细。予生发汤加味，15剂药后，已完全控制脱发，且有纤细头发渐渐新生。继以上方三剂配制丸剂巩固疗效。1971年春，其头发已茂密乌黑如常人。随访12年，未再复发。

验证：甘氏应用上方不仅对青年脱发有效，对老年脱发疗效亦佳。病例：赖××，男，地质队工人，52岁。患脱发

症数年，多方延医治疗无效，用生发汤治疗20剂后，头发乌如常人，面色红润光泽。(甘锡民，《新中医》，1984；(11)：封三。)

按：脱发一症，中医认为多肾精气血的盛衰有密切关系，有“肾其华在发”和“发为血之余”之说。方中以首乌、菟丝子、生地补肾生精荣发，当归、川芎、白芍、生地四物补血、活血、生发，再以天麻、蛇蜕祛风固发，精充血旺，发当自生。用药期间要节房事，戒手淫，忌食辛辣刺激食物，以增强疗效。

64. 斑秃(油风)

方名：中药浸剂

来源：姜耀武等，《中医函授通讯》，1986；(1)：571。

组成：野菊花100克，丹参100克，艾叶50克，骨碎补100克，防己100克，红花500克，海桐皮100克，黄实100克。

用法：上药浸入4000毫升白酒中密封30天后，过滤备用。每日擦患处6~8次。

主治：斑秃(油风)。

疗效：姜氏自拟上方后，应用30例，治愈27例(斑秃区毛发全部长出)，显效1例(斑秃区90%以上毛发生长)；无效2例(斑秃区无新发生长)。总有效率为93.3%；有效病例在30~60天开始可见新发生长。病例：杜×，男，16岁，学生，1985年4月18日初诊。半年前，无意发现枕部有两卵黄大小之脱发区，自擦姜片1个月无效来诊，经用中药浸剂擦患处，2个月后全部长出新发。

验证：张氏用该方法治疗斑秃32例，效果极佳，治愈率为100%。典型病例：蒋×，男，51岁。3年前，头顶出现圆形成片脱发，曾服百余剂中药皆无效，头发几乎脱光，经2个月擦药，斑秃处长满了头发。(张德术，《中医函授通讯》，1987；(2)：12。)

按：斑秃的成因属血虚，故有“发为血之余”之论，血虚则发无以养，故发落。该方以活血之药行血，促进血循环，再配丹参养血，补血、生发、血液畅行，头皮得养，发自出也。

65. 脂溢性皮炎

方名：颠倒散

来源：广东省中医院皮肤科，《新中医》，1986；(11)：29。

组成：大黄、硫黄各等分。

用法：将上两药研细末备用。先用温水洗湿头发，然后把颠倒散搓到头皮上去，2~3分钟后温水洗去药粉，或用硫黄香皂洗1次头，并用清水洗净便可。每隔3~5天用药1次。

主治：头脂溢性皮炎。

疗效：该科用上方治疗本病100例，显效60例(60%)，有效31例(31%)，无效9例(9%)，总有效率为91%。病例：巫××，女，34岁。1984年5月14日初诊。主诉：头皮痒二周，伴头发油腻，脱发，即予上方洗头，用3次后，症状全部消失。

验证：邢氏用上方验治于临床，屡验屡效。病例：汪××，男，32岁，工人。头皮瘙痒半年多，有时奇痒难忍。

头、颈、耳周白屑叠生，尤以头皮为甚。先后以凉血祛风，补肾补血，燥湿等法治疗均未见效。经用上 方 外洗 1 次痒止，洗 5 次白屑已除，至今未见复发。(刑剑科，《新中医》1990；(2)：封三。)

按：颠倒散是《医宗金鉴》中的方，是用来治疗“肺风粉刺”即(痤疮)的。方中大黄味苦性寒，清热泻火，解毒，硫磺味辛性温，杀虫而痒，二药性寒热颠倒故曰颠倒散。用治脂溢性皮炎同样起到良好效果。

66. 酒 刺 (痤 疮)

方名：治酒刺方

来源：邵忠文等，《新中医》，1982；(1)：19。

组成：白果。

用法：将白果去掉外壳，取种仁用刀片切出平面频搓患部，边搓边削去用过部分，每次用1~2粒种仁搓即可。于每晚睡前用温水将患部洗净(不用肥皂或香皂)，搓药后次日早上洗脸，可照常搽抹雪花膏之类的护肤品。一般用药7~14次酒刺即见消失。

主治：酒刺(头面皰泡，青春美丽豆，青春 蕾)也称粉刺、痤疮。

疗效：邵氏等自1978~1980年共用30斤白果，治疗116例青年酒刺患者，收到显效。

验证：刘氏用上 方 临床治疗 6 例酒刺患者均获满意疗效。并将使用方法进行改进，即将白果(银杏)30克压碎，放于100毫升乙醇(70%)中浸泡一星期过滤后取药液外搽日

2~3次，效果亦佳。病例：简××，女，20岁。患脸部痤疮3年，曾使用“暗疮特效霜”等治疗无效，后改用上方治疗15天痤疮消失，继用10天以巩固疗效，追访半年多无复发。（刘焕贤，《新中医》，1985；（5）：封三。）

按：酒刺又称痤疮，由于多见于青年又叫青春美丽豆。是由于内分泌量大，影响皮肤血管舒缩神经功能，使皮肤皮脂腺分泌量增加，产生浓稠的皮脂，因不能完全排出，渐渐蓄积在毛囊口处形成大小不等的面部突起。白果中所含的氰甙水解后产生氰酸，能抑制麻痹血管舒缩神经功能的混乱，所含的白果酚甲有使肌肉收缩和增加血管渗透的作用，将其涂在患部后能使患部恢复正常的生理功能，使酒刺消失，而且不留疤痕。

67. 面部“印斑”（蝴蝶影）

方名：疏肺散斑汤

来源：袁尊山，《新中医》，1982；（9）：21。

组成：荷叶6克，防风10克，蝉蜕6克，桔梗10克，百合10克，浙贝母15克，淡竹叶10克，木通10克，栝蒌皮10克，法半夏10克，茺蔚子10克，甘草6克。

用法：水煎服。脾胃湿滞，四肢倦怠，纳呆，大便不爽，苔滑润，脉濡等症，加茯苓15克，毕澄茄、枳壳各10克；心经热症，心悸，失眠，烦躁不宁，小便黄少等加夜交藤，生龙骨、生牡蛎各20克，莲子芯10克；肝火上乘，两胁作痛，易怒，头顶或太阳穴痛，舌边红，苔黄厚，脉弦数等症，加木贼草10克，青箱子、夏枯草各15克。

主治：面部“印斑”（蝴蝶影）。

疗效：袁氏10多年来用上方治疗多例患者，疗效满意。

病例：景×，女，26岁，未婚。因面部起印斑5年，久治不愈而于1981年6月2日来诊。视其面部，以鼻为中心，全然灰黑，如蝶伏其面。且两颧之间，色较深黑。仅鼻孔以下，始见黄白本色。月经正常，白带较多，但无臭味。兼有心悸、失眠、烦躁，小便黄少等，舌质尖红，苔黄润，脉数。用疏肺散斑汤加夜交藤。生龙骨、生牡蛎各20克，莲子芯10克，水煎服四剂后，心悸、失眠均有好转，面部印斑颜色变浅，脉稍和缓，以上方加减继服12剂，面部印斑基本消散，饮食、精神、睡眠均可，脉舌正常，病已痊愈，遂以上方每周二剂，连用三周，以巩固疗效。

验证：周氏用上方验治四例黄褐斑患，获效甚著。所治四例均为女性，均有月经不调，经血紫黑夹瘀块，情志抑郁等症。病程2~4年。其中3例在经期治疗，1例在经后治疗，服药最少六剂，最多14剂，经随访3例痊愈，1例显效。

按：“印斑”是以鼻为中心的面部黑斑或灰斑。因为常形成蝴蝶状又名“蝴蝶斑”。如见于孕妇则叫孕斑。也可见于未婚未孕的中、青年女性，虽无痛苦，却影响美观，未婚青年甚至有严重的精神负担。中医认为“肺为华盖，主皮毛”，通调水道，输津液，故印斑所成，责之于肺。袁氏自拟疏肺散斑汤，方中以蝉蜕、荷叶、防风、桔梗、百合、竹叶、枯菱皮清轻发散，宣通为本，用木通、甘草、利小便以通阳，去湿热，佐以半夏，浙贝母以祛中上焦之痰湿。共奏宣通理肺，通阳散斑之效。

68. 男性乳房发育症

方名：逍遥丸

来源：谢昭安，《新中医》，1988；(1):44。

组成：当归、白芍、柴胡、白术、茯苓、甘草、薄荷等。

用法：水丸剂，每日3次，每次9克，饭后温开水送服，3个月为1个疗程。

主治：男性乳房发育。

疗效：谢氏用逍遥丸治疗本病35例，按发病时间长短分三组进行观察：A组，发病在3个月至1年内者25例，其中15例服药75天后乳房肿块完全消失，10例服药1个疗程零5天，肿块消失，乳房恢复正常。B组：发病1年以上至3年以内者7例，其中5例服药1个疗程20天肿块完全消失，2例肿块缩小原来的2/3。C组：发病3年以上者3例，其中1例服药1个疗程肿块完全消失，1例服药1个疗程后肿块略有缩小，因做睾丸肿瘤切除手术未坚持服药治疗。另1例合并睾丸外伤手术后病人服药半个疗程后，乳房肿块明显缩小，但由于不合作而中断治疗。发病时间短者，疗效较佳。总治愈率为89%。

验证：高氏用逍遥散验治1例获愈。病例：肖××，男，25岁，农民，5年前右乳房渐增大，如妇人状，伴胀痛，用逍遥散(当归、白芍、茯苓、白术各10克，甘草、生姜各3克，柴胡、薄荷各6克，水煎服，日一剂。15剂后，乳房渐小，胀痛大减。再进15剂，半月后乳房完好如初，左

右对称。(高胜,《新中医》,1988;(11):56。)

按:本病多发生在男子青春期和50岁以后。一般认为发病原因与这二个时期的内分泌的改变有关。祖国医学认为,男性乳房发育症系肝气郁结,湿痰内蕴所致。逍遥丸中药用柴胡、薄荷、生姜以顺其疏泄,使之升发条达,且引诸药直达病所;当归、白芍养血柔肝;白术、茯苓、甘草健脾和中,以培生化之源。诸药共奏疏肝理气,健脾燥湿化痰之功。使肝气舒,郁自解,脾胃健,湿痰除则乳房肿块自消。

69. 腋 臭

方名:碘椒酊

来源:罗新昌,《新中医》,1977;(1):46。

组成:辣椒2~3粒,2~2.5%的碘酊10毫升。

用法:将辣椒切成小段放入碘酊内,入瓶密封摇荡,即成“碘椒酊”。将棉球饱蘸药液充分涂擦腋窝,每天1~3次,一般连用7天可愈。

主治:腋臭。

疗效:罗氏用此法治疗多例,均收到良好效果。病例:陈××,男,18岁,学生,有腋臭多年,每天用碘椒酊充分涂擦腋窝2次,治疗6天获愈。

验证:胡氏报道用上法验治5例,全部治愈。病例:唐××,女,患腋臭已10多年,常为该病难治而苦恼,经用碘椒酊,一次即见显效,臭减大半,坚持治疗而痊愈。(胡忠炎,《新中医》,1977;(5):封三。)

按:腋臭是因腋窝大汗腺的分泌物和局部细菌作用所

致。多与遗传有关。虽对健康没有大的影响，但臭味重时，往往影响旁人学习工作，令人生畏。上法制法简单，使用方便，效果理想，若有其疾，值得一试。注：辣椒品种较多，最好用形体像大米的“米椒”。经胡氏验证若无“米椒”，其他任何品种的辣椒均可。涂搽药次数，1天以2次为宜，少了影响疗效，多了辣痛太甚。

70. 胆 结 石

方名：柴胡四金汤

来源：蔡荫庭，《新中医》，1988，(6):11。

组成：柴胡、白芍、金铃子、郁金、金钱草、鸡内金、茵陈、木香、龙胆草、大黄、芒硝。

用法：根据病情酌定用量，水煎服。

主治：胆结石。

疗效：蔡老中医用上方治疗本病疗效显著。病例：卢××，女，51岁。因右上腹阵发性绞痛伴发热、畏寒已10天而急诊入院。患者原有胆石症病史近10年，反复发作。近10天来右上腹剧痛，阵发性加剧，痛时向右肩及腰背部放射，发热畏寒，伴恶心呕吐，大汗淋漓，口渴咽干纳呆。检查：体温40℃，血压96/75毫米汞柱，全身皮肤有轻度黄染，巩膜黄染(+++)，右上腹拒按肌紧张，压痛(++)，莫非氏征阳性。超声波检查：右肋下胆囊液平段5厘米。舌红，苔厚腻，脉滑数。处方：柴胡、大黄、金铃子、郁金各9克，白芍、鸡内金各15克，金钱草、茵陈各30克，木香、龙胆草各6克，玄明粉13克(另冲)。水煎服，日一剂。服药第二天开始排石，

连续排石3天，共排出黄褐色之结石112粒。排石后症状体征逐渐消失，服药10剂，共住院14天，痊愈出院，跟踪4个月未见复发。

验证：吴氏用上方验治5例胆石症，皆收显著疗效。病例：吴××，女，30岁，患胆石症反复发作10多年。近来发作6天，右上腹剧痛，阵发性加剧，痛时向右肩背放射，发热恶寒伴恶心呕吐，痛时弯腰打滚，用拳头坚压腹部呻吟不息，大汗淋漓，面色苍白，食后痛剧，3天未能进食，两天未解大便，脉沉细数，经西医输液、抗炎、镇痛解痉效不佳，经上方一剂，服1次后痛减大半，2次后疼痛消失，能吃两碗稀饭，连服三剂至今未发。（吴三俊，《新中医》，1988，（11）：56。）

按：胆石症具有痛、热、黄三大症，其中以痛为主要矛盾，在治疗上必须“以通为用”，因该方具有疏肝利胆，清热除湿，攻坚破积，促进结石排出等作用，用治胆石症疗效显著。

71. 胆 结 石

方名：治胆结石方

来源：袁鹤济，《新中医》，1982；（6）：6。

组成：生甘草、炙甘草各10克，乌药6克，银花10克，炒白芍10克，白薏仁1.5克。

用法：水煎服。可随症加减。

主治：胆结石。

疗效：袁老中医以上方加减，少则数剂多则10余剂，可

使许多胆石病人免于手术。病例：鲁××，女，外国人，44岁。1954年9月27日初诊。症见食后胁下作痛，时发时止，右侧尤甚。纳差，每食刺激性食物痛辄发。经西医检查诊为：胆囊炎，胆结石。诊得舌红有裂纹，苔黄，脉两关均弦。治以甘缓和中止痛，给予上方服药一剂痛稍减，二剂而痛止。症脉好转，仍守前方稍加增减，服至10月18日患者于大便中先后排出7粒结石，此后胁痛未发。

验证：肖氏遵上方加减验治30例经X线检查或B超探查确诊的胆石症，其中胆石全部排出症状消除者10例，结石部分排出或结石向下移动症状好转者16例，病情无改善者4例（其中3例肝内胆管结石）。从临床实践看上方对胆囊管结石疗效较为满意，但对肝内胆管结石疗效较差。（肖嘉荣，《新中医》，1984，（11）：封三。）

按：上方治结石之法，确有独到之处，药少量轻，药味看似平淡而有出奇制胜之妙。方中生甘草泻火补脾，炙甘草补元气平肝而止痛，生炙同用亦补亦清，以其甘缓为主；炒白芍平肝而止痛，与甘草相伍酸甘化阴共奏缓肝和脾止痛之功；乌药、薏仁行气止痛，银花清热解毒。虽未用利胆排石之重剂，确收到止痛排石之效。

72. 慢性胆囊炎

方名：慢性胆囊炎专方

来源：余国俊，《山东中医杂志》，1983，（1）：23。

组成：柴胡10克，龙胆草10克，生牡蛎30克。

用法：以三药为专药专方，随证加味，水煎服。

主治：慢性胆囊炎。

疗效：余氏用上方加味治疗本病多例，皆收良效。病例：郑××，男，56岁，1977年12月8日初诊。1976年5月患急性胆囊炎，经保守疗法缓解后转为慢性。右上腹胀痛，时而窜及肩背作痛，痛时手足微冷。矢气频频痛可减，忧思恼怒则痛增。屡用疏肝理气药物，痛可缓而不能止，舌质红，苔薄黄干，脉弦数乏力。此因肝胆郁热，兼气滞胸胁，有伤阴之象。治宜升肝降胆，理气开郁，护养肝阴。予专方专药加味（柴胡10克，胆草10克，生牡蛎30克，白芍30克，香附、枳壳、青皮各10克，甘草3克），服四剂痛止。半年后因事拂逆，右上腹又胀痛难忍，仍投上方，加元胡6克（冲服），二剂痛止。

验证：我用余国俊大夫的专方专药，先后治疗3例慢性胆囊炎病人，都取得满意效果。（赵维华，《山东中医杂志》，1986；（5）：45。）

按：余氏认为慢性胆囊炎的临床证候虽较复杂，但总的病理机制，大多属于肝胆郁热，脾胃气化失常而壅遏。故以柴胡升发肝气，疏肝达郁；胆草大苦大寒，沉阴下降，泻肝胆实火；生牡蛎寒咸软坚，散气火之凝结，去胁下之痞硬。三药相伍，一升一降一和，专治肝胆之郁热。若能与辨证结合，加味应用，疗效更好。

73. 胆道蛔虫症

方名：猪胆汁方

来源：代宏彬，《新中医》，1989；（2）：13。

组成：猪苦胆一枚取汁，胡椒末、川椒末各20克，酸醋300毫升。

用法：上药混合，分2次服下。

主治：胆道蛔症。

疗效：代氏报道用上方治疗胆道蛔虫症近百例，收效满意。病例：陈学英，女，24岁，工人。1985年12月24日入院。阵发性右上腹疼痛，伴放射至右肩背痛，恶心呕吐，疑胆道蛔虫症、胆结石收入院。经用西药输液，止痛，针灸及乌梅汤均无效，彻夜不眠，弯腰抱腹，汗出如珠，经用上方服后，几分钟后痛止，嘱其下午再服1次，3日后痊愈出院，至今未复发。

验证：富氏用上方验治1例27岁女性患者，以阵发性右小腹绞痛，并放射右肩背痛，恶心呕吐，吐出蛔虫两条前来求医，疑为胆道蛔虫。胆石症收治，经用大量抗菌素、激素、补钾、输液、肌注安定、阿托品、口服中西药均无效。根据钻顶样绞痛右背痛和痛后如常人的特点，拟定上方诊断性给药，以排除胆石症，结果药到病除，一次成功。（富彦相，《新中医》，1991；（2）：封三。）

按：蛔虫得酸则静，得辛则伏，得苦则下，故用胆汁清热泻火，更有以胆治胆之意；川椒、胡椒均味辛，祛寒杀虫；酸醋入肝经，取酸收之意。酸苦辛同用，寒热并用，寒热既平，蛔退而痛止。

74. 胆道蛔虫症

方名：胆蛔汤

来源：邓铁涛，《新中医》，1987；（4）：38。

组成：炒榧子肉、苦楝根、白皮各12克。乌梅10克，使君子(打)12克。

用法：枣子槟榔(切)12克。水煎服。上为10岁左右儿童剂量，可根据年龄、体质及病情加减，1日一剂或二剂。也可同时静脉滴注等渗葡萄糖，缓解疼痛，服药后阵发性疼痛止，一般在12个小时左右即排出。

主治：胆道蛔虫，肠道蛔虫。

疗效：经邓老多年应用此方比仲景乌梅丸有效。例如1女同学患胆道蛔虫，未用滴注，单用上方治疗数剂而愈。

验证：姜氏用上方治疗10例胆道蛔虫均有效。病例：刘××，女，1987年5月25日无明显诱因，右上腹剧痛，呈阵发性钻顶样痛一天，同时伴恶心呕吐，此物为胃内容物。5月26日住进外科病房B超检查：胆总管增宽，其内可见条索状回声，诊为胆道蛔虫。以上方加大用量，水煎服。一剂后上腹痛锐减，三剂后便排出蛔虫两条，痛止。于6月2日B超复查，肝胆未见异常改变，痊愈出院。(姜传武，《新中医》，1988(2)：55。)

按：胆道蛔虫是由于蛔虫穿入肝道所致，以上腹部阵发性钻顶样疼痛为特点，伴有呕吐寒战、发热。多见于儿童及青壮年。上方榧子肉、苦楝皮、使君子、槟榔均有驱杀蛔虫的作用，乌梅味酸以取蛔虫“见酸则退”，使其从肠道中退出

之效。

75. 巨大胃柿石症

方名：乌药承气汤加减

来源：刘士杰等，《山东中医杂志》，1988；(6):47。

组成：乌药10克，香附10克，木香6克，元胡12克，砂仁6克，牵牛子10克，大黄6克，厚朴10克，枳实10克，鸡内金10克，焦三仙各12克。

用法：水煎服，日一剂。

主治：巨大胃柿石症。

疗效：刘氏等用上方治愈1女性27岁巨大胃柿石症患者。患者半月前某日曾空腹进食柿子2枚(约250克)。食后因头痛又即刻服脑心舒10毫升，休息约1小时后，感上腹不适疼痛，数日后渐加重，伴恶心呕吐，吐出胃内容物，偶噎气，常大便秘结。查舌质淡红，舌苔薄白，中部厚略腻，脉弦滑。查体：剑突下有压痛，可扪及约6×7厘米大小的包块，边缘清楚，质较硬，推之移动，表面不规则，未见其异常。于1987年11月22日经X线钡餐透视，发现胃有6×7厘米左右异物型，可以移动。诊断为巨大胃柿石症，对症治疗无效，建议手术治疗，病人惧于手术而用中药治疗。经上方加减共服药20余剂，症状消失。于1988年1月8日X线摄片复查示异物消失，胃壁光滑，蠕动对称，病告痊愈。

验证：张氏用上方验治了1位胃石患者。此患者去过几家大医院，都建议手术取石，在无其他办法的情况下，来我院准备手术治疗，这时突然想起《山东中医》杂志登载的乌药承

气汤加减治疗巨大胃柿石症的报道，经用此方共服12剂收到奇效，症痊愈。使患者免受开刀之苦和经济损失。（张保才，《山东中医》，1989，（5）：57。）

按：胃柿石症临床比较少见。西医多采用手术治疗，而用中药乌药承气汤加减确能治愈。方中用乌药、枳实、香附、木香、厚朴、砂仁等大量理气药，破气导滞散结，鸡内金散结消石，焦三仙消食健胃，用牵牛子、大黄泻下通便，诸药合用，共奏行气导滞，泻下排石之功。

76. 泌尿系结石

方名：硝石散

来源：吴金轩，《新中医》，1985，（2）：56。

组成：火硝6克，滑石18克。

用法：在铁勺上置纸一张，把火硝倒在纸上，不让其接触铁器，放在文火上炒黄。炒黄的火硝6克与滑石18克，加水一大碗，煎沸10分钟，倒出药汁服用，1日一剂，日服2次，连续用至尿石排下为止。

主治：膀胱结石、尿道结石及肾结石。亦可用治胆道结石。

疗效：此方是吴氏临床应用50多年的验方，用治膀胱结石、尿道结石疗效最好。病例：答××，患尿石症数年，经用上方五剂而愈。病例：王××，患尿石症，服上方10余剂，排下尿石3颗而愈。

验证：杨氏用上方加茅根治疗膀胱、尿道等结石39例，证实疗效确佳。病例：舒××，男，26岁，农民。1988年7

月13日以右腰绞痛引少腹尿频尿痛，淋漓不尽伴血尿就诊，X线摄片诊为输尿管中段及膀胱结石。处方硝酸钾（为试剂用品，炒微黄）9克，滑石18克，白茅根15克，水煎服，服至第五剂排出黄豆大结石一枚，继服六剂，由于结石2次嵌阻尿道口引起尿潴溜，最后手术取出一枚1.8×1.3厘米的棱形结石。（杨宝献，《新中医》，1990；（3）：封三。）

陈氏用此方加大黄、石尔香治疗3例胆道结石也取得了满意疗效。（陈自玉，《新中医》，1989；（8）：56。）

按：火硝又名硝石、焰硝能消物软坚，与芒硝相似，但火硝较芒硝效力大。滑石性缓，清热利尿除湿，去膀胱结石，与火硝配用有清热化石之功。

77. 前列腺肥大

方名：疏肝散结方

来源：岳承忠，《新中医》，1984；（7）：5。

组成：柴胡、牛膝各10克，生牡蛎30克（先煎），丹参、当归、赤芍、海藻、昆布、海浮石、夏枯草、玄参各15克，川贝粉3克（分冲），肾精子5粒（以桂圆肉包裹，于第一次服药时吞服。）

用法：水煎服。

主治：老年前列腺肥大。

疗效：上方是印会河教授治疗老年前列腺肥大的主方，经临床反复应用证明行之有效。病例：李××，男，78岁，1980年诊治。此人素有高血压病史，又患小便淋漓不尽多年，1年前，因突然不能排尿而急入北京×医院，经查诊断

为老年性前列腺肿大。因血压高不适于手术，故作留置导尿管处理，并建议中医治疗。经用上方五剂尿道通畅无阻，又进五剂，多年之苦疾告愈，多次追访，未见再发。

验证：段氏用上方验治1例亦收良效。病例：曹××，男，63岁，患小便不畅1年多。近半年来，日见加重，每次排尿淋漓不尽。经医院诊为“老年性前列腺肥大”，经中西医结合治疗无效，改用“疏肝散结方”（肾精子以冬葵子9克代之），连用七剂而愈。（段汉峨，《新中医》，1985，（2）：56。）

按：印教授以中医辨证论治为基础，结合丰富的临床经验，参照现代医学对人体的认识，指出：现代医学所述前列腺之部位，正为中医足厥阴肝经的循行所过之地，故将前列腺肿大归属为肝经病变，又提出“疏肝散结”之法，方中取当归、赤芍、丹参、养血活血，调理肝经，疏通经脉；柴胡疏肝解郁条达气机，引药入肝经；牡蛎、海藻、昆布、海浮石、玄参、贝母、夏枯草、肾精子（牛膀胱之结石）软坚消积，消除症结肿块；牛膝引诸药下行直达病所，诸药合用，症积得消，经脉疏通，故尿路通畅小便自如。

78. 前列腺炎

方名：补肾导湿汤

来源：林君玉，《中医杂志》，1987，（6）：20。

组成：川萆薢、菟丝子、沙苑子、淮山药、茯苓、石菖蒲、黄柏、芡实、车前子、甘草。

用法：酌定用量，水煎服。也可随证加减。

主治：前列腺炎。

疗效：上方是林氏治疗前列腺炎与“精浊”的基本方，具有消中有补，不致克伐正气；补中有消，无虑留滞湿热的优点，加减应用可用治急慢前列腺炎，效果良好。

验证：王氏用上方加减治疗18例前列腺增生症，收效满意。18例均为男性，年龄50~70岁，病程最短5年，最长15年，18例均经肛门指诊确诊。其中6例作膀胱镜检查，5例作“B超”检查确诊。用补肾导湿汤（川萆薢15克，菟丝子15克，生山药15克，芡实10克，益智仁15克，石菖蒲10克，黄柏10克，车前子15克，丹皮10克，云苓15克，甘草5克。舌苔黄腻者前列腺常规检查有少许脓细胞或“+”以上者，去芡实，加薏苡米15克，冬瓜仁10克，重用黄柏至20克；舌苔白腻者重用云苓、萆薢至30克；见肝肾阴虚者加女贞子15克，旱莲草15克；脾肾亏损，病情迁延者重用山药、菟丝子至30克。服药期间不可饮茶，以清淡饮食为宜），结果其中14例无炎症患者服中药三剂即见效，2例服药一剂见效。夜尿由原来10余次减少到3次以下，半月后夜尿控制在1~2次以内。4例炎症患者，服药六剂方见效，调治1个月后，小便次数可控制在每晚3~5次。（王更生，《中医杂志》，1988；（7）：66。）

按：前列腺炎、前列腺增生症是老年人一种常见病，多属祖国医学“淋浊”、“精浊”、“肾虚”范围。方中以菟丝子、沙苑子、山药健脾益肾；以萆薢、黄柏、车前子、芡实、茯苓清利水湿；石菖蒲交通心肾，甘草调和诸药合用共奏补益脾肾，利尿通淋，对脾肾亏损，湿浊留滞所致的老年慢性非炎症性前列腺增生症，以小便频数，舌苔白腻，无膀胱刺激征者，收效最快。

79. 前列腺炎

方名：补肾导湿汤

来源：林君玉,《中医杂志》,1987,(6):20。

组成：川萆薢、菟丝子、沙苑子、淮山药、茯苓、石菖蒲、黄柏、芡实、车前子、甘草。

用法：酌定用量，也可以上方为基本方加减应用，水煎服，日一剂。

主治：前列腺炎(精浊)，前列腺增生。

疗效：林氏自拟补肾导湿汤随证加减治疗前列腺炎(精浊)多例，收效较好。

验证：以上方加减治疗18例前列腺增生收到满意效果。18例均为男性50~70岁，病程最长15年，最短5年。18例均经肛门指诊确诊，其中6例作膀胱镜检查，5例作B超检查而确诊。18例中14例单纯服中药，4例配合服中成药前列通片、安尿通片和抗炎治疗。14例无炎症患者服中药三剂后即可见效。

按：前列腺炎、前列腺增生是老年人的常见病。以尿道滴白，尿急，尿频，尿痛，时有排尿困难，性功能障碍等为主症。方中以菟丝子、沙苑子补肾，用山药、茯苓、芡实健脾除湿，萆薢利湿化浊，为治白浊之主药，菖蒲、车前子化浊利湿；黄柏清泻膀胱湿热，甘草调和诸药，此方具有消中有补，不致克伐正气，补中有消，无虑留滞湿热的优点。

80. 各种息肉

方名：济生乌梅丸加味

来源：龚志等，《新中医》，1983，(11):33。

组成：乌梅1500克，僵蚕500克，象牙屑30克，人指甲15克(或用炮穿山甲30克代替)，酒醋适量。

用法：把乌梅放入酒醋中浸泡一宿，以浸透乌梅为度，去核，焙焦存性，僵蚕(半拌炒黄为度)，人指甲用水洗净用滑石粉炒至黄色鼓起，象牙屑上四药共为细末，炼蜜为丸，每丸重9克(放置干燥通风处勿霉变)。成人每服1丸，早中晚各1次，白开水送下，儿童酌减量。上剂量为1个疗程，日连续服2至3疗程。

主治：各种息肉(直肠、声带、宫颈息肉)。

疗效：龚氏等用上方治疗直肠息肉，声带息肉，宫颈息肉皆取得了显著的效果。病例张××，男，58岁。患者于1977年3月始大便时有鲜血，血附于大便之表面，排便时肛门无疼痛和下坠感，大便每天1次，不洁燥，如便结则血较多。今年元月始大便出血量较多。窥肛肠检肛管距肛门口约5厘米处3点、5点、9点肠壁均有息肉似葡萄状紫红色，蒂短紧附于肠壁，触之易出血。诊断为多发性直肠息肉。共服“济生乌梅丸”24天，检查：各点之息肉已脱落，基底部有少许残根已近乎肠壁平行，无出血，继服15天，3个月后复查息肉无所见，病家无所苦。

验证：裴氏等用上方验治2例结肠息肉病人，获满意疗效。病例：滕××，男，27岁，自1982年起常有腹泻，气候

转凉时更甚，大便带粘液红赤，伴右下腹痛，无里急后重感。经直肠镜检查诊断为肠息肉，建议手术治疗。因患者畏惧手术而用上方加减治疗，连服3个疗程诸症消失，于1984年10月赴某医院复查，结果，息肉消失，肠壁光滑，只残留零星针尖大小瘢痕不充血。(裴振华等，《新中医》，1985；(10)：55。)

周氏等报道用上方加减验治直肠息肉，声带息肉收到很好效果。有1例患“声带息肉”的病人，经长期服用抗菌消炎药及清热解毒，养阴利咽中药达100余剂，未见明显好转，声嘶越来越重，咽喉常感梗塞，痛苦异常，经用上方加减（乌梅250克，僵蚕200克，桔梗200克，丹参200克，甘草30克，共研为细末，蜂蜜为丸，每服9克，日服3次），服一料，诸症皆除，声音恢复如常，五官科检查，息肉完全消失，继以上方一剂，巩固疗效。(周天寒等，《中医杂志》，1987，(10)：37。)

按：直肠，声带，宫颈息肉临床上比较常见，比较棘手，难于手术，术后易复发。龚氏用“济生乌梅丸”能获良效，值得一试。方中乌梅味酸，有敛肺湿肠，蚀恶肉，化痔消息肉之功。《本经》“去死肌，青黑痣，蚀恶肉。”僵蚕有消风化痰散结之功。象牙屑性味甘寒，有清热，拔毒，生肌之效，《本经经疏》：“治恶疮、拔毒、长肉、生肌、去漏管。”人指甲有软坚、散结、祛瘀之功。酒醋味酸可助乌梅涩肠止血，又能散瘀。本方对恶性肿瘤不适宜。

81. 各种痔病

方名：乙字汤

来源：万揆一，《新中医》，1979；（4）：20。

组成：大黄1克，柴胡5克，升麻1.5克，甘草2克，黄芩3克，当归6克。

用法：水煎服，日一剂。

主治：各种痔病。

疗效：万氏用上方治疗各种痔病10余例。一般服药5~10剂即可收到止痛、止血，痔核逐渐内收之效。病例：樊×，52岁，患痔疾已逾10年，发作时疼痛流血，西医诊断为混合痔。半年前因其叔患内痔疼痛流血，在我院以“乙字汤”治疗收效。由其叔介绍来诊。查形体消瘦，面色苍黑，舌周色赤，舌苔黄厚，痔核脱出，疼痛不止，大便燥结，血随便出，脉沉弦缓略现涩象。经用“乙字汤”变量服之（大黄9克，当归18克，柴胡15克，黄芩10克，升麻6克，甘草12克）一剂未尽，大便通畅，痛缓血止。后大黄减为3克续服两剂后，疼痛全止。脱出之痔核，亦逐日内收。1年多来又复发1次，再服上方后迅速收效。

验证：王氏用上方验治痔疮疗效确切可靠。病例：冯××，女，52岁。1979年10月5日就诊。病人患外痔已达7年之久，经常流血、疼痛、脱肛，便后要用手送回肛门。经用“乙字汤”加减，服三剂后各症大减，续服而愈。（王春雄，《新中医》，1989；（7）：封三。）

杨氏等用“乙字汤”治疗湿热痔疮出8例，效果显著。（杨邦忠，《新中医》，1989；（2）：封三。）

刘氏用“乙字汤”验治各种痔疮20余例，确有良效。（刘相亲，《新中医》，1987；（7）：封三。）

按：“乙字汤”为日本原南阳氏治疗各种痔病的验方。方

中当归和血，可改善血行不畅状况兼有止痛效果，黄芩、甘草清热解毒，柴胡升麻同配具有升提举陷之用，能使脱出之痔核内收，生大黄泻热通便，便秘则免流血之患。药味不多，精当中证，奏效迅速。

82. 痔 疮

方名：痔疮方(编者加)

来源：王殿祥，《新中医》，1985，(3)：9。

组成：鲜无花果10枚。

用法：将无花果放于砂锅内加水2000毫升，文火煎煮沸后仍煎30分钟，至药液约1500毫升左右，然后倒入干净盆内，捞起熟果盛于碗里。用脱脂棉蘸药液敷患处，每次20分钟，同时食煮熟的无花果5枚。上药为1日量分2次用。治疗期间禁忌辛辣刺激食物。

主治：痔疮。

疗效：王氏用上方治疗痔疮27例，全部治愈。治疗次数最多者12次，最少者5次，平均7.6次。病例：陈××，男，48岁，患血栓痔已2年，经多方治疗未愈，于1980年8月19日就诊，经用上法治疗3天痊愈，追访3年未见复发。

验证：李氏本人痔疮严重，经用上方治愈。后用此方验治几十例痔疮患者均获愈。(李俊卿，《新中医》，1987；(11)：封三。)

按：据《随息居饮食谱》记载：“无花果甘寒清热，疗痔润肠，上利咽喉”，《本草纲目》曰“……治五痔咽喉痛”。文火煎煮，水外洗，果内服，收效甚佳，值得一试。

83. 痔疮发炎、肿痛

方名：痔炎膏

来源：陈培城，《新中医》，1984，(11)：32。

组成：芒硝30克，冰片10克，猪胆汁适量。

用法：先将芒硝、冰片研为细末，再用适量猪胆汁调成糊状(如痔核表面有溃疡或分泌物者加白矾10克)，外敷痔疮，以消毒棉垫覆盖，胶布固定，每天早晚各换药1次。

主治：痔疮发炎肿痛者。

疗效：陈氏用上方治疗痔疮发炎肿痛者多例，疗效满意。病例：李××，女，46岁，干部。痔疮发炎5天，曾服抗生素、化痔灵，痔根断效不显，于1981年4月26日就诊。现痔疮肿痛日见增甚，坐卧不安，入夜难寐。检查见截石位3~7点处痔核肿胀，大如拇指，色深红紫，触痛明显，诊为混合痔合并发炎，遂以“痔炎膏”外敷2天后肿消痛止。

验证：胡氏用上方验治1例痔疮患者获愈。病例：王××，男，30岁，干部。患痔病2年，经常复发，久治不愈。常用抗生素、痔疮栓、痔疮药膏、高锰酸钾外洗等治疗，疗效不佳。于今年1月10日来诊。痔病复发，疼痛难忍，坐卧不安，彻夜难眠。检查截石位3~7点处痔核肿大如枣，呈深红色，触痛明显，诊为混合痔合并感染。即用上方外敷，2天后症状消失，随访数月未复发。(胡平，《新中医》，1985，(6)，封三。)

按：方中芒硝取其清肠通便，泻火解毒，消肿止痛；冰片散热消而止痛；猪胆汁解毒疗疮，清热通便，诸药调成糊

状外敷，局部直接用药，效果更佳。

84. 蛲虫病

方名：治蛲虫方

来源：李存敬，《新中医》，1987；(9):12。

组成：苦楝子一个。

用法：将成熟苦楝子洗净，温开水泡软，去皮后塞入肛门，每晚睡前1次，连用5天。塞后卧床休息，第二天早起排出苦楝子。每日用开水煮洗短裤，以绝传染之源。

主治：蛲虫病。

疗效：经李氏多年应用上方治疗蛲虫病，无论男女老幼、体质强弱，无不奏效。

验证：何氏等用上方验治成人蛲虫1例。病例：马××，男，45岁，干部。患蛲生病年余。每夜晚入睡则肛门瘙痒无耐，以致睡眠不佳，白天头昏乏力，影响工作，多次服用中西药驱虫剂，疗效欠佳，久而久之，每晚睡后1小时，必起床捉蛲虫1次。1988年1月16日患者使用上方如法治疗，用至第三天，晚睡觉时已无肛痒，后又连用半月，其病已瘥。

(何克哲等，《新中医》，1989；(1):封三。)

按：苦楝子性味苦寒有毒，功专杀蛲虫、蛔虫，肛门局部用药收效甚佳。

85. 宿食结于肠间

方名：赭遂攻结汤

来源：张锡纯，医学衷中参西录，152。

组成：生赭石60克，朴硝15克，干姜6克，甘遂4.5克（轧细药汁送服）。

用法：水煎汤送甘遂末。

主治：宿食结于肠间，不能下行，大便多日不通。

疗效：张氏用上方治疗1例年过五旬的病人，呻吟不止，言自觉食物结于下脘，甚是痛楚，数次延医调治，一剂中大黄用至两半不下。且凡所服之药，觉行至所结之处，即上逆吐出，饮食亦然。此时上焦甚觉烦躁，大便不通达10日之久。诊其脉，虽微弱，至数不数，重按有根。知犹可任攻下，遂用此汤去干姜，方中赭石改用90克，朴硝改用25克。服后须臾，腹中作响，过了2.5小时，大便通下而愈。1个多月后，症状复发如前，仍用前方而愈。

验证：仇氏效张氏之法，临证中凡见燥结证，如现代医学之肠梗阻或急性胆囊炎、胰腺炎等出现大便秘结不通者，多习用代赭石。病例：钱××，女，46岁，2人。1987年10月来诊。素有习惯性便秘10多年，平日靠服用麻仁丸、果导片等大便方通。此次因操劳过度，起居失常，以至大便间日未解，服用麻仁丸等罔效，西医嘱其灌肠，患者不愿而要求中药治疗，诊见大便秘结，腹部胀满有积气，心中烦闷，面赤烘热，口干喜冷饮，舌尖红，苔黄腻而糙，脉弦，证属胃肠积热，腑气不通，燥屎内停，拟方：代赭石30克，大黄10克，芒硝6克，枳实10克，厚朴10克，木香10克，槟榔10克，甘草6克，服一剂，大便得畅，腹胀亦除。数月后患者上症又发，同道曾用调胃承气汤加味，治之不效。我在同道原方中加入代赭石45克服之而愈。（仇锦华，《中医杂志》，1990；（4）：58。）

按：赭石苦寒质重，入心肝二经，其镇逆止血平肝之功已被医者熟悉应用，而通便之功则鲜为人知。据现代药理研究代赭石含有镁盐，镁离子在肠道形成一定的渗透压，使肠内保持大量水分，可刺激肠蠕动而排便。代赭石的通便作用已被张锡纯和仇氏所证实。应用时可依病证不同而配其他方药应用。

86. 睾丸鞘膜积液

方名：水疝汤

来源：北京老中医房芝萱。

组成：小茴香、生槟榔、乌药、炒二丑、车前子、牛膝、橘核、猪茯苓、肉桂、当归、泽泻、赤芍。

用法：水煎服。临床运用时可随证加减。

主治：水疝(睾丸鞘膜积液)。

疗效：上方为房老中医治疗水疝的经验方，治愈者甚多。

验证：张氏用上方验治于临床每获良效。病例：张××，男，5岁，1982年3月12日初诊。患儿右侧阴囊下坠，肿大似鹅卵状，皮色晶亮光滑，按之稍硬，不痛，推之不移，睾丸不能触及。透光试验阳性，诊为“睾丸鞘膜积液”，动员手术治疗，因家长不同意，转用中药治疗，经用疏肝理气、软坚散结方12剂无效，后改用上方加减（小茴香10克，槟榔5克，乌药5克，车前子5克，当归5克，赤芍5克，泽泻5克，炒二丑3克，昆布10克，海藻10克。服五剂后阴囊已缩小如常人。再予原方五剂，以巩固疗效。（张威才，《中

医杂志》，1987，（6）：43。）

按：水疝属西医的睾丸鞘膜积液。多因水湿下注或感受风寒湿邪而致。上方中以猪茯苓、车前子、泽泻、二丑以利水渗湿消除水湿为患，以小茴香、槟榔、乌药、橘核、肉桂散寒湿行气滞，以当归、赤芍、牛膝活血祛瘀，诸药合用共奏散寒行气活血，利水渗湿消肿之效。

87. 睾丸鞘膜积液

方名：浸洗液（编者加）

来源：刘加升，《新中医》，1982；（9）：22。

组成：肉桂6克，煅龙骨15克，五倍子15克，枯矾15克。

用法：将上药捣碎加水约700毫升，放于药锅内煎煮，水沸后30分钟将煎出液滤出，待冷却至与皮肤温度相近时，把阴囊全部放入盛药液的容器内，浸洗30分钟左右，每2日一剂，连用八剂。

主治：睾丸鞘膜积液。

疗效：刘氏用上方治疗睾丸鞘膜积液11例，均获痊愈。用药最少者五剂，最多者九剂。病例：曹××，男，5岁，1976年10月6日发现阴囊左侧逐渐增大，无疼痛，无发热，阴囊大小与体位、咳嗽、挤压均无关。检查：阴囊左侧肿大，触之有囊性感微有波动，局部无红肿热痛，左侧睾丸未触及，透光试验阳性，即用上方三剂，其父代诉经洗后肿大阴囊明显缩小，再用二剂洗后阴囊恢复到原来大小，随访1年未见复发。

验证：笔者用上方再加艾灸验治小儿睾丸鞘膜积液疗效可靠。病例：张×，男，6岁，1986年10月5日诊。自1983年7月发现左侧阴囊肿大，经地区医院外科诊为睾丸鞘膜积液，建议手术治疗，家长不同意而来诊，经用上法外洗二周配合艾条点灸水道穴（位于腹正中线脐下3寸旁开2寸处），气冲穴（位于腹正中线脐下5寸旁开2寸处），交替施灸30分钟，以局部皮肤红晕或温热灼手患者能耐受为度，每晚1次，连用二周，肿大时的阴囊渐复正常，随访至今未复发。

（袁惠民，《新中医》，1988；（10）：56。）

按：方中肉桂温经散寒具有扩张血管的作用，并能刺激粘膜吸收，排除积气积液；枯矾、五倍子有较强的收敛燥湿作用，并能制止粘膜渗出；煅龙骨也有较强的收敛吸湿作用，四药合用浸洗有良好的收敛吸湿，制止鞘液分泌，促进积液吸收的功能。该方疗效可靠，经济方便，无痛苦易于小儿患者接受。

88. 阴囊湿疹

方名：治阴囊湿疹方

来源：梁惠敏，《新中医》，1984；（10）：34。

组成：外洗方：苦参30克，地肤子16克，蛇床子12克，花椒10克。

涂药方：滑石粉15克，枯矾6克，青黛9克，组成复方滑石粉。

用法：先将外洗药加水1500毫升，用砂锅煎成汤、早、晚各洗患处1次，每次15～20分钟，一剂药可连续使用2

天。洗完后用软毛巾擦干患处，再将复方滑石粉涂擦患处。

主治：阴囊湿疹(绣球风)。

疗效：梁氏用上方治疗多例阴囊湿疹患者，取得较满意效果。病例：李×，患急性阴囊湿疹，搔痒难忍，用手抓得阴囊流水，心情烦躁，采用外洗、涂药法，连续治疗3天而获愈。

验证：谭氏用上方验治7例阴囊湿疹，均获痊愈。病例：张××，男，26岁，农民，1985年4月21日来诊。患急性阴囊湿疹，搔痒难忍，阴囊有黄色粘液渗出，服西药无效，经用上方外洗和涂药治疗，3天后即愈，随访至今未复发。(谭凤森，《新中医》，1989；(8)：56。)

按：阴囊湿疹中医称“肾囊风”，民间称“绣球风”，是湿疹的一种类型。急性的阴囊皮肤灼热和红肿特别显著，若不及时治疗可转为亚急性。若长期反复发作，经久不愈则变成慢性。经用祛风利湿、杀虫止痒的外洗方，再外涂利湿解毒医疮的复方滑石粉，故能取得满意疗效。

89. 带状疱疹

方名：带状疱疹外敷效方

来源：俞善同，《新中医》，1987；(11)：8。

组成：紫金锭片，季德胜蛇药片，板蓝根注射液，白醋(黑醋也可)。

用法：用紫金锭、季德胜蛇药片各1支，研极细末，加板蓝根注射液4毫升，白醋10毫升，冷开水适量，调成稀糊状，用消毒棉签蘸药涂搽患部，每日4~5次。以上为病灶

3平方厘米的用量，可按病灶范围比例加量。

主治：带状疱疹。

疗效：一般涂药2小时内止痛，4天内痊愈。俞氏治疗10例带状疱疹疗效好，疗程短。病例：曹××，女，40岁，1986年10月5日突然右胸疼痛，继4、5前后肋间起密集成簇、大小不等水疱，基底紫红斑，充血，周围轻度红色浸润，用上药后半小时内止痛，3天痊愈。

验证：李氏用上方验治临床，疗效满意。病例：陈×，女，45岁。1988年12月15日右腋下及右肩部疼痛，第二天痛剧，经×医院诊为带状疱疹，用维生素B₁、B₁₂、板蓝根液注射2天，外搽伞油（做雨伞用的油），5天效果不显。经用上方外敷2小时痛止，4天痊愈。（李世文，《新中医》，1989；（7）：封三。）

按：带状疱疹是由病毒所致，西药对其效果欠佳。紫金锭片、季德胜蛇片、板蓝根注射均有清热解毒消肿疗疮的功效，醋调外敷局部故收良效。

90. 带 状 疱 疹

方名：三黄二香散

来源：殷大彰，《新中医》，1987；（2）：44。

组成：大黄、黄柏、黄连各30克，制乳香、没药各15克。

用法：上药共研细末，加细茶叶泡浓汁适量调成糊状，外敷患处，干则易之。

主治：带状疱疹（缠腰火丹、蛇丹）。

疗效：一般1~2日后结痂，疼痛消失，4~6日痊愈。病例：徐×，女，21岁，学生，1979年7月21日初诊。自诉5天前右腰部突然出现成批集簇水疱，渐次增多，刺痛甚剧，寤寐不安，诊为带状疱疹，用抗生素无效，经人介绍来诊。患者右腰部、腹部及后背可见大片成簇密集水疱，皮肤灼红疼痛，不敢碰触，舌绛，苔净，脉弦细，用上方外用调敷患处，即日痛止眠安，2天后结痂，4天全消而愈。

验证：陈氏用上方验治2例；确有良效。病例：周×，女，50岁，右侧右腹部皮肤灼热刺痛3天，经用四环素，吗啡呱等不效，疼痛加重，查：右第十肋下皮肤有密集黄豆大小的透明水疱，疱壁紧张，四周红晕，沿右侧背腹部分布，排成带状，累累如串珠，疱群之间皮肤正常，舌红，苔薄黄，脉弦数，经用上方外敷患处，第二天复诊患处结痂，疼痛消失，第五天痊愈。追访未见复发。（陈辉光，《新中医》，1988，（7）：封三。）

按：带状疱疹属祖国医学“丹”门，好发于胸胁部及腰腹部一例，故称“缠腰火丹”；亦见于头，面部及其他部位总称“蛇丹”。由火邪湿毒凝结而成，治宜清热解毒利湿，上方中“三黄”清热解毒泻火，乳没消肿生肌，活血止痛，局部外敷，收效甚佳。

91. 带 状 疱 疹

方名：六神丸

来源：赵良辰等，《中医函授通讯》，1990；（5）：9。

组成：麝香、牛黄、冰片、珍珠、蟾酥，雄黄等。

用法：将六神丸适量，用温开水化开，再与仙人掌（去皮）调和成糊状，敷于患处，相隔2日换药，换药时用温盐水清洗患处。

主治：缠腰火丹（带状疱疹）。

疗效：赵、王二氏报道用上方治疗本病数例，~~其~~用方便，疗效显著。病例：范××，男，23岁，1988年5月6日诊。3天前，初起腰间出现米粒大丘疱疹，密集成簇，患部刺痛。1天过后，疮疹变大如绿豆，个别如黄豆大，出现水泡。现水泡三五成群，集聚数处，排成带状，如腰束带，疼痛异常，伴身困乏力。舌质红，苔黄厚腻，脉滑数。诊为缠腰火丹。用上法共换药3次而愈。

验证：笔者用上方验治4例，颇有特效。病例：张××，男，51岁，右侧腰部出现米粒样水泡，疱液透明，累累如串珠，并有灼热刺痛感，呈带状排列，多个医生确诊为缠腰火丹（带状疱疹）。用西药治效果不显，后用上方2次而愈。（朱培训，博兴县阎坊分院。）

按：六神丸是《全国中成药处方集》中雷氏方。是一张解毒、消肿、止痛，治疗烂喉丹痧、乳蛾、咽喉肿痛等症的方剂。但治疗此病，方书中均未记载。效果显著，是因这种病多属湿热毒邪为患，而此药性寒凉，解毒力强，又加外用，可直达病所，故有速效。

92. 跌打损伤

方名：创伤外洗方

来源：丁源，《中医验方汇选》，1972；(12):194。

组成：当归尾6克、川芎9克、大黄6克、红花6克、木瓜9克、杜仲9克、川牛膝6克、川续断9克、血竭9克、透骨草9克、炒穿山甲9克、赤芍6克、乳香9克、没药9克、煅自然铜9克。

用法：上方水煎60分钟，放在盆内熏洗患处，一剂可洗2~3次，每日1~2次，洗至不痛为止。

主治：跌打损伤，青红肿痛、不能行走。

疗效：丁氏介绍，洗后觉轻快，痛减肿消，没有任何其它反应。病例：傅×，被大车轧伤右足，医院检查骨膜受伤，肿痛不能行走，用上方洗10余日即能行路。

验证：笔者用上方验治跌打损伤初期致使肢体关节红肿疼痛者196例，83%的患者6天痊愈，17%10天痊愈，无一例不效者。还用上方加水醋各半水煎外洗，治久伤后期关节屈伸不利者76例，92%的患者15天痊愈，8%40天痊愈，病例：患儿李××，男，7岁，滨州市人，左肱骨外髁骨折行闭合复位克氏针内固定术后50天，左肘强直于45°位。经用上方水醋各半煎熏洗，21天左肘关节活动范围50~120°，近正常功能。（石宝营，惠民地区中医院。）

按：本方意在活血通络，消肿止痛，通利关节，药品无不恰当。治创伤初期，妙在透骨草一味，可引诸药力从皮毛渗入筋骨合乎佐使之要义。治久伤关节不利，加醋煎洗，以取酸能软坚之效。但应注意，外伤24小时之内切勿用本方熏洗，否则肿痛不但不消，反而加重，

93. 肥大性脊柱炎

方名：腰痛方

来源：邹云翔，《新中医》，1980；(6)：19。

组成：全鹿丸9克(分吞)、巴戟天9克、淡苁蓉9克、金毛狗脊12克、制附子3克、炙黄芪6克、酒川断9克、炒杜仲12克、甘杞子12克、炒独活3克、黑芝麻15克、拌炒苍术4.5克、桂圆肉9克、陈皮4.5克、法半夏4.5克、云茯苓9克、薏苡仁9克。

用法：水煎服。

主治：腰痛(肥大性脊柱炎)。

疗效：病例：卢××，男，52岁，干部，1963年3月5日初诊。患者近五、六年来经常腰痛，转侧不利，经某医院X线摄片证实为胸腰椎肥大性炎症，经用中西药治疗，理疗和针灸等效皆不著。入冬以来，腰部痠痛不能久立，近1个月来几乎不能步履，头痛便秘，脉象沉细苔腻症属下元不足，血虚液方亦挟湿邪内蕴，方拟温运下元养血润燥，佐以宣湿和络。服上方10剂时腰痛基本消失，步履如常，大便通畅。

验证：许氏1980年2月，患了腰痛病(肥大性脊柱炎)，经多次治疗效果不佳，经用上方治疗，服了10剂中药，病情很快好转，得到控制。后服20剂而痊愈。(许华，《新中医》，1989；(4)：封三。)

按：腰痛是临床上颇为常见的病症。它可由多种疾病引起。上方对由肥大性脊柱炎等病引起的腰痛，证属肾阳虚衰

下元不足挟有湿邪为宜，其他原因引起的腰痛应详审病因，辨证施治。

94. 损伤性腰腿痛

方名：腰腿痛方

来源：徐代源等，《新中医》，1982；（7）：20。

组成：丝瓜络10克、落得打15克、黄芪15克、当归12克、川续断12克、怀牛膝10克、算盘子15克、木瓜10克、秦艽10克、独活10克、炙甘草6克。

用法：水煎分早晚2次服。每日一剂。上方用于急性期，慢性期加附子6克，桂枝6克。

主治：损伤性腰腿痛。

疗效：徐氏等用上方治19例损伤性腰腿痛，均治愈。其中服二剂治愈3例，服三剂愈者11例，服五剂愈者5例，1980年底追访，均无复发。病例：段××，女，34岁，于1978年5月16日中午发病。右手提水时，突然腰部“咔嚓”响声，即感剧痛，并有串麻痛经臀部沿大腿、小腿外侧放射到足外侧，腰不敢直立，步行缓慢，卧床休息，日常生活不能自理，大声喊叫、久站、久坐及咳嗽时腰痛加剧。经用西药等治疗2天，疼痛无缓解。改用上方，一剂痛大减，连服三剂，症状和体征消失，再服二剂以巩固疗效，迄今2年，未见复发。

验证：王氏用上方验治外伤性腰腿痛，效果很好。病例：吴××，男，47岁，农民。因提重物扭伤腰部，1年多来腰痛缠绵不愈，腰肌紧张，压痛明显，经某医院先后用激素、

普鲁卡因局部封闭及口服去痛片、BV₁等药不效，经用上方五剂即腰痛消失，最近随访，未见复发。(王贤新，《新中医》，1984；(9)：封三。)

按：外伤性腰腿痛是一种常见病。多以受伤时呈闪电样腰痛，并向臀部经大腿、小腿外侧放射至足外侧及足小趾有串麻痛为主症。中医认为病机是气滞血瘀，经络不通，不通则痛，上方中用丝瓜络、川续断、怀牛膝、木瓜、秦艽、独活、当归祛风通络、活血止痛，黄芪补气以取推动血液循环的作用。其中算盘子为大戟科植物算盘子的果实，味苦性凉，《四川中药志》中记载：“治气痛，腰痛。落得打又叫积雪草为伞形科植物。出《神农本草经》。味苦平性凉有清热解毒，散瘀止痛等功效。用甘调和诸药，缓急止痛，诸药合用，使瘀散络通则肿痛麻木自消。

95. 脊 髓 痹

方名：地黄饮子

来源：印会河，《新中医》，1985；(6)：16。

组成：熟地10克、山萸肉10克、石斛10克、麦冬10克、五味子6克、菖蒲6克、远志4.5克、茯神10克、淡苁蓉10克、肉桂6克、熟附片10克、巴戟天10克、(原方有薄荷、生姜、大枣，也可不用)。

用法：水煎服。

主治：脊髓痹（瘖厥风痺）。

疗效：印氏和先父用此方治愈许多“风痺”患者。临床有效率在80%以上。1957年曾治愈一姓李患瘖厥风痺的女

病人。

验证：简氏用上方验治 2 例风痺病人均效。病例：金××，男，65 岁，退休干部。近两年来常感头昏眼花，走路不稳，如踩棉花，手中的香烟、筷子会不自主掉下。患者右上肺呈浸润肺结核。曾按眩晕、美尼尔氏综合征等病给予中西药治疗罔效，经用上方七剂明显好转，再投七剂，上述症状均消失，随访至今未见复发。（简秀成，《新中医》，1988；（4）：封三。）

按：风痺是中医病名，属西医的“脊髓痨”，多由晚期梅毒和结核杆菌侵害脊神经，致使失去正常功能而成。其主症是“四肢不收”即手足不能由自己的意识控制，走路不稳，东歪西斜，甚至摔倒，或走路时如踩在棉花上。手也不自主，手中碗筷等物掉而不觉。若侵害到上部脊髓，就会出现语言不利，说话困难，这便是中医所说的“瘖厥”，与四肢不收同时并见的中医称为“瘖厥风痺”。地黄饮子本是刘河间《宣明论》中的方剂，经印氏父子等人临床应用，对“脊髓痨”这种疑难顽症，有明显的疗效。

96. 骨质增生

方名：白芍木瓜汤

来源：王之术，《新中医》，1980；（1）：18。

组成：白芍30克、木瓜12克、鸡血藤15克、威灵仙15克、甘草12克。

用法：水煎服，每日一剂。颈椎：加葛根12克；胸椎：加狗脊12克；腰椎：加杜仲12克，怀牛膝12克；膝以下关

节：加怀牛膝12克。效不显白芍可逐渐加至60克，若有腹泻加炒白术15克，茯苓12克。

主治：骨质增生症。

疗效：王氏报道用此方治疗本病160例，痊愈109例（68.2%），显效42例（26.2%），进步9例（5.6%）。服药剂数最少三剂，最多100剂。病例：高××，男，47岁，腰痛27年，病情反复，严重时卧床不起。曾经针灸等各种治疗，始终未愈。腰椎X线片：腰4~5椎体前后缘均有增生性改变，腰与椎右缘较著，生理曲线消失，印象：腰椎增生性脊椎炎。经用上方加杜仲、牛膝服20剂痊愈，随访2年未见复发。

验证：王氏用上方验治12例骨质增生患者，疗效满意。病例：杜×，男，54岁，会计，1982年5月10日就诊。患者于1981年12月患右肩关节疼痛，初不介意，致日趋严重。1982年2月右臂活动不能自如，抬手不能及头，穿衣困难，睡眠不宁。经摄片检查，诊为“颈椎骨质增生”，给予骨宁针、骨刺片治疗2个多月，痛仍如故，遂投白芍木瓜汤加桂枝9克，粉葛、丹参各12克，升麻6克。三剂而痛减，再进五剂，痛已基本消除，寝能眠，臂能抬举触头，更衣自如，再进五剂而告痊愈，追访至今未复发。（王恩浩，《新中医》，1989；（10）；封三。）

钟氏等用此方验治9例肘关节骨质增生均收良效。病例：梁××，女，53岁，搬水泥后右肘肿痛，屈伸受限7日，1981年9月15日就诊。检查：右肘轻度肿胀，鹰咀附近压痛，伸肘135°（邻肢夹角法），屈肘80°，总活动度55°。经X线照片诊为右肘骨关节病，服上方21剂后症状消失，随访3

年无复发。(钟士元等,《新中医》,1985;(3):封三。)

按:骨质增生是一种常见病,尤以40岁以上的中老年人多见。主要发生于颈椎、腰椎、膝关节及跟骨等。属中医“痹证”、腰痛等病的范畴。证属风寒湿邪,阻塞经络,气滞血瘀,肝肾亏损。此方以芍药缓急止痛,味酸软坚,具有软化骨刺之功,木瓜舒筋活络,鸡血藤性温补血活血,威灵仙味辛咸性湿,通行十二经,发散风湿,舒筋活络亦有软化骨刺之效。甘草缓急止痛,调和诸药,上药合用有补肝肾、舒筋脉、散瘀血、软坚缓急而止痛之功效,再依骨质增生部位不同,酌加不同药物,故对各种骨质增生症有明显疗效。

97. 痛 痹

方名:痛痹方(编者加)

来源:王长洪等,《中医杂志》,1982;(2):15。

组成:川乌5克,麻黄10克,桂枝6克,白芍6克,酒当归10克,地龙10克,木瓜10克,甘草5克。

用法:水煎服。

主治:痛痹(疼痛较剧,遇寒更甚,局部不温,舌黯不红等)。

疗效:上方是董建华老中医治疗痛痹的经验方。病例:郭××,腰骶疼痛如掣,向下肢放射,不能直立步履已有2个月,夜间疼痛尤剧,形寒肢麻,肢端不温,舌黯苔白,脉沉细。西医诊断为“坐骨神经痛”。投上方六剂,服后腰痛大减,已能直立,守方加鸡血藤20克,又进六剂,疼痛缓解,已能独立行走。

验证：姚氏用上方验治痛痹2例，收效颇良。病例：梁××，男，55岁。因右大腿剧痛5天，不能忍受，步履艰难，于1982年5月4日入院。经对症治疗5天，疼痛未减，转中医科治疗。望其舌苔白，脉沉细，经用董老“疏濶阴破沍寒”治疗痛痹之法，处方用：制川乌、麻黄各6克，细辛3克，木瓜、当归各12克，白芍、独活、桃仁、白芥子各9克，鸡血藤30克，红花、甘草各6克，服3剂后疼痛减轻，活动自如。继用原方四剂，痊愈出院。随访5个月，未见复发。（姚越健，《中医杂志》，1983；（1）：78。）

按：上方是由《金匱》乌头汤加味化裁而成。乌头除寒开痹，善入经络，力能疏通痼阴沍寒，配麻黄宣透皮毛腠理，二药一表一里，一温一散，内外搜散，止痛甚好，桂枝温通经脉，地龙活血通络，当归养血和血，白芍、甘草、木瓜酸甘缓急，诸药合用，对痼阴沉寒凝于经脉之痛痹尤为适宜。

98. 坐骨神经痛

方名：蝎蛇散

来源：陈三立等，《新中医》，1987；（3）：25。

组成：乌梢蛇、蜈蚣、全蝎各10克。

用法：将上药焙干研成粉，等分成8包，首日上下午各服1包，继之每日上午服1包，7日为一疗程。两个疗程间隔3~5天，一般1~2个疗程可见显效至痊愈。药后无重大反应，一般在药后可有全身及患肢出汗或灼热感，有的可出现短暂性的疼痛及麻木加剧，不久即消失。

主治：坐骨神经痛。

疗效：陈氏等报道用上方治疗本病54例，治疗期间停用其它药物，经长期观察随访，疗效满意。病例：范××，男，37岁，干部。患坐骨神经痛3次住院治疗，效果不显，腰椎摄片未见异常，于1974年1月来诊。检查：表情痛苦呻吟不止，弯腰曲背不敢活动，脊柱向右侧弯直腿抬高左侧20°，坐骨神经干压痛明显，符合坐骨神经诊断。住院经激素、维生素等治疗无效，改用上方服药两个疗程，症状完全消除，痊愈出院。随访9年未再复发。

验证：杜氏用上方验治20例，疗效颇佳。病例：蔡××，女，68岁，右下肢疼痛3年多，经西医诊断为坐骨神经痛，服西药效不显，经用蝎蛇散原方治疗两个疗程痊愈，随访至今未复发。（杜长江，《新中医》，1990；（1）：封三。）

按：坐骨神经痛属祖国医学痹证范畴。多由风寒湿邪闭阻经络，不通则痛。方中乌梢蛇能祛风湿，通经络，并善治风湿顽痹，肌肤麻木；全蝎、蜈蚣通经散结，活络止痛。三药皆为虫类药物，均为搜剔入经入络在筋骨日久之风寒湿邪，合用故对风湿顽痹及神经痛、关节痛均有良好作用。

99. 坐骨神经痛

方名：皂独附姜汤

来源：吕广振，《山东中医杂志》，1982；（6）：338。

组成：皂刺30克，独活9克，附子9克，肉桂6克，姜黄15克，苍术15克，薏仁30克，防己9克。

用法：水煎服。

主治：坐骨神经痛（风寒湿型）。

疗效：吕氏用皂刺为主药加味治疗坐骨神经痛7例（其中干性4例，神经炎1例，根性2例），痊愈5例，显效2例。一般服药六至九剂，最多15剂。病例：夏××，女，42岁。患者在田间摘豆角，突然从左侧腰臀部沿坐骨神经通路有触电样疼痛，放射至左足跟，当即倒下，不能活动，被抬回家中，经治疗后，疼痛缓解，但仍不能动，着凉加重，得热痛减，食欲、二便正常，舌苔薄白，脉沉弦。诊为痹证（风寒湿型）治宜祛风除湿，散寒止痛，以皂独附姜汤加川芎9克，威灵仙9克，服三剂，疼痛大减，继服上方六剂，日渐痊愈。2年后随访未再复发。

验证：吕氏用上方验治于临床，确有疗效。病例：于×，男，52岁，农民。1983年1月5日初诊。患者素有腰腿痛已5年多，反复发作，缠绵难愈。多方就医，曾诊为“风湿性腰腿痛”“关节炎”等病，屡用中西药治疗，其疼痛只能暂时缓解，但不能根治，每因劳累、遇风寒而诱发并加重。此次发作，正值寒冬腊月，由于外出赶集不慎感冒，除头痛、发热、咳嗽、咽痛外，又觉腰腿痛加剧，尤以左侧腰臀部沿坐骨神经走行方向至足跟部呈放射性疼痛加重，得热痛减，转侧活动均受限制，睡眠欠佳，舌苔薄白，脉沉紧。辨为痹证，属风寒湿型，用上方加减，服三剂，疼痛大减，腿可活动，腰可翻转。另加寄生15克，狗脊15克，继服10剂而愈。随访半年未见复发。（吕建光，《山东中医杂志》，1984；（2）：46。）

按：坐骨神经痛是现代医学的病名，据其表现属祖国医学痹证范围。吕氏依据风寒湿邪侵入经脉，致气血运行不畅的道理，以皂刺为主药随证加味而收满意效果。皂刺味辛性

温，具有活血祛风消痈之功，原为治疗外科疾病之要药，吕氏重用皂刺治坐骨神经痛，可使血活风除络通，气血畅行而痛止。如属风寒湿型，配附子、肉桂、姜黄温经散寒止痛，苍术、薏仁、防己、独活祛风除湿而止痛。

100. 腹壁静脉炎

方名：血府逐瘀汤加减

来源：王世录，《新中医》，1990；(6)：40。

组成：当归、桃仁、熟地黄、川芎、柴胡、赤芍、五灵脂、醋延胡、桂枝各10克，川牛膝、枳壳、红花各15克，丹参20克，黄芪30克。

用法：水煎服。

主治：胸腹壁静脉炎、血管神经性头痛、血瘀胸痛及乳腺增生等病证。

疗效：王氏报道近几年来用上方治愈1例右侧胸腹壁静脉炎，5例血管神经性头痛、2例乳腺增生，9例胸痹。病例：王×，男，30岁，工人，1987年2月28日就诊。患者右胸肋至上腹部疼痛3个多月，痛如刀刺，固定不移，胸中烦闷，面色无华，体倦乏力，寐则多梦，胃纳尚可，二便调畅。经多方医治效果不佳。请余诊治。检查：从右侧胸部第八肋间至右上腹部皮下可见一条约30厘米长蚯蚓状条索物，质较硬，直径3毫米，色泽黯淡，触之疼痛，推之可移，双手按其两端呈凹陷状，舌黯淡，苔薄白，脉沉细弦。诊为右侧胸腹壁静脉炎，属中医恶脉范畴。证属气血两虚，气滞血瘀，络脉不通。投上方服六剂后，自觉症状大有改善，继服

15剂,诸证悉除,蚯蚓状条索物也随之消失。

验证:韩氏等用上方验治腹壁静脉炎患者,确实有效。

病例:李××,男,57岁。1990年9月16日来诊。一星期前,患者自觉左腹部疼痛未注意。后摸到一条索状物,疼痛,渐由轻到重,短变长,细变粗。经用抗菌素及万花油外敷治疗效果不佳,前来就诊。症见左腹部有一条约15厘米长,直径约5毫米的条索状硬物,局部皮肤正常。自觉有牵扯性针刺样疼痛,纳食、夜寐均可,二便正常。舌质淡黯,边有齿痕,苔黄腻,脉弦滑。证属瘀瘀阻滞,脉络不通。治以健脾祛瘀,活血祛瘀,投以血府逐瘀汤合二陈汤加减(黄芪、白术、陈皮、茯苓、半夏、枳实、胆星、银花、蒲公英、穿山甲、土鳖、延胡、川芎、当归、红花、桃仁、怀牛膝、甘草),服九剂后,局部静脉较前变细变软,疼痛减轻,依上方加减,继服九剂后,局部静脉条索肿痛消失。(韩法涛等,《新中医》,1991;(5):封三。)

按:按腹壁静脉炎的临床表现(痛有定处,痛如针刺,肿块,舌质紫黯),属中医的瘀血范畴,故用王清任《医林改错》的血府逐瘀汤而奏效。方中用桃仁、红花、赤芍、川芎等活血祛瘀,配合当归、熟养血补血,使瘀血去而又不伤血;柴胡、枳壳疏肝理气,使气行则血行,牛膝破瘀通经,引瘀血下行,酌加黄芪补气以行血,桂枝温运气血,诸药合用,活血祛瘀,行气止痛。对由瘀血引起的疑难病证不妨一试。

101. 鹤 膝 风

方名：四神煎

来源：陈可冀等，《中医杂志》，1981；(3):14。

组成：生黄芪240克，川牛膝90克，远志肉90克，石斛120克，金银花30克。

用法：先煎四味，用水约1500毫升，煎至2碗，再加入金银花30克，煎至一碗（150毫升），顿服。

主治：鹤膝风，膝关节红肿疼痛，步履维艰。

疗效：陈氏等用上方治疗此病，多获良效。

验证：单氏用上方验治鹤膝风数例，均收效满意。病例：陆××，女，34岁，农民。1981年4月26日初诊。患者双下肢酸痛数年，近2个月始见双膝肿大，股、胫骨肌肉萎缩，曾用抗菌素、激素、糜蛋白酶等治疗，均未见效。又于膝关节囊处每天抽液150毫升（一侧）左右，已抽10余次，症状未见减轻，以至步履艰难，不能站立，双膝肿大，形如鹤膝，按之绵软，皮色不红，局部微热，二便正常。舌质淡红苔薄白，脉弦细。伴头晕心悸，口淡食少，神疲乏力。双侧膝围均41.5厘米。膝部X线摄片见软组织肿胀，关节间隙增宽。中医诊为鹤膝风，经上方八剂，膝肿基本消失，膝围为37.5厘米，饮食增加，并能行走5华里，唯膝部有轻微酸痛。将原方改为丸剂，早、午各服15克，晚服肾气丸10克，调治1个月，膝围36厘米，股、胫骨肌肉已渐丰满，诸症痊愈如常人。随访半年，未见复发。（单会府，《中医杂志》，1984，(7):79。）

按：鹤膝风是以膝关节肿大疼痛，而股胫的肌肉消瘦为

特征，形如鹤膝，故名鹤膝风。类似急性风湿性关节炎，类风湿性关节炎，化脓性关节炎等疾患。上方药简量大，功专效宏。特别是黄芪一药重用，以取扶助正气统领诸药直达病所，蠲痹除疾，祛而外出。牛膝祛风湿，利关节，强筋骨，通气血，善治膝痛不可屈伸。石斛益精强阴，亦有健腰膝，除痹痛之功。远志补益心肾，银花为清热解毒之妙品，是为风寒湿邪内蕴化热，关节红肿而设，且可制约黄芪温热之性。诸药配伍，扶正之力甚强，祛邪之功亦著，故收速效。

102. 关节扭伤

方名：鲜土牛膝外敷方

来源：陈师农，《新中医》，1986；（9）：56。

组成：鲜土牛膝适量。

用法：将上药捣烂涂敷患处，加少许食盐和匀，外用绷带固定，每日1次。

主治：踝关节扭伤。

疗效：陈氏用上方治疗21例均愈，轻者1次，重者2次即效。病例：程××，女，20岁，大学生，1983年4月17日就诊。右足外踝内翻扭伤，局部明显肿痛，行走困难。用上药捣烂外敷。第二天即好转，再敷一次痊愈。

验证：罗氏用上方验治踝关节内翻扭伤18例，外翻扭伤8例，腕关节扭伤3例，共29例均收到良好的效果。病例：吴××，男，27岁，农民，1987年6月18日就诊。因担尿灌秧苗，路滑，摔了一跤，导致右足外踝内翻损伤，局部明显肿痛，行走困难。用上药捣烂加少量白酒外敷，第二天肿大

消，行走觉轻微疼痛，再敷1次遂愈。(罗朝阳，《新中医》，1989，(6)：封三。)

按：土牛膝苦酸性平，活血散瘀，祛湿利尿，清热解毒。《江西草药》中载：“治跌打损伤，土牛膝三至五钱，水煎酒对服”。陈氏用鲜土牛膝捣烂外敷局部收效更佳。

103. 血栓闭塞性脉管炎

方名：活血化瘀方

来源：方一汉，《新中医》，1986，(3)：37。

组成：第Ⅰ期方：川芎、桃仁、红花、丹参、鱼腥草、蒲公英、野菊花、陈皮各10克，地龙6克。

第Ⅱ期方：川芎、桃仁、佛手、红花、地龙、穿山甲、陈皮各10克，枳壳6克，蜈蚣2条。

用法：水煎分3次服，每日一剂，每周用三~五剂。

主治：小腿血管性疾病（血栓闭塞性脉管炎等）。Ⅰ期方主要用于病程短，皮损鲜红，炎症明显者；Ⅱ期方主要用于病程长，皮损暗红，结节及索状物较硬，久治不愈者。

疗效：方氏报道治疗20例，痊愈12例，显效6例，无明显改善者2例，总有效率90%。病例：曲××，男，50岁，干部，患者病程10年。主要是双小腿踝部以下疼痛，病初伴间歇性跛行，1976年左脚第四趾溃烂，在某医院诊为闭塞性脉管炎住院治疗。1984年4月因伴发小腿血栓性静脉炎而来诊。见右小腿有3条索状物，每条索状物约有10~12厘米长，已经10余天，隆起皮肤表面，发红疼痛，双足趾均发红或发绀、发冷，右足背动脉搏动微弱，疼痛明显。治疗采用第Ⅰ期方服用20剂，后索状硬物明显缩短，色红减退，疼痛

减轻。改用第Ⅱ期方服药15剂，条索状硬化物及疼痛全消。双足趾皮色温度基本恢复正常，足背动脉搏动增强，小腿血栓性静脉炎达到临床治愈，其闭塞性脉管炎症状明显改善。治疗80天服药40剂，服药期间配合服丹参片或三七片。

验证：王氏用以上二方验治5例周围血管性疾病，均取得满意疗效。病例：高××，女，农民。患者病程18年。初为左小腿踝部以下瘀痛伴间歇性跛行，1985年左脚第三、四趾溃烂，在北京某医院诊为血栓闭塞性脉管炎，并劝其截趾。患者因惧怕手术而来诊。见患者左小腿明显漫肿，左小腿中部有3条各约8~10厘米的条索状物，沿静脉走行分布，隆起于皮肤表面，触痛发红，并有3处绿豆大皮损，有少许渗液。左足趾背延及两踝发绀发冷，左足第三、四趾各有2个似麦粒大小的溃疡点，有少许脓液且臭。左足背动脉搏动微弱。舌质紫暗，且布满瘀点瘀斑。诊为血栓闭塞性脉管炎并小腿血栓性静脉炎。先用第Ⅰ期方，每周三~五剂，服完18剂后，病情趋于稳定。改用第Ⅱ期方，服28剂后，条索状物全消，左足趾溃疡愈合，皮色皮温正常，左足背动脉搏动增强。小腿血栓性静脉炎得到临床治愈，闭塞性脉管炎得到明显改善。为巩固疗效，继服活血通脉胶囊半年，于1989年10月4日随访2年未复发。

按：小腿血管性疾病可包括血栓性静脉炎、血栓闭塞性脉管炎及结节性红斑等。以小腿有鲜红、暗红结节，或条索状硬物，隆起于皮肤表面，数目不等，自觉疼痛明显，并有压痛为主症。祖国医学认为血瘀则凝，凝则不通，不通则痛，凝则聚集则成结节。初期红肿则为热象，炎症明显故用活血化瘀，兼以清热解毒，而后期久治不愈者，除用活血祛瘀外，

加用通络散结的地龙、穿山甲、蜈蚣等虫类药，再者，血凝则气阻，气行则血行故方中加入适当行气之品，以提高疗效。

104. 急性淋巴管炎

方名：白薇苍术汤

来源：孙旭升，《新中医》，1989；(6)：3。

组成：白薇30克，苍术10克。

用法：加水2碗，煎成1碗，1次顿服，药渣捣碎敷患处，日一剂，连服2日。

主治：红丝疔。(急性淋巴管炎)。

疗效：孙氏用上方治疗红丝疔24例，全部治愈无一例走黄，用药1至2天止痛，随后红肿消退，病例：刘××，男，24岁，1985年4月23日就诊。2天前劳动时左足底被扎伤，至今日中午足底疼痛难忍，足背红肿，予上方后当晚痛止神安，第二天肿消热退。

验证：兰氏用上方验治4例红丝疔，疗效显著。病例：易××，男，18岁，农民，1987年7月28日就诊。右足背被木头撞伤，次日局部红肿疼痛，伴发热，头晕，舌苔薄黄，脉象略数。投上方加味（白薇30克，苍术9克，金银花20克）一剂治愈。(兰友明，《新中医》，1990；(6)：56。)

按：红丝疔见《证治准绳》。又名红线疔、血丝疔。多因火毒凝聚或破伤感染所致。多起于手足，初起局部红肿热痛，继而红线由上臂前侧或小腿内侧向上走窜，重者可伴寒热、头痛、乏力。相当于急性淋巴管炎。白薇性味苦寒，有清热凉血，解毒疗疮之效，苍术可起祛风散寒燥湿，使火毒

由表而解。本方具有效优价廉，简便易行等优点。

105. 下 肢 溃 瘍

方名：枯矾猪甲膏

来源：侯志民，《新中医》，1989；(3)：11。

组成：枯矾一份，猪甲粉三份，海螵蛸一份，冰片少许，麻油适量。

用法：用麻油或蜂蜜将四味药调成糊状。把创面用双氧水清洗，去除脓性物，将药均匀敷于疮面上，外用纱布包扎。一周后换药，此时可见新生肉芽组织，第二次以后3天换药1次，以后每日换药1次至痊愈。(首次敷药局部可见疼痛，不需作其他处理)，

主治：下肢溃疡。

疗效：侯氏几年来用上方治疗16例，一般5~10次即愈，均未见复发。病例：李××，女，42岁，农民。患左下肢象皮肿10余年，因打柴刺伤小腿前侧，形成慢性溃疡，经外用中西药治疗2年未愈，创面恶化，溃疡面积达20×6厘米。深处达骨膜，腐烂恶臭，边缘不整，周围皮肤变硬呈紫红色，经用上法治疗10次痊愈，2年后走访，未见复发。

验证：赵氏用上方验证治愈2例。病例：冯××，男，55岁，农民。患右下肢溃疡18年，经外用中西药治疗数次未愈。1974年经县医院手术治疗，仍不愈。现右下肢溃疡面积约20×10厘米，深达骨膜，边缘不整，创面腐烂恶臭，周围皮肤变硬呈紫黑色。经用枯矾猪甲膏治疗二周痊愈。随访6个月未复发。(赵应鸾，《新中医》，1990，(5)：56。)

按：下肢溃疡多发于小腿下1/3处，踝上三寸内臃或外臃的地方，俗称“臃疮腿”。特点是溃面久而不敛，轻微损伤即能使之复发。方中以枯矾收湿止痒，解毒医疮；海螵蛸外用有燥湿生肌止血之效；猪甲咸平，炒用可治冻疮湿疹；冰片、麻油有防腐止痛之功，调糊局部直接外敷收效迅速。

106. 无名肿毒

方名：甘遂芫花甘草散

来源：潘冬旺，《新中医》，1988；(7)：14。

组成：甘遂，芫花，甘草，天仙子各适量。

用法：将甘遂、芫花放入铁锅内炒干后碾碎成末状，与天仙子拌均匀，放入一小碗内；把甘草浸泡水煎沸，待凉后倒入盛上药的小碗内，使药末及天仙子调拌成膏状，根据红肿疼痛范围的大小将该散外敷在患处，用敷料包扎固定，待散剂水份被吸收干后，再倒上少许甘草水，一日6~8次，保持散剂呈湿润状态。

主治：无名肿毒。

疗效：潘氏用上方外敷治疗无名肿毒37例均获愈。病例：刘×，女，30岁，干部，1985年10月17日就诊。因左侧臀部疼痛，继发局部红肿，左脚行走困难，全身发热4天。曾入某医院肌注青霉素及红霉素加氨苄青霉素静脉点滴未见好转。查：体温39.7℃，左侧臀部内上有一个4×18厘米的红肿范围，触痛明显，尚无明显波动感，停用它药，改用上方外敷18小时后，患部中央破溃，流出乳白色粘稠状脓液约100毫升，局部用药棉擦净，碘酒消毒，按上方另取一散剂

外敷，第三天痊愈。

验证：兰氏等用上方验治于临床效果可靠。病例：林××，男，42岁，农民，1988年12月2日就诊。右侧臀部红肿疼痛3天（约一酒壶口大），经肌注青霉素未效，经用上方外敷，停用西药，12月3日复诊，患部破溃流出黄白色粘稠液颇多，病减大半，再敷一料，病遂告愈。（兰友明等，《新中医》，1989，（8）：56。）

按：无名肿毒见《医学入门》，是体表局部骤发肿痛的一种证候。因其随处可生，无适当名称，故取其名。多因内有郁热，或感受外邪风毒而发。甘遂、芫花外用有消肿散结之效，天仙子味苦辛性温有大毒，有解痉止痛等作用，甘草清热解毒。注本方甘遂、芫花、天仙子均有毒，甘遂反甘草，故此方只宜外敷，不能内服。

107. 手 癣

方名：治鹅掌风、灰指甲验方

来源：曲云飞，《中医杂志》，1981，（12）：39。

组成：鸦胆子20克（打碎），生百部30克，白酒、醋各半斤。上为治疗一只患手的用量，如患两手，药量加倍。

用法：将药及酒、醋共放入大口瓶内，密闭，浸泡10天后备用。用时将患手插入瓶中浸泡（浸泡过程中注意尽量减少药液的挥发），每次浸泡30~60分钟，每日2~3次。泡至第六、七天时，患手皮肤将变得红嫩而薄，此是将愈之兆，不须顾虑，当继续浸泡至愈。

主治：手癣（鹅掌风、灰指甲）。

疗效：上方是著名老中医倪平佛治疗手癣的验方，多数患者浸泡11~12天即痊愈。

验证：刘氏用上方验治9例鹅掌风，一般用药1~3剂获愈。病例：张××，男，48岁，干部。右手患鹅掌风已5年，皮肤粗糙，厚如胼胝，入冬皲裂，遇冷水倍感痛楚，影响工作和休息，经多方中西药内服外擦治疗无效，笔者获此方后去登门治疗，患者因病久不愈失去信心，勉强接受了这一简易治疗。先后用药3剂浸泡30次，患手临床治愈，至今8个多月再未复发。(刘端起，《中医杂志》，1982；(12)：72。)

按：手癣也称鹅掌风，是一种发于手掌的皮肤病。初起皮下小水泡，搔痒，以后叠起白皮而脱屑。日久则皮肤粗糙变厚，入冬皲裂，疼痛，若日久不愈也可蔓延至指甲，使甲板失去光泽，变形增厚。鸦胆子苦寒，内服杀虫止痢，善治阿米巴痢疾，外用有解毒疗疮，腐蚀赘疣等作用，百部有杀虫抗菌作用，对真菌有一定抑制作用，疗癣常用，醋能软坚防腐，酒能活血，并能使有效成分浸出，坚持按时浸泡患手，可使手癣顽疾获愈。

108. 手足皲裂症

方名：手足皲裂验方

来源：王永茂，《新中医》，1983；(1)：47。

组成：当归、紫草各60克，忍冬藤10克，麻油500克。

用法：将上药共浸麻油内，浸泡24小时后文火煎熬至药枯焦，滤出药渣，留油待凉，棉棒蘸涂患处，每日数次至愈为止。

主治：手足皲裂症。

疗效：上方经王氏多年应用疗效较好。病例：沈××，女，26岁，服务员，于1979年底患病，多次去外地诊治，确诊为手足皲裂症。曾服养阴润肤中药数剂，西药维生素类，外用油膏类均无效。1980年4月3日初诊：双手掌指端、足底及足趾部均布满纵横、深浅不等裂隙，手伸握深痕有血出，生活不能自理，体重明显减轻。经用上法两料外涂，历经月余痊愈。1年后随访未见复发。

验证：陆氏用上方重复验证10余例手足皲裂症，均有卓效。病例：史××，女，35岁，两足皲裂已4年，裂处达10多处，每年冬春数月，走路疼痛，艰难跛行，经用上方，1天疼痛即止，2~3天后足部大小皲裂先后愈合，数天后，洗脚时陆续脱一层粗糙皮屑，皮肤光滑，患者欣然。（陆文生，《新中医》，1984，（10）：封三。）

按：本病多见于秋末冬初，多由寒冷、风燥所侵，致使血脉阻滞皮肤干裂。方中当归有养血活血，逐瘀血而生新血之功；忍冬藤清热解毒兼疏风通络；紫草凉血解毒；再配以麻油滋润皮肤，故对此症有效。

109. 骨 髓 炎

方名：解毒生肌膏

来源：梁铁民，《临床正骨学》，1978；（8）：266。

组成：当归15克，白芷15克，紫草15克，生地15克，黄芩15克，蜂蜡90克，麻油360毫升。

用法：先将前五味药入麻油内炸枯去渣，再入蜂蜡熔化

过滤，高压灭菌，备换药用。

主治：骨髓炎后期，褥疮等（痈肿疮疡久不收口）。

疗效：梁氏介绍，此方有解毒排脓生肌作用，主要用于各种疮疡后期，创面久不愈合，能加速愈合作用。

验证：笔者用此方治疗指骨骨髓炎2例，背部褥疮1例，其疮面愈合时间，相对缩短70%。病例：徐××，女，26岁，右手拇指骨髓炎切开引流2个月来诊。检查：右手拇指充血水肿，皮肤颜色紫暗，指腹侧见0.3×1厘米切口，有脓性分泌物；X光示：右手拇指末节骨质稀疏，破坏，有充气影，周围软组织肿胀。经用上方治疗而愈。（石宝营，惠民地区中医院。）

按：方中当归、生地养血，白芷消肿生肌，紫草、黄芩解毒，合用对消除肉芽水肿，加速疮面生肌愈合均有良效。

110. 银 屑 病

方名：银屑散

来源：李文亮，《千家妙方》，下册1982年7月版。

组成：樟丹3克，轻粉3克，铜绿3克，铅粉3克，水银3克，鸡骨1具，杉木750~1000克。

用法：所用鸡骨需用无盐清水将鸡炖烂，剔除全部鸡肉和肌腱。按照通常的中药闷炭的方法，将鸡骨用杉木烧后闷成鸡骨炭（注意切勿将鸡骨烧之成炭），然后将鸡骨炭研成粗末，再与樟丹、轻粉、铜绿、铅粉共研为细末，最后将水银放入再研，使水银研成用肉眼看不到的或刚看到的细小颗粒即可。将上药量均分成14等份，包装好备用（配制后应及

时应用为妥，久存药效降低)。备好酒精灯、支架、石棉网、两根喇叭型长纸筒（长30厘米，粗口径2厘米，细口径0.5厘米）；若无酒精灯可用简易自制酒精灯代之，若无石棉网可用一张薄铁片代之。治疗时先点燃酒精灯，再放上支架和石棉网，网上摊其“银屑散”药粉一份，加热发烟，患者用其喇叭型纸筒吸其药烟，纸筒细口插入双侧鼻孔，粗口对准药烟，用口慢慢呼气，直到石棉网上的全部药物不再发烟为止。如此每天治疗1次，以晚上临睡时为好，一般连续14天为一个疗程。每次吸药烟完后，用清水漱口。

主治：银屑病。

疗效：书中刘、于二位大夫用此方观察治疗共20例，痊愈12例，均为进行期病人，其中病程1年内者9例，1~4年者3例，临床基本治愈4例，均为进行期患者，病程1年以内者3例，1~4年者1例；显效者4例，其中进行期1例，静止期3例，病程1~4年者1例，5年以上者3例。全部有效，治愈及显效率100%。

病例：王××，男23岁，工人，患者因全身皮肤起大小不等的红色丘疹1个多月，于1973年4月来诊。当时检查可见丘疹表面覆有银白色鳞屑，以胸背部分布较密集，大的如玉米粒，小的如粟粒至绿豆大小。自述晚上奇痒，每晚需用热水冲浴一大把食盐洗擦患处后方能入睡。诊断为寻常型泛发性银屑病进行期。按“银屑散”方配制药剂，嘱其回单位自己治疗。治疗10次后，患者亲来告知，全身皮疹均已脱屑，自第三次治疗后就不再作痒。查看其体，果真全身皮疹已失，只留下一些色素。经随访多年，未见复发。

验证：笔者用上方治疗银屑病6例，效果颇佳。病例：

张××，男，28岁，系滨州土产杂品采购供应站工人，患银屑病已3个多月。到外地医院及当地医院都看过，确诊为银屑病，外涂药膏，注射争光霉素等药治疗近3个月无效。于1979年2月13日前来就诊，当时检查，丘疹根基红晕，表面大量灰白色鳞屑几乎遍及全身，背部最多，丘疹几乎连成一片，头部、脸面、双臂及下肢较少，为点片状。余亲自配药一剂分成14包，每日闻熏一包。用药7天，病人即来告知，全身牛皮癣全部消退，只留下一些色素。半年后略有复发现象，再用药7天痊愈，以后未复发。(张连同，滨州医学院附属医院。)

按：笔者1974年于广饶县医院实习时即得知此方，是西营公社一农民介绍，为“鸡骨散”和千家妙方中的银屑散，药物，药量完全相同。但其它方面略有差别，笔者介绍一下自己的制剂和用法供参考。所用鸡骨为纯白毛鸡生骨1具（杀鸡去毛后，用小刀将肉全部割净，保留全部骨质）。将杉木1000~1500克碎成手指粗样木柴，然后将木柴摆放成堆，上面放鸡骨，最后从木柴底部用酒精点燃，等火燃旺用瓦盆盖住，四周用砂或土封严，待凉后取出木炭和鸡骨在盆内共研，加入药物再研至看不见水银为止。分成14包备用。嘱其病人每天用一包放在木板上堆成条状，从一头点燃用鼻吸熏至燃尽。（病人最好单独在一比较小的、封闭比较好的房间内，熏完后即在房内休息）。

注意，“银屑散”因多用剧毒药物制成，对肝脏有一定影响，故肝功能不正常者，慢性肝病者，可禁用、慎用或暂不用。治疗中可给以保肝药物。治疗中有中毒反应者，可酌情减量用药、隔日用药，或停药，同时给以保肝治疗，如静注

高渗葡萄糖、维生素C，维生素B₆等，口服复合维生素B，肝泰乐等药物。

总之，在治疗中要注意尽量能达到治病目的，而又保护肝脏免受损害为妥。为了预防毒性反应，笔者在治疗过程中都让病人服用下方。即：川椒6克、桔梗6克、紫苏10克、甘草10克。水煎服日一剂。因此所治疗的病人，从未发现过毒性反应，而且治疗效果比不服此方者好。此方所起的作用待进一步研究。至于闻熏银屑散的烟雾成份和体内吸收的量的多少及作用机理等亦待进一步研究。

附，汞中毒症状及救治方法，无论内服或外用汞及其化合物，均应严格控制其剂量。一次摄服大量或连续服用中等量时，则每易引起汞中毒。严重的，能够出现剧烈腹痛、便中混血、尿量骤减、呼吸浅弱，脉搏细小、体温下降等现象，最后心脏衰竭而死。中毒较轻的，会出现口齿咽喉肿痛或腐烂，及口臭、流涎、吞咽困难，头疼、心悸、失眠、恐惧、四肢拘挛、皮肤疹块等症状，如迁延日久，则由营养障碍、脱力、感染、败血性热而死。汞中毒的救治方法：（一）由大量内服而引起腹痛的、可用开口花椒30~50克吞下，汞即从大便排出。（二）出现全身肌肉骨节疼痛的用花椒数斤，炒热置床铺席上卧之。（三）出现口齿肿胀腐烂出血的，可用贯众、川连各9克，水煎漱口，并用绿豆、桔梗、甘草煎汤内服。

111. 银 屑 病

方名：克银方

来源：朱仁康等，《中医杂志》，1981；（4）：22。

组成：克银一方：土茯苓30克，忍冬藤15克，山豆根10克，板蓝根15克，草河车15克，白藓皮15克，威灵仙10克，生甘草6克。

克银二方：生地30克，丹参15克，元参15克，麻仁10克，大青叶15克，山豆根10克，白藓皮15克，草河车15克，连翘10克。

用法：一方、二方都是每日一剂，水煎，分2次服。

主治：银屑病（牛皮癣）。克银一方用于血热风燥型。症见皮损基底鲜红或暗红，脱屑发痒，小便黄，大便干，舌质红，苔薄白或薄黄，脉弦滑。克银二方用于血虚风燥型。症见皮肤干燥，或见皲裂，皮损基底暗淡，层层脱屑，发痒轻甚，大便干，舌质暗或淡，脉弦细。

疗效：朱氏等报道108例经3~24周的治疗（克银一方平均七周，克银二方平均八周），痊愈71例，占65.7%；显效15例，占13.9%；进步16例，占14.8%；无效6例，占5.6%。总有效率为94.4%。

验证：李氏单用克银一方治愈3例银屑病。病例：黄××，女，14岁，学生，1981年11月初诊。无明显诱因周身起斑块5天，瘙痒脱屑，周身散在性弥漫性癣块，呈钱币状，脱屑根基暗红，舌尖红，苔薄白，脉滑。诊为银屑病血热风燥型，治以清热解毒，用克银一方六剂后病情好转，继用30剂病即痊愈。（李延超，《中医杂志》，1983；（7）：79。）

按：银屑病又称牛皮癣，相当于祖国医学所称“白疔”，是一种比较顽固的皮肤病。参考银屑病的病理特点，与恶性肿瘤类似。朱氏等采用以清热解毒药物为主的克银一方、二方，取得满意疗效，其作用机理有待于进一步探讨。

112. 皮肤瘙痒症

方名：凉血祛风汤

来源：王振华，《新中医》，1984；（5）：26。

组成：生地30克，白藓皮、玄参、苦参、银花、连翘各15克，地肤子、丹皮、赤芍各12克，紫草、荆芥、防风各10克，升麻、薄荷，生甘草各6克，蝉蜕3克。

用法：上药水煎分2次内服，每日一剂。药渣再水煎汤反复擦洗患处。

主治：皮肤瘙痒症。

疗效：王氏用上方治疗皮肤瘙痒症48例，取得较满意疗效。一般用药二剂即可。病例：叶××，女，17岁，全身性皮肤瘙痒1个多月。搔痒以夜晚尤剧，奇痒难忍，以致彻夜难眠，经用西药抗组织胺药，钙剂及可的松类激素内服并软膏外用，稍有缓解，但停用西药则又复剧痒。患者全身皮肤见致密丘疹，并有抓痕，血痂及色素沉着。舌质淡红，脉弦细。经用二剂瘙痒告愈，继服二剂以资巩固。后未再复发。

验证：李氏用上方验治2例皮肤顽固性瘙痒患者，疗效显著。病例：罗××，男，全身皮肤瘙痒已40多天，经医院中西医结合治疗未效，改用上方一剂次日痒即止，仅二剂而顽痒痊愈。（李思坤，《新中医》，1984；（9）：56。）

张氏多年来也用上方验治多例皮肤瘙痒证，颇效。病例：李×，男，46岁，干部，1985年4月5日诊。全身皮肤瘙痒10余年，经多方治疗不效，经用上方加减一剂痒减，三剂后基本痒止，又进三剂随访未再复发。（张学端，《新中医》，

1988, (10):56.)

按：方中白藓皮，苦参，银花、连翘、荆芥、防风、升麻、薄荷、蝉蜕具有清热解毒，祛风除湿止痒；以生地、玄参、丹皮，赤芍清热凉血，活血祛瘀即取“治风先治血，血行风自灭”之意；生甘草清热解毒，调和诸药。内服外洗，使热毒得解，湿邪得利，血行而风息故瘙痒自除。

113. 皮肤瘙痒症

方名：盐泔洗剂

来源：张开云，《新中医》，1986, (7):51。

组成：食盐100克，米泔（浸泡生米后的水）1000毫升。

用法：把食盐放入米泔水中，置于铁锅内煮沸5~10分钟，然后将药液倒入面盆中，温热以适应为度。用消毒毛巾蘸药液擦洗患部，日2次，早晚各1次，每次擦洗1~3分钟，一般1~2次见效，多则3天。

主治：皮肤瘙痒症。

疗效：张氏用上方治疗本病数十例，疗效较好。病例：孙××，男，51岁，1975年1月3日初诊。周身皮肤瘙痒2年多。从1973年冬季始皮肤瘙痒，先从面部渐及周身皮肤。曾在当地医院治疗罔效，瘙痒抓破仍不解苦，甚至彻夜不寐，伴心慌、烦躁。检查：皮肤干燥，搔痕累累，搔破处血迹斑剥，遂以上法治疗3天即愈，9年随访无复发。

验证：张氏等用上法验治多例，疗效较好简单易学，价廉无副作用。病例：陈×，男，23岁，农民，1986年10月2日初诊。患周身皮肤瘙痒半月，始服西药扑尔敏及外搽地塞米松软膏，有效但易复发，后则无效，经用上法治疗2次痒

止，至今未复发。(张安富等，《新中医》，1988，(7):封三。)

按：食盐性味咸寒，生用溶于水外洗可有解毒止痒之功，常用治痈肿疮毒、湿疹皮肤瘙痒等症；米泔水亦有祛湿止痒之效，二药煎液搽洗患部收效迅速。痒止后忌饮酒、咸鱼、虾蟹等物，洗澡时不用碱性强的肥皂，以防复发。

114. 顽固性皮肤瘙痒

方名：胡麻丸

来源：秦修成，《山东中医杂志》，1982，(6):362。

组成：大胡麻120克，防风60克，威灵仙60克，石菖蒲60克，苦参60克，白附子30克，独活30克，甘草15克。

用法：以上八味药，共研细末，炼蜜为丸，每丸重6克。每服一丸，日服3次，10天为一疗程。

主治：顽固性皮肤瘙痒。

疗效：秦氏报道运用上方治疗本病11例，8例痊愈，多年未复发。3例未随访。

验证：姜氏验治确有良效。病例：田××，男，50岁。1983年春患皮肤瘙痒症，昼夜不安。曾在县医院住院治疗10余日不效。经用上方改丸为汤并加蝉衣、藿香、地肤子，服三剂症状大减。又加牛蒡子10克，服三剂痊愈。(姜玉修，《山东中医杂志》，1986，(5):45。)

按：方中以大胡麻养血润燥而熄风，以防风、独活、威灵仙、白附子祛风胜湿而止痒，苦参清热燥湿，祛风止痒，石菖蒲散湿化浊，甘草调和解毒，诸药合用而收养血祛风，燥湿止痒之效。

115. 丘疹性荨麻疹

方名：六神丸

来源：曾庆发，《新中医》，1987；(6)：45。

组成：牛黄、雄黄、冰片、麝香、珍珠、蟾酥。

用法：把六神丸研极细末，用凉开水或护肤霜适量调匀，外搽患部，轻者外搽1次，重者3次即愈。

主治：细皮风疹(丘疹性荨麻疹)。

疗效：曾氏用上法治疗该病4例效果满意。病例：刘××，男，4岁，1986年3月5日就诊，其母代诉：四肢躯干起风团样丘疱疹，瘙痒1天。皮疹呈散在分布，以四肢为甚，为风团样丘疱疹，约1~2厘米大小，色淡红，略呈纺锤形，顶端见针头样水疱，状如虫咬，用六神丸每次2支，研极细用凉开水或护肤霜适量调匀，外搽患部，搽1次后次日瘙痒大减，疹退减半，搽第二次后，痒止疹消未再复发。

验证：文氏用上法验治5例收效满意。病例：雷××，男，29岁，农民。1987年9月19日诊，患者一周来，每天下午全身遍起大小不等、形状不一的皮疹，瘙痒不已，疹块成片，其色红润，此起彼伏，遇风尤甚。曾服西药扑尔敏、苯海拉明和中药清热燥湿养血散风之品，仅能暂缓一时，次日又发搔痒难忍。依法给予六神丸三支外搽，搽1次后，瘙痒大减，疹退大半，搽3次后，痒止疹消病愈。随访至今未再复发。(文清华，1990；(1)，封三。)

按：细皮风疹多属于西医的丘疹性荨麻疹。六神丸原本治疗咽喉肿痛，喉风、乳蛾及痈疽疮疖。因本方具有清热解

毒消肿止痛之功，故用治细皮风疹同样奏效。

116. 痱 子

方名：藿香正气水

来源：王兰镇，《山东中医杂志》，1990；(5):51。

组成：藿香、紫苏、茯苓、陈皮、厚朴、桔梗、白芷、大腹皮等。

用法：用藿香正气水（济南中药厂生产），局部外搽，搽用温水洗净，拭干患部，每天3~4次。

主治：痱子。

疗效：王氏几年用上法治疗痱子30例，治愈27例，3例因局部继发感染成痱疖转用他药治疗。一般用药1天即可止痒，2~5天治愈。再患复用仍有效。病例：××患儿，女，6个月。1988年8月20日诊。头颈、前胸，后背及臀部弥漫红色小丘疱疹4天。用市售痱子水、痱子粉乏效，搽藿香正气水3天而愈。

验证：笔者用藿香正气水外搽验治痱子疗效确切。病例：××患儿，5个月，1990年8月2日诊。全身起痱子，以前胸突出，经用数支藿香正气水外搽1天痒止，3天痊愈。（马吉诗，桓台花园卫生所。）

按：痱子又名痱疮、汗疹。多见于炎夏，以小儿及肥胖人易患。多由于暑湿蕴蒸，汗泄不畅所致。藿香正气水具有芳香化湿，理气辟秽之功，内服可治夏秋感冒吐泻，山岚瘴气及水土不服之吐泻，外搽对痱子也有良效。

117. 湿 疹

方名：湿疹三号方

来源：李林，《中医杂志》，1981；(10)：20。

组成：生地、元参、当归、丹参、茯苓、泽泻、白鲜皮、蛇床子。

用法：酌定用量，水煎服。

主治：亚急性、慢性、泛发性湿疹及阴囊湿疹。

疗效：上方是中医研究院研究员朱仁康治疗亚急性、慢性、泛发性湿疹及阴囊湿疹的经验方，治愈多例。

验证：李氏用上方验治3例慢性湿疹，均获满意疗效。

病例：陈××，男，50岁。1982年2月10日就诊。左膝下内侧有手掌大一块湿疹已1年多，反复发作，皮肤呈暗紫褐色，高起正常皮肤，表面有轻度白色鳞屑，搔破流水，舌红苔薄白，脉象弦滑。某院诊为慢性湿疹，经中西医结合治疗未见好转。经用湿疹三号方（生地30克，元参12克，当归15克，丹参12克，茯苓12克，泽泻10克，白鲜皮12克，蛇床子10克，黄柏10克，土茯苓10克，苦参10克），水煎服，并用马齿苋90克，黄柏60克，水煎外湿敷，每日2次。服药2剂后，痒感已缓解，又服4剂，效验大显，守方继服10剂，下肢皮肤恢复正常。（李武德，《中医杂志》，1983；(6)：79。）

按：朱老认为湿疹主要由内湿外发肌肤所致，往往缠绵难愈。由于某些原因反复发作，而出现口干渴而不思饮，舌质红绛少津，皮肤干燥脱屑，瘙痒不止等阴虚证候，此时若单用滋阴养血则腻滞恋湿，如仍投渗湿苦燥则更伤阴血。上方以

生地、元参、丹参、当归滋阴养血和营，补阴血之不足，防渗利诸药之伤阴，茯苓、泽泻健脾利湿，白鲜皮、蛇床子祛湿止痒，祛湿邪之有余，制滋补诸品之腻滞。湿去而无伤阴之弊，阴复而无助湿之嫌，故对急慢性湿疹顽疾收良效。

118. 慢性湿疹

方名：治慢性湿疹方

来源：饶建跃，《新中医》，1989；（4）：40。

组成：葱白500克，猪肠200克，砂糖75克。

用法：把葱白、猪肠洗净，和砂糖一并放入铁锅内，加青油炒拌4分钟左右，再加少许水后，用碗盛起，放在普通容器内蒸熟，汤和食物一同吃下。

主治：慢性湿疹。多形性损害，症见红斑丘疹水泡，结痂糜烂，阵发性瘙痒。

疗效：饶氏3年来用上方治疗本病18例，显效12例，进步4例，无效2例。病例：李××，男，58岁，患慢性湿疹10余年。自觉瘙痒，躯干部及四肢症见暗红色斑丘疹，间夹水泡，抓破渗液糜烂有血痂，皮肤色素沉着，反复发作不愈。饮酒后诸症加重，影响睡眠，屡用中西药效果不理想。经用上方后，1次瘙痒除，2次皮疹明显改善，3次基本痊愈。随访2年未见复发。

验证：周氏用上方验治3例慢性湿疹，确有奇效。3例病经3~5剂后基本痊愈。病例彭××，男，71岁。患双下肢胫前慢性湿疹10余年，经中西医治疗仍反复发作。又经住院抗过敏治疗二周基本痊愈。出院一周后，局部湿疹又呈急性

发作，经用上方二剂后，局部渗出停止，瘙痒减轻，皮损有明显改善。又连服三剂湿疹基本痊愈。随访至今未见复发。（周新渝，《新中医》，1990；（5）：56。）

按：慢性湿疹是一种比较难治的皮肤病，该方简单，药源方便，效果可靠，值得一试。其作用原理有待研究。

119. 热毒痈肿、血肿

方名：赤小豆粉

来源：廖玉春，《新中医》，1976；（2）：42。

组成：赤小豆适量。

用法：将赤小豆用磨子磨成粉末或研成粉末，用蜜糖或冷水调敷患处，已溃烂的疮疡敷在疮口周围，暴露疮口以便排脓，1日2次。

主治：热毒痈肿、血肿及扭伤。

疗效：廖用此法治疗热毒痈肿、血肿及扭伤多例，均收满意效果。病例：邓××，男，28岁，右脚踝关节扭伤，引起右脚踝骨上约20厘米长一段肿痛，经用赤小豆粉末水调外敷，一夜之后，肿痛明显减轻，再敷2天，肿痛全消而愈。

验证：彭氏用上方验治跌打血肿多例，无有不愈者。病例：王×，男，22岁，被汽车不慎撞伤左腿，当即随车来诊，见左股骨上端1/3处至胫腓骨下端1/3处明显肿大，皮肤表面青紫红斑密布，压之波动，刺痛胀麻，X线报告未发现骨质受损。即用赤小豆250克研细末冷水调成糊状，似用泥糊墙一般，将血肿满满涂敷，纱条包扎。2天后前往患者家中探视，但见红肿尽消，异色皆退，患腿与右腿大小相等而

愈。(彭常金,《新中医》,1979;(4):50。)

按:赤小豆又名赤豆,具有化瘀止痛,散恶血,消血肿等功效。《朱氏集验方》载“赤小豆治一切痈疽疮疥及赤肿,不拘善恶,但水调涂之,无不愈者”。此方应用简便,价廉效高,很值得一试。

120. 肌 痛 症

方名:肌痛方

来源:李树钿,《新中医》,1981,(1):28。

组成:枳实15克,粉葛30克,生杭芍15克,当归15克,炙甘草9克,红花3克。

用法:水煎服,每日一剂。

主治:肌痛症。

疗效:上方乃是吴仁老中医的验方,治疗多例肌痛症均收良效。病例:王×,男,28岁,教师。患者身强体壮,已病数日,发热身痛,烦躁喘满,全身肌肉似火灼,手不能触摸,衣不能近,触动肌肉,则周身肌肉疼痛不已。曾服去痛片,注射安乃近,青、链霉素等药物不但无效,反而痛甚,改用中药治疗亦未见效。后邀吴老中医会诊,诊其脉洪大有力,舌苔青黄少津,大便数日不下,下亦燥结,余症同前。诊为“肌痛症”,服上方二剂后,疼痛稍止,能近衣,手摸,但大便干燥不解,矢气恶臭,上方加生军9克,山楂15克,服二剂后,便通痛止,脉静身凉,诸症消失。

验证:裴氏用上方验治于赵××的孩子,患儿患病三个多月,全身肌肉疼痛难忍,夜间加剧,甚至通宵难眠。跑了

几家大医院化验、透视、心电图、超声波等都做了，但无任何阳性结果。用止痛剂开始有效，继则无效。观其用药不过是维生素C、谷维素、维生素B₁之类，病人服后毫无效果。余诊之后，沉思良久，苦无上策，经用上方加重当归用量而愈。(裴海泉，《新中医》，1989；(5)：封三。)

按：肌痛症可参照祖国医学的肌痹病治疗。是指以肌肤证候为突出表现的痹证。《素问·长刺节论》：“病在肌肤，肌肤尽痛，名曰肌痹”。近似于现代医学的皮炎。方中主用葛根解肌退热，又善鼓舞胃中清气上行以输津液，津液得以上承，筋脉肌肉得以濡润，故可解除身热肌痛等症；杭芍补血敛阴，缓急止痛，与甘草相伍可除肌肉灼痛挛急；配枳实行气导滞，当归、红花活血祛瘀以取“通则不痛”。诸药配合共奏解肌退，行气活血，缓急止痛之效，故对肌痛这一疑难病症而收良效。

121. 扁 平 疣

方名：养血活血汤

来源：赵洪斌，《山东中医》，1982；(6)：362。

组成：熟地12克，白芍12克，赤芍10克，丹皮10克，桃仁10克，红花10克，牛膝10克，首乌6克，杜仲6克，赤小豆10克，白米10克，穿山甲6克。

用法：水煎服，每日一剂，白酒为引，服时先喝白酒30毫升。10~20剂为一疗程。

主治：扁平疣。

疗效：赵氏用上方治疗本病，痊愈率46.15%，显效率

50%以上，无效率15.38%，总有效率占84.62%。

验证：赵氏用上方验治多例疗效可靠。病例：李××，男，10岁。1980年7月20日因左侧面颊部长疣来诊。患儿左侧面颊有2.5×2.5厘米一片单个群集，顶部扁平，稍高出皮肤的浅褐色丘疹，略有瘙痒，丘疹周围及全身皮肤无异常。诊为扁平疣，经用上方加减（熟地12克，赤白芍各9克，桃仁、杜仲、穿山甲、首乌、白术各9克，红花、板蓝根、当归各12克，川牛膝、甘草各6克，赤小豆30克。服三剂后，面部扁平疣基本消尽，再服二剂痊愈。（赵月星，《山东中医》，1983；（6）：65。）

按：疣的病因祖国医学认为由于风邪搏于肌肤而变生，或肝虚血燥，筋气不荣所致。养血活血汤中以熟地、白芍、首乌养血补虚润燥，以赤芍、桃仁、红花、丹皮、牛膝、山甲活血祛瘀散结，杜仲补肝肾，强筋骨，赤小豆、白米清热利湿，也可酌加当归、板蓝根以养血解毒。

122. 各种癣症

方名：大蒜外搽方

来源：程爵棠，《新中医》，1982；（2）：48。

组成：独头大蒜（生）一枚。

用法：将大蒜切片，直接搽患部，每日2~3次，每次搽5~10分钟。注意：（一）外搽前将患部用温水洗涤干净，保持患部清洁，切忌用生冷水洗或使患部长期用冷水浸泡。（二）先抓后洗，疏松汗腺，使药力直达病所深部，加速药效。（三）睡前要搽一次，其余酌定。（四）忌食易动风和油腻之物。

主治：各种癣证。(干癣尤效。不论癣发何部，新久均可使用。

疗效：程氏报道5年来用上法共治82例，其中痊愈67例，显效9例，有效3例，无效3例。一般5~7天见效，最多15天，直至痊愈。无任何副作用。病例：王××，男，57岁，工人。1976年12月5日初诊。自诉5年前，先右股骨(大腿)内侧，后右股部，初起如钱，渐渐长如手掌大，轮廓分明，呈浅红色斑点，边缘一圈鲜红色小丘疹，中心覆有白色鳞屑，抓之则起，瘙痒难忍。曾多次用黑白癣药水和中药制剂外搽无效。嘱用上法外搽患部，连搽7天见效。10天痊愈。随访1年，未见复发。

验证：我儿子1986年臂弯部患癣，经用上法搽患部几天就好了。(张庆春，《新中医》，1990；(6)：56。)

按：大蒜据现代医学体外试验证明：“对絮状表皮癣菌，铁锈色小芽胞癣菌，堇色毛癣菌等有较强的抗菌作用。经临床反复验证外搽疗癣效佳。并且使用方便，药源丰富，值得推广。

123. 淋巴、骨、关节结核

方名：治疗结核秘方

来源：部先玲等，《山东中医杂志》，1984；(5)：46。

组成：外敷紫草油：紫草90克、蜈蚣2条、全蝎2只、香油180克。

将蜈蚣和全蝎放入熬热的香油内炸透，然后倒入盛紫草的容器内，泡晒7天，过滤即得紫草油。

内服蜈蚣丸：蜈蚣50条，全蝎30克，天虫15克，川军9克，雄黄6克，朱砂6克，甲珠45克。共研细末混匀，再加捣烂的米饭，制药丸如黄豆粒大。

用法：把紫草油浸泡过的纱布敷于患处。内服蜈蚣丸每次3克，每日3次。

主治：淋巴结核、关节结核、骨结核。

疗效：此方系章丘县87岁高龄的李宗楹先生的祖传秘方，对淋巴结核、关节结核、骨结核均有很好的疗效。

验证：时氏用该秘方验治结核10余例，其效甚著。（时立英，《山东中医杂志》，1986；（5）：45。）

按：该秘方主用全蝎、蜈蚣、僵蚕、山甲等虫类药以取攻毒散结，通络逐瘀。据《中药大辞典》载：“蜈蚣去头足焙干研末内服，每次3~5条，每日2次，治疗不同类型的结核病7例，均治愈”。雄黄燥湿祛痰，紫草凉血解毒，川军逐瘀解毒，朱砂防腐解毒，诸药合用，内服外用敷结合，故收显效。

124. 水火灼烧伤

方名：水火灼烧奇方

来源：蔡良平，《新中医》，1984；（2）：22。

组成：生姜。

用法：将生姜捣烂揉汁，用药棉蘸姜汁敷于患处。灼伤轻者，敷药1次即可，严重者可时时注入姜汁，保持湿润36小时即可停药。

主治：水火灼烧伤。

疗效：蔡氏20余年用上方治疗水火灼伤四五百例无一失误。

验证：邓氏用上方验治一小儿双小腿被火灼伤，起数个水泡，疼痛不堪，后用生姜汁滴涂患部，疼痛即减轻，渐至消失，调治数日，迅速痊愈。（邓克新，《新中医》，1984；(10)：封三。）

按：生姜用来治风寒感冒、胃寒呕吐为多，却很少知道生姜能治灼伤，并且疗效甚奇。据现代药理研究生姜有抗炎、镇痛作用。据蔡氏临床经验认为：灼伤处敷涂姜汁，能立即止痛。已起泡红肿者，能消炎退肿，消去水泡，水泡已破者，敷之亦无刺激，由于生姜能灭菌，破口亦不致溃烂。生姜家家皆备，随处可得，用法简单，易于应用，若有水火灼伤者不妨一试。

125. 冻 疮

方名：复方乌头酊

来源：刘远霸，《新中医》，1982；(11)：20。

组成：生川乌、生草乌各50克，桂枝50克，芒硝40克，细辛20克，红花20克，樟脑15克，60%酒精1000毫升。

用法：先将生川乌、生草乌、桂枝、细辛、红花研粗末，再与芒硝、樟脑相混合后入酒精内密闭浸渍7天，滤药液备用。用棉花签蘸药汁涂患处（溃疡面按外科溃疡处理），趁湿频频揉擦，每日早晚各1次，每次擦药约5分钟左右。

主治：冻疮。

疗效：刘氏用上方治疗多例冻疮均收良效。病例：××，

男，25岁，学生。1980年12月17日初诊。患者手足患冻疮已21载，每逢冬寒复发，至春暖方愈。曾用多种方法治疗不效。今冬又开始发病，手指背，足趾足跟，焮肿瘙痒疼痛已一周，患部可见六处约蚕豆大小紫黯，尚未溃烂，按上法治疗4天，肿胀消，痒痛止而愈。来年2月追访未复发。

验证：丁氏几年来用上方验治冻疮患者，效果良好。病例：李××，女，28岁，职工。双下肢末梢患冻疮，外用冻疮膏及中草药单方效都不显。于今年元月6日来诊，检查：双脚趾及脚跟有红肿斑，边界模糊，压之易退色，得暖则舒，诊为冻疮，经用上方如法外擦，3天后欣然而告，肿胀痒痛症大减，继用一周而愈。（丁冬生，《新中医》，1986；（2）：27。）

按：冻疮主要由寒冷之气所伤，阳气不达，阳抑血凝，经脉涩滞，血行不畅而成，治以寒者温之，结者散之，取辛温大热的乌头、桂枝、细辛温散凝寒锢冷，配红花、芒硝、樟脑活血通络消肿定痛。诸药酒精浸泡后，能充分发挥药力，助药性深入皮内直达病所故易应手获效。

妇科部分

126. 白塞氏三联综合征

方名：赤小豆当归散加减

来源：王文正等，《山东中医》，1983；（3）：23。

组成：赤小豆30克，当归15克，升麻12克，生地15克，木通6克，竹叶12克，甘草3克，栀子9克。

用法：水煎服，每日一剂。

主治：狐惑（白塞氏三联综合征）。

疗效：王氏等用上方治愈1例男性患者。患者自1979年10月初开始眼睑微肿，继而阴茎瘙痒，10月中旬舌面出现白色溃疡，服牛黄上清丸后稍减。今年1月份舌面及阴茎溃疡逐渐成片状，口唇干燥，周身倦怠不适，伴有热感，小便黄。遂去某部队医院诊为白塞氏综合征，住院治疗，经用强的松、庆大霉素等，40多天未收显效，改用上方服13剂而诸症消失。

验证：张氏用上方加减验治3例狐惑病患，均获效验。

病例：王某，女，44岁。反复发作口唇及前阴部溃疡2年多，曾去地区等医院诊为白塞氏综合征。医治不愈，近日病

情剧增，治用赤小豆当归散合导赤散加减（赤小豆60克，当归15克，连翘20克，生地30克，玄参25克，木通、竹叶、生甘草、龙胆草、升麻各10克，黄柏、知母各6克。水煎服，每日一剂，并予苦参30克水煎熏洗阴部。药进六剂，阴部症状基本消失，唇肿，舌烂亦减。停用洗药，上方去知柏加野菊花15克，续服6剂，诸症消除。（张明亚，《山东中医》，1987；（4）：13。）

按：狐惑系现代医学之白塞氏三联综合征，病因尚未完全明了，一般认为与感染、过敏及人体免疫功能异常有关，治疗尚乏特效药物。祖国医学认为本病系湿热浸淫，邪毒内盛引起，以咽喉、腐蚀前后二阴溃疡为主要特征。《金匱要略》载：“狐惑之为病，状如伤寒，默默欲眠，目不得闭，卧起不安，蚀于喉为蛾，蚀于阴为狐……。”方中以赤小豆利在下之湿，升麻解在上之毒，栀子清上下之热，木通、竹叶泻其火，当归通其经，生地凉其血，合用则使毒散湿利，病因消，症状除而狐惑之病愈。

127. 习惯性流产

方名：陈艾鸡蛋汤

来源：杜荣俊，《新中医》，1978；（1）：15。

用法：陈艾叶煎汤去渣，剩汤煮荷包鸡蛋，鸡蛋煮熟后连蛋带汤1次服，每日连服七剂。流产前月开始服，轻者连服2~3个月，重者连服3~5月。

主治：习惯性流产。

疗效：杜氏用上方治疗习惯性流产31例均获较好疗效。

验证：李氏用上方验治6例习惯性流产患者，均获良效。采用的服药方法是，从怀孕月开始服药，每4~5天服1次，连用4~6个月，所治病例均连续流产二胎以上，并用其他方法治疗无效者，服上方，使足月生产者为成功。病例：赵×，30岁。婚后怀孕足产一死胎，此后连怀二胎，均于孕后2~3月流产。怀第三胎时，为了保胎，曾用黄体酮及中药治疗仍流产。第四胎时到我处求治，即介绍用上方治疗。从怀孕月起，每4天服一剂，连服8个月，至怀孕10个月零7天而顺产一男婴，现已4岁，生长发育均正常。（李庆方，《新中医》，1985；（4）：封三。）

按：此方为民间验方，用方简便，价格低廉，无副作用，效果较好，艾叶《中药大辞典》载：“理气血，逐寒湿，温经止血，安胎。”《药性论》也载：“止崩血，安胎止腹痛。”再配以补虚养身的鸡蛋故能起保胎作用。

128. 白 带 病

方名：止带方

来源：丁敬堂，《新中医》，1983；（3）：28。

组成：黄柏、焦苍术各10克，椿根皮、土茯苓、生苡仁、蒲公英各15克，柴胡8克，生龙骨、牡蛎各30克。

用法：水煎服，每日一剂。湿热甚加龙胆草，熟大黄，少腹痛加延胡、乌药，腰痠痛甚加续断、牛膝，脾虚甚加淮山药、茯苓，肾虚甚者加菟丝子、续断，病程长久加海螵蛸、金樱子、芡实。

主治：急慢性盆腔炎、阴道炎、宫颈糜烂等引起的白

带病。

疗效：丁敬堂老中医用上方治疗 274 例带下病，结果痊愈 179 例，占 65.33%；显效 48 例占 21.17%；有效 28 例占 10.22%；无效（治疗三周无改善者）9 例占 3.28%。总有效率 96.77%。病例：刘×，30 岁，1980 年 2 月 13 日初诊。素有带下，经治已减，2 天前带下骤增，犹如小溲，乳白色，状如豆渣，外阴红肿，瘙痒难忍，伴发热，头晕痛，舌质红，苔白腻，脉濡滑。西医诊为霉菌性阴道炎，中医诊为白带病。即予止带方加熟大黄、车前子各 10 克，配合外洗七剂即愈。

验证：高氏用此方验治于临床，疗效甚佳。病例：雷×，33 岁。1985 年 9 月就诊。患者带下已 3 年多，有时呈乳白色或呈黄白色，状如豆渣，时而量多如经水，有时量少。外阴时有红肿，白带多，出现湿疹，瘙痒难忍，腰痠痛。舌红苔白腻，脉浮滑。经用中西医药治疗均不显效，改用止带方加龙胆草、续断、牛膝各 10 克，服三剂后湿疹消失，白带减少，腰痠痛减，一周后再诊去龙胆草、土茯苓加淮山药 15 克，白茯苓 10 克，服四剂后痊愈，1 年后随访未复发。（高建林，〈新中医〉，1989，（12）：封三。）

按：白带又称带下病，是妇科常见病之一。多见于西医妇科急慢性盆腔炎、阴道炎、宫颈糜烂等病，往往缠绵难愈，丁老中医的止带方不失为一首难得的止带方。

129. 外阴瘙痒

方名：阴痒外洗方

来源：李忠信，《新中医》，1983；（3）：25。

组成：芒硝、苦参、蛇床子、黄柏、川椒各15克。

用法：上药加水1500毫升，煎至1000毫升，去渣倒入盆内，至温热适度坐浴，浸洗15~20分钟左右，每日1~2次。

主治：各种原因引起的外阴瘙痒。

疗效：李氏用上方治阴痒多例，一般三~六剂即愈。病例：庭××，女，32岁，阴部瘙痒已2年多，常影响工作和休息，中西医屡治无效。于1977年5月到我处治疗，用上方三剂煎水外洗，症状大减，精神愉快，继用二剂而愈，至今未复发。

验证：王氏用上方验治10余例阴痒患者，均获良效。病例：陈×，女46岁，农民。患阴痒症5年，反复发作，时重时轻，白带量多，其味秽臭，苦不堪言，在某医院诊为滴虫性阴道炎，经中西医治疗无效。经用上方加百部、蒲公英各30克，枯矾15克，水煎外洗，每日2~3次，六剂而愈，随访至今未发。（王柱林，《新中医》，1988；（7）：封三。）

赵氏用上方加减化裁外洗验3例阴痒患者，均收满意疗效。（赵广胤，《新中医》，1985；（7）：封三。）

按：方中芒硝能解毒消肿，对皮肤疮肿及疮疹赤热痛痒均有作用；苦参、蛇床子均有杀虫止痒之功，现代药理研究均有抗滴虫作用，外用善治滴虫性阴道炎；黄柏泻火解毒，治热毒疮疡湿疡等；川椒辛温，散寒除湿杀虫止痒，诸药配合，具有清热解毒，利湿收敛，杀虫止痒等作用，用治阴痒故能收效。

130. 阴 痒

方名：阴痒外洗方

来源：洗建春等，《新中医》，1989，(10):18。

组成：鬼针草，蛇泡勒各60克。

用法：将上药水煎出味，把药液倒在盆内，趁热先熏后坐盆浸洗，边浸边洗净阴道分泌物。并注意勿同时使用它药，禁房事，内裤需煮沸消毒，勤换勤晒。月经期禁用此药。

主治：阴痒（阴道炎、外阴炎等引起的外阴瘙痒）。

疗效：洗氏用上方治疗20例阴痒（霉菌性阴道炎17例，滴虫性阴道炎3例，外阴炎、外阴搔痒10例），全部治愈。一般经1次用药，瘙痒症减，10天为一疗程。对外阴炎疗效颇好，3天即效，而对霉菌性和滴虫性阴道炎疗程较长，需1~2个疗程方可治愈。病例：付×，女，26岁，未婚，1986年5月27日初诊。外阴瘙痒伴豆腐渣样白带2年多。曾在某医院检出酵母菌，经治后暂缓解，但反复发作，瘙痒难忍，影响工作，面色萎黄，舌淡苔腻，脉滑。妇检：外阴（-），阴道口周围有白膜样分泌物覆盖，拭之不易脱落，取分泌物实验室检出酵母菌，诊为霉菌性阴道炎。经用上方治疗，1次搔痒症减，3次后瘙痒全消，白带减少，共治2个疗程而愈，多次化验未找到致病菌。

验证：黄氏用上方验治6例阴痒患者，均效如桴鼓。病例：林××，女，25岁，已婚，1990年2月10日初诊。自诉2年来阴部、阴道奇痒，并有灼热感，经常流多量白色分泌

物，气味腥臭，尿频腰痛。曾在某医院诊为滴虫性阴道炎，经治疗虽有效，但反复发作，经用上方外洗，2次不再瘙痒，半月后化验已找不出致病菌，至今未复发。(黄育文，《新中医》，1990，(10):56。)

按：鬼针草为菊科植物鬼针草的全草，味苦性平，有清热解毒，散瘀消肿等功效，所含成份对革兰氏阳性菌及金黄色葡萄球菌等均有抑制作用；蛇泡勒为蔷薇科植物茅莓的全草，也有清热解毒，凉血消肿等作用，二药合用，水煎熏洗，收效迅速。

131. 不 孕 症

方名：助孕汤

来源：王竹民，《新中医》，1984；(9):40。

组成：广木香、当归、羌活、益母草、芍药、柴胡、香附、紫河车。

用法：患者月经无明显病痛者、可于经后10~15天服助孕汤四~六剂，以摄精助孕。若月经有明显异常者，重在调经，可以上方为基础加减化裁；实热，加丹皮、栀子；虚热，加知母、黄柏；气虚，加党参、淮山药、黄芪；实寒，加桂心、莢术、紫石英；虚寒，加巴戟天、仙灵脾、艾叶；痰湿，加苍白术、川厚朴、枳壳；血瘀，加桃仁、红花；输卵管不通，加木通、丝瓜络、吴茱萸。

主治：妇女不孕症。

疗效：王氏用上方治疗不孕症多例，约80%的病例服1~3个疗程即见经调而受孕。病例：王××，女，30岁，

1971年3月4日初诊。多年前产一女婴后，一直未孕，平日自感腰脊痠沉，白带清稀。经期28~30天，量中等、色淡，经后腰痛。经用助孕汤加补骨脂、川续断、桑寄生各12克，车前子（包）15克，嘱经后10日连服六剂，药后未行经同年底顺产一男婴。

验证：严氏用助孕汤临床验证效果良好。病例王××，女，27岁，农民。继发性不孕2年半，经多方医治未见效。1984年11月2日来诊。症见月经先后不定期，经行不畅挟有血块，少腹胀痛，乳房胸胁胀闷不舒，腰膝痠困，纳差呕恶，舌苔薄，脉沉弦尺弱。先用逍遥散加减以行气解郁调经，后又投助孕汤数剂，1985年元月20日其夫前来告曰：爱人已怀孕。（严育斌，《新中医》，1985；（6）：封三。）

按：方中以柴胡疏肝解郁，升举阳气，当归补血活血，调经止痛，据现代药理研究有抗维生素E缺乏和对子宫“双向性”调节作用。香附疏肝理气调经止痛，为气病之总司，妇女之主帅。木香为三焦气分之药，能升降诸气，下焦之气滞尤宜，乃塞者通之意，可行输卵管之气，有利于卵子与精子经过的道路畅通无阻。羌活开提督脉之阳气。紫河车乃血肉有情之品可益气养血、添精补督任（若药源不足可以菟丝子、枸杞子代替）。诸药合用具有疏肝调经、滋肾安血、调整阴阳，使能摄精助孕之功能。

132. 子宫肌痛

方名：二石散（编者加）

来源：周慕白，《新中医》，1984；（10）：15。

组成：云母石90克，阳起石18克。

用法：共研细末混匀，每次用汤药送服12克。

主治：卵巢癌，子宫肌瘤。

疗效：周氏用上药研末，另用中药汤剂送服此药治愈1例卵巢粘液性囊腺癌。病例：祝明玉，女，39岁。1965年夏，自感小腹部有一包块，时有微痛，1966年4月渐见增大，随之疼痛增剧，遂到县医院检查。印象为“子宫肌瘤恶性变”，又到重庆医学院作病理活检，诊为“卵巢粘液性囊腺癌”，结论是“子宫附件癌，已向盆侧壁转移，无法手术”。初诊见患者消瘦，面色晦暗，卧床呻吟，小腹约有两拳大一包块胀痛，扪之凹凸不平，发热微汗，五心烦热，夜间口干咽燥，纳差，七八天未解大便，舌质偏红，苔少而薄，脉沉细略数。经用桃仁承气汤加味、增液承气汤后，食欲增强，舌苔已转润，脉较前有力。见其胃气已起，即以抵挡汤加减（三棱、莪术各15克，土鳖虫、大黄（后下）、当归、赤芍、红花、桃仁、枳壳各10克，川牛膝12克。服五剂，未见好转，继服上方外，另用云母石90克，阳起石18克生研为末混匀，每次用汤药送服12克，三剂后患者阴道有少量恶血流出，色紫黑，极臭，小腹阵痛递减。将上方改为三棱、莪术、土鳖虫各90克，桃仁、红花、当归、赤芍、大黄、阳起石、川牛膝各60克，枳壳30克，云母石120克。共研细末饭糊为丸，每日服3次，每次服18克，温开水送服，前后共服汤药30余剂，丸药四料，共用云母石950克，阳起石430克，治疗2个多月，小腹包块逐渐缩小，后因久病厌药，自行停药。小腹包块尚残存如鸡卵大，但无任何不适，第三年余复访，残块竟不药自消，1968年春到重庆医学院作脱落细胞检查，未发

现癌细胞。现历17年仍健在。

验证：苏氏用云母石、阳起石配合汤药治疗子宫肌瘤收到很好效果。病例：植××，女，48岁，腰、右下腹胀痛发作10年，经量多，时间长，医院诊为附件炎。近来腰腹胀痛加剧，超声波检查子宫 $60\times 70\times 99$ 毫米，内部分布欠均匀，宫内可见 28×30 、 26×25 、 24×10 毫米突发性光团，边缘清楚，确诊为右侧附件炎并子宫肌瘤。患者不愿做切除手术。经用清热解毒，软坚散结、活血祛瘀汤药加阳起石、云母石研末送服（党参、当归身各30克，赤芍、败酱草、莪术、三棱、牛膝各15克，蒲公英、土茯苓各20克，牡蛎40克，桃仁10克，红花6克，另加阳起石2克，云母石10克，研末汤药送服），共服18剂，次年超声波复查：子宫 $46\times 45\times 68$ 毫米，宫内只余下一 14×12 毫米光团。适逢患者七七绝经故停药，至今痛苦若失。（苏赛玉，《新中医》，1990；（12）：封三。）

按：用云母石、阳起石抗癌治肿瘤尚鲜见报道。《本草纲目》载“云母石……治身痹死肌……；阳起石……破子脏中血症瘕结气……。”配合其他活血散瘀药可起破结消肿等作用。此二药是否有抗癌作用，有待于进一步实践验证。

133. 产后缺乳

方名：红薯狗肉汤

来源：贾俊峰，《新中医》，1983；（7）：37。

组成：红薯250克，新鲜狗脊髓骨500克（狗自死者不可用），以黄狗为好。

用法：先将地瓜用清水洗净，勿破红皮，与鲜狗骨同煮

至烂熟同盛盆内任意服饮。

主治：产后缺乳。

疗效：一般一料乳水即下。病例：周×，女，28岁，患者平素体弱，营养缺乏。初产即乳水不下，多方医治罔效，已4个多月，服上方后6日乳水稍通，继服一料乳源充足。

验证：杜氏用上方验治2例均收效。2例患者1例产后1个月无乳，1例产后3个月无乳，均经多方治疗无效，经用上方如法服用一料乳水即下。若配合口服维生素E每日200毫克，每日2次，连服3天，效果更佳，因大剂量维生素E能使末梢乳腺管扩张，血供增加，导致乳腺分泌增加。（杜连生，《新中医》，1989；(10)：50。）

按：狗肉《日华子本草》载：“补胃气壮阳，暖腰膝，补虚劳益气力”。用狗骨髓取其滋补之功与红薯同用，以治因虚弱分起的缺乳为益，对因肝气郁结所引起的实证乳汁缺少则不适合。

134. 乳 腺 炎

方名：芒硝外敷方

来源：程广里，《中医杂志》，1981；(4)：27。

组成：芒硝适量。

用法：根据患处面积大小，取芒硝适量（以能敷满患处，厚度约0.25厘米为宜），用凉水搅拌均匀，敷于患处，外用白布裹之。药干燥时可掸之以凉水，务使经常保持湿润。每日换药1次。

主治：各种原因引起的皮下瘀血肿痛，静脉炎，乳腺

炎，回乳。

疗效：程氏用此法治上病，一般约3天可见肿消痛止。
哺乳妇女回乳如法敷于两个乳房上，约2~3天即可回乳。

验证：张氏用上法治愈6例乳腺炎患者，证明疗效可靠。病例：王××，女，34岁。自诉原诊断为“乳腺炎”治疗无效，两乳房疼痛难忍，夜间更甚，怕冷发烧。查双侧乳房均触及肿块，质硬，压之疼痛，无波动，皮肤焮红，体温39.5℃。采用上述外敷法每日换药2次，连用4天肿退病愈。（张桂宝，《中医杂志》，1982；(11)：80。）

按：芒硝味咸苦而性寒。内服有清肠通便，润燥软坚之功，外敷有泻火解毒，消肿散结之效。用芒硝外敷治软组织水肿及乳腺炎初起有效，还有用芒硝外敷退乳，均有临床报道。方法简单，应用方便。

135 急性乳腺炎

方名：地肤子治急性乳腺炎

来源：王殿祥，《山东中医杂志》，1983，(4)

组成：地肤子50克，红糖适量。

用法：地肤子50克(又名扫帚菜种子)，水煎后加红糖适量，趁热服下，取微汗，每日一剂。

主治：急性乳腺炎。

疗效：王氏用本方治疗33例患者，体温迅速恢复正常，局部炎症均获消散，无一例化脓，一般服药二剂症状减轻，四剂痊愈，个别有服六剂者。

验证：笔者数年来用上方治疗急性乳腺炎屡用屡验。病

例：张××，教师。因左乳房肿块痛疼36小时，被××医院诊断为急性乳腺炎，给予青霉素等药治疗，因其青霉素皮试阳性，而求余诊治。照上方法服药二剂，肿块消散，余证解除，而获痊愈。（许国华，博兴县中医院）

按：急性乳腺炎，中医称之为“乳痈”。多发生于哺乳期妇女，尤以初产妇为多。如处理不当易化脓，常需切开引流，给母婴带来较大危害。中医药治疗效果显著，关键在于早期诊治。上方用于急性乳腺炎初期1~3天，恶寒发热，局部红肿热痛，未成脓者最宜。本方简、验、廉、便，疗效可靠，值得推广应用。其作用机理有待于进一步研究。

136. 急性乳腺炎

方名：乳痈外敷方

来源：张正义，《新中医》，1983；（7）：25。

组成：土豆1个（要选择无斑点的）洗净，泥鳅1条（约10厘米长为最佳），以上为1次用量。

用法：泥鳅和土豆同时放入器皿中捣烂，捣至粘腻沾手时，取出做成小饼，贴敷患处，每日1次。

主治：急性乳腺炎（乳痈），红肿热痛有硬结者均可外敷。如遇有化脓开口者，可先用利凡诺纱布填补，外加敷料之后，再敷此药饼。

疗效：一般2次即见效。病例：刘××，女，右乳房红肿热痛，经用青链霉素等抗菌素治疗20多天，无效而转外科手术，术后红肿痛仍不减，患部又自行溃破2处，患者精神不佳，夜不能寐。经用上法1次痛减，2次开始收口，外敷3

次痊愈。(敷药期间已停用其他药。)

验证：郑氏用上方治疗急性乳腺炎未化脓者多例均获痊愈，用药最多的4次，最少的1次。病例：张×，女，27岁，产后半年哺乳期，因工作忙未给孩子及时吃奶，右乳房出现了红肿疼痛，右侧卧位时疼痛加重，伴发热体温38.3℃。右乳房外观红肿，扪之有结节，压痛明显，肌注青链霉素5天无效，经用上方外敷1次疼痛明显减轻，体温正常，2次后诸症消失，而告愈。(郑志汉，《新中医》，1986；(7)：46。)

按：泥鳅《中药大辞典》载：“性味甘平，补中气祛湿邪。”《四川中药志》载：“利小便，治皮肤瘙痒疥疮发痒。”又载：“利小便，滑液能治痈肿。”其与土豆配用捣烂外敷治乳痈，作用机理待于研究。

137. 急性乳腺炎

方名：乳痈验方

来源：张敏元，《新中医》，1982；(7)：39。

组成：当归、川芎、益母草、泽兰、苍耳子各12克。

用法：上药水煎加黄酒冲服。

主治：急性乳腺炎(乳痈初起，尚未成脓，局部皮肤焮红，肿硬疼痛，或伴有恶寒发热症。

疗效：张氏用此方治疗数十例乳痈，均收到满意疗效。病例：汤××，女，22岁，1975年5月12日就诊。患者为初产妇，双侧乳房结块，红肿疼痛，乳汁不畅，伴恶寒发热已6天，曾经多方治疗无显效。检查：体温39℃，两乳房内之肿块如拳头大，触痛明显，但无波动感，舌质淡红，苔薄，脉

滑数。用上方二剂后，乳房内肿块日见缩小，诸症消除而愈。

验证：王氏用上方临床验治10例乳痈患者，疗效颇好。

病例：刘××，女，27岁。1988年1月10日就诊。患者因亡夫心情忧郁，加之哺乳及过于劳累，于9日始见右乳房胀痛，恶寒发热，去当地医院肌注青链霉素因过敏而来就诊。

查：神清面略红，舌淡红，苔薄黄，脉沉弦略数，体温37.4℃，右乳房偏右下局局部皮色紫红，可扪及5×6厘米之肿块，触痛明显无波动，诊为乳痈，经用上方水煎服于当晚10时，恶寒发热乳房肿痛减轻，第二天体温正常，三剂后诸症消而愈。（王桂荣，《新中医》，1988；(12)：封三。）

按：乳痈是哺乳期妇女的常见病，不管成因如何，初起以乳房肿块，红肿硬痛，乳汁不畅为主症，以气血壅滞，乳络不畅，乳汁瘀滞为其共同病机。上方乃是张氏祖传验方，具有活血祛瘀通络等功效，故对乳痈初期脓未成者有良效。若已成脓者则宜改用清热解毒排脓之方药治疗。

138. 妊娠恶阻

方名：砂仁二陈汤

来源：李庆福，《山东中医杂志》，1984；(4)：43。

组成：砂仁6克，陈皮6克，半夏6克，云苓10克，炙甘草6克，生姜5片。

用法：水煎分2次服，每日一剂。

主治：妊娠恶阻。

疗效：李氏报道用该方治疗妊娠恶阻10余例，均服一剂

即见效，服二至三剂告愈。

验证：于氏用上方验治1例效果颇佳。病例：姜×，女，孕后2个月反复出现呕吐，曾经某院用西药治疗一周未效，又服某中医的中药20余剂亦鲜效。现脘腹不适，时觉气上冲，欲呕，动则吐清稀物，不思饮食，乏力头晕，舌淡苔白脉弱。用上方水煎服一剂呕吐次数减少，它症亦觉好转，服二剂后未再呕吐，观察二周末复发，体力转佳，食欲亦增。（于世民，《山东中医杂志》，1987；（2）：7。）

按：妊娠恶阻是孕妇的一种常见病，多由于脾胃虚弱，胃失和降而致，方中意取砂仁芳香理脾，二陈健脾化湿，取其小剂，功专和降冲逆之气。方中半夏与生姜伍用，不但无损胎元而能增强疗效。

儿科部分

139. 儿童癫痫小发作

方名：黄芪赤风汤加蜈蚣

来源：张家驹，《新中医》，1985，(6)：38。

组成：生黄芪60克，赤芍3克，防风3克，蜈蚣一条(研冲)。

用法：煎三味药水煎服，蜈蚣研末冲服。

主治：儿童癫痫小发作。

疗效：张氏用上方治疗儿童癫痫小发作11例，治愈6例，显效1例，好转2例，无效2例。服药最少18剂，最多47剂。病例：李××，男，12岁，1976年11月6日初诊。患儿1年前不慎从高处跃下，当时无昏迷，未经治疗，半年来患儿左手不由自主抽动，持物落地。某医院儿科及脑电图检查诊断为癫痫发作。近20天加重，每日发作10余次，每次约1分钟左右即止。舌淡苔白脉弱。证属瘀痛，由外伤后血瘀脑络，日久气虚风动所致，治以补气行瘀，用上方七剂发作停止，继服30剂，隔日一剂，巩固疗效，追访1年未见复发。

验证：彭氏用上方验治2例儿童癫痫小发作患者均获

效。病例：舒×，女，12岁。1985年12月25日就诊。患儿于1984年7月7日被电击伤，当即昏迷，经抢救苏醒，未作其他处理。半年后双手不自主的抽动，有时抽跌倒，双目凝视，面色苍白，言语中断。曾在地区医院诊为癫痫小发作，经用祛风解痉之剂不显效，后改为上方服35剂获益。随访至今，未再复发。(彭云辉，《新中医》，1987；(11)：封三。)

按：癫痫小发作多见于儿童，以智暂的意识丧失，两眼发呆，面色苍白，手持物落地，或肢体颜面肌肉抽动为主证，但无昏迷及全身抽搐。本病也见于难产、跌仆损伤或高热抽搐之后，血瘀脑络，气虚风动为患。治疗比较棘手。黄芪赤风汤为清代王清任补气行瘀方之一，黄芪大补元气以取气旺血行之意，赤芍活血散瘀通络，现代药理研究有解痉镇静抗惊厥及抗炎作用，防风祛风解痉，另加虫类药蜈蚣搜风通络解痉。该方标本兼顾气虚血瘀型的癫痫小发作有效。

140. 小儿热病后期口腔溃疡

方名：养阴清汤

来源：吴达昌，《新中医》，1989；(3)：3。

组成：生地6克，麦冬4克，玄参5克，贝母，白芍，丹皮各2克，甘草，薄荷各3克。

用法：水煎服，每日一剂。余热未清者加银花，淡竹叶各5克。

主治：小儿热病后期口腔溃疡。

疗效：吴氏1984年以来用上方治本病36例，均获得良效。病程皆在3~15天。服药2~4天痊愈者31例，5~7天

痊愈者5例。病例：黄××，女，2岁。因发热咳嗽住某医院，诊为“支气管肺炎”，经用抗菌素配合输液治疗5天，咳嗽渐平。第六天发现口腔粘膜及舌面多处溃疡。加服维生素类药3天无效。患儿畏痛拒食，昼夜哭闹，自动出院求治于余。诊见烦躁不安，唇红低热(37.8℃)，口腔粘膜及舌面多处点状溃疡，中心黄白色边红。指纹紫滞。经用上方加银花、淡竹叶各5克，服药四剂，溃疡平复，食欲如常而愈。

验证：肖氏用上方验治2例效果满意。病例：张×，男，2岁。因感冒高热3天，4天发现口腔粘膜及舌面有多处溃疡点。患儿哭闹无常，畏痛拒食，大便4天未解。症属热病伤阴，水不制火，虚火上炎。经用上方加减，一剂好转，二剂病愈。

按：口腔溃疡属祖国医学“口疮”范畴，为儿科常见病。养阴清肺汤出自《重楼玉钥》，为治白喉要方。方中生地，玄参、麦冬、丹皮滋阴清热，凉血解毒，薄荷宣肺利咽，甘草泻火解毒，共奏滋阴、清热、解毒之功。用治小儿热后期口腔溃疡，颇为合拍，故收良效。

141. 小儿口腔溃疡

方名：连萸散

来源：马贵杰，《山东中医杂志》，1983；(6)：38。

组成：黄连5克，吴茱萸3克。

用法：将上二药共捣细末，以米醋适量调成稠糊状，每天晚上敷患儿双侧涌泉穴，白天取下，每剂药用1次。

主治：小儿口腔溃疡。

疗效：马氏用上方治疗本病13例均痊愈。最快者二剂，最慢者五剂。

验证：叶氏用上方加胆南星3克，依上法敷涌泉穴，验治多例小儿口腔溃疡，效果满意。（叶长青，《山东中医杂志》，1984(5):27。）

按：按祖国医学“心开窍于舌，舌为心之苗”等理论，心火亢盛可见口舌生疮糜烂，故方中取苦寒的黄连直折心火，少佐辛热的吴茱萸，以制黄连之寒，二药外敷足少阴肾经的涌泉穴，可有引火下行之功，故对口腔溃疡有效。此法无痛苦，最适用于小儿。

142. 小 儿 口 糜

方名：治口糜方

来源：朱大年，《新中医》，1984；(12):12。

组成：川黄连3克，生大黄6克（后下），生石膏，板蓝根各30克，黄芩、生山栀、连翘、赤芍、野菊花各9克，甘中黄4.5克。

用法：水煎服，每日一剂。外用锡类散吹口。

主治：小儿口糜（口腔溃疡）。

疗效：朱氏用上方治疗由心脾火上炎引起的口腔溃疡疗效颇佳。病例：陆×，男，1岁半，1981年5月28日初诊。发热后，热退口腔内出现溃疡，口内疼痛不能进食，流涎烦躁，夜间哭吵，大便秘结，午后体温常在38℃左右，溃疡较重，舌面、上腭及两颊均有溃烂，多数融合成片，上覆灰白色腐状物，咽部充血，乳蛾肿大，舌苔薄，脉滑数，诊为口

糜，证属心脾之火上炎。法以清火解毒，凉血利咽。服上方五剂而愈。

验证：梁氏用上方验治数例效甚佳。病例：李××，女，1岁，因发热哭闹，拒食就诊，症舌红，苔薄黄，上腭及两颊侧，下唇内侧有多处大小不均，成片溃疡，咽红，经用上方服三剂，外用5日“锡类散”而愈。（梁祝安，《新中医》，1988，（9）：55。）

按：口糜（口腔溃疡），以心脾胃经热盛为多。上方以黄连、黄芩、栀子、石膏清泻三经实热，甘中黄是把甘草末装入竹筒内，于人粪坑中浸渍而成，具有清热凉血解毒之功，

《本草经疏》曰：“专解胃家热毒”；以板蓝根、连翘、野菊花清热解毒，赤芍凉血活血，生大黄泻热通便以取“釜底抽薪，上病下取”之意。配合锡类散吹口外治，故对由发热引起的口腔溃疡，或伴有便秘、扁桃体肿大等实热症状者最适宜。

143. 小儿流涎

方名：益智白术饼

来源：王心好，《中医杂志》，1987；（4）：53。

组成：益智仁30克，土炒白术40克。

用法：将益智仁，土炒白术碾细过箩，取药粉加白面粉400克，食盐、炒芝麻各10克，水适量合面，烙焦饼40个。用前放火上烤焦后再食。1~2岁者，1日2次，每次半个；3~4岁者，1日2次，每次1个；5岁以上者，1日3次，每次1个。

主治：小儿流涎。

疗效：王氏用上方治疗多例小儿流涎效果满意。病例：有一个5岁男孩，流涎2年多，下巴经常水湿，伴纳呆畏寒等脾肾阳虚之见症。给予此饼，一料服完，口涎大减，再服一料病愈。

验证：笔者在临床中，应用此方收到满意效果。病例：荆×，男，4岁。经常口角流涎1年，口角发白，下巴及胸前经常水湿，遇冷天加重。曾到专科门诊检查，口腔内粘膜无异常。给予上方治疗，3料即愈，未再复发。（范立孝、魏会东，桓台县医院。）

按：涎为脾液，渗泄权在于脾。流涎过多者，以儿童多见。究其原因，以脾肾阳虚，中焦虚寒多见。方中用白术健脾以助运化，益智仁补肾气摄涎唾，二药相伍，相得益彰，少量食盐、芝麻起调味之用，烙成薄饼，尤易于小儿服用。

144. 小儿支气管哮喘

方名：桂枝加龙骨牡蛎汤

来源：王秉岐，《新中医》，1985；（3）：47。

组成：桂枝、白芍、生龙骨、生牡蛎，生姜、大枣等。

用法：酌定用量，也可随证加减，水煎服。

主治：小儿支气管哮喘。

疗效：王氏以上方为主加减治疗小儿支气管哮喘多例，疗效颇好。病例：王××，男，3岁，1973年9月21日初诊。患儿不满1周岁时，因患“支气管肺炎”住本地医院，经用抗菌素治疗，好转出院。但此后经常感冒发热，伴喘嗽、抽

搐，屡治不愈。就诊时，患儿面晦不华，抬肩呼吸，舌淡苔白，指纹淡滞，候诊片刻即抽搐一次，醒后露睛酣睡。体温37.5℃。证属中气虚弱，营口失和。处方：桂枝、炒白芍各3克，龙骨、牡蛎各12克，姜半夏6克，陈皮4.5克，生姜3片，大枣2枚，嘱服三剂。药后患儿热退身凉，咳嗽大减，能咳出黄稠痰，再未抽搐。药已中病，守前方加黄芪9克，白芍增至6克，继进三剂。9月28日复诊：患儿咳嗽已平，精神轻爽，饮食倍增，一周来再未感冒，低热抽搐亦未再发。病去十之八九，乃嘱服小儿健脾丸以善其后，随访10年未再复发。

验证：香港中医林氏用上方加减治愈小女6年之久哮喘病。小女现年10岁，2岁开始患哮喘，汗多易感冒，夜间亦凉，痰多，纳差，消瘦。曾服射干麻黄汤加补肾药百多剂无效。持续哮喘2年，每日用西药止喘，经服“桂枝加龙骨牡蛎汤”加陈夏、参、芪40剂后，半年未复发（初期须配合西药止喘，稍后可停西药），人也胖了，感冒也少了。（林培创，《新中医》，1986，（9）：56。）

按：桂枝加龙骨牡蛎汤方出《金匱要略》，原治男子失精，女子梦交”等而设。王氏以此方加减治疗小儿支气管哮喘收良效。方中以桂枝汤调和营卫阴阳，解肌祛风；龙骨、牡蛎三药。按《本草经读》云“龙骨能敛火安神，逐痰降逆”。“痰，水也，随火而生，龙骨能引逆上之火，泛滥之水而归其宅，若与牡蛎合用，为治痰之神品。”张锡纯氏云：“龙骨其性尤善利痰，治肺中痰饮咳嗽，咳逆上气。”龙骨牡蛎配桂枝汤，调阴阳治其本，降逆化痰以治其标，标本同用故收良效，另外龙骨、牡蛎尚有补钙作用，对小儿支气管哮喘伴

缺钙者最为适合。

145. 百 日 咳

方名：百马汤

来源：谢昭亮，《新中医》，1984；(1):4。

组成：百部、马兜铃、炙甘草、大枣。

用法：上方为基本方，随证加减，水煎服。

主治：百日咳。

疗效：上方为黎炳南老中医治百日咳验方。黎老先生从医40年余，治愈者众多。病例：邝×，男，3岁半，1979年11月26日初诊。诉咳嗽3个多月，时现气促，近月来咳嗽加剧，表现为阵发性咳嗽，痰多，夜间尤甚，每晚10多次，咳甚欲呕，经西医治疗不收效。经用百部10克，马兜铃3克，炙甘草6克，大枣4枚，麻黄4克，党参、沙参、鹅管石各15克，白术、茯苓各10克，苏子葶苈子各6克，七剂咳嗽减，稍加增减，继进四剂数日咳嗽随之消失。

验证：彭氏用上方加减，不仅治百日咳有良效，用治小儿咳嗽疗效均满意。病例：王×，男，8岁，1986年4月5日就诊。感冒咳嗽气促，吐少量泡沫痰，咽痛喉痒，恶心欲呕，口微渴，不欲饮，咽充血，舌淡红，脉浮有力，用百马汤加味，水煎服，一剂效，二剂已。(彭定年，《新中医》，1988；(8):56。)

按：百日咳祖国医学称“顿咳”、“疫咳”、“鹭鸶咳”为小儿常见的呼吸道传染病，方中百部润肺止咳。马兜铃清泻肺热而止咳。据现代药理研究二药有较广的抗菌作用，百部

能降低呼吸中枢的兴奋性。二药相配有良好止咳平喘作用。炙甘草润肺止咳，配大枣补中调和，若再随证加减不仅治百日咳，也可用治其他原因引起的咳嗽。

146. 小 儿 疳 积

方名：山药内金饼

来源：孙冠兰，《山东中医杂志》，1983；（6）：38。

组成：淮山药30克，鸡内金12克，芝麻，红糖，面粉适量。

用法：将山药、鸡内金炒微黄为度，共为细粉，加入适量面粉、红糖、芝麻、水和成团，赶饼似周村烧饼样，烙熟，一般按一次服药量制饼一张。每日2~3次，每次用药粉2~6克（即一至二张饼），亦可多服或不加面粉直接做成散剂服用。

主治：小儿疳积。

疗效：孙氏用上方治疗小儿疳积21例，疗效颇佳，均痊愈，且无副作用。

验证：笔者用上方治多例小儿疳积均收到显著效果。病例：刘××，男，2.5岁，桓台县人，因断奶后喂养不当而引起经常大便稀薄，食欲不振，腹部膨胀，青筋暴露，四肢消瘦，面色萎黄，毛发稀疏而黄，精神萎靡不振。经县医院检查，血色素7.9克/100毫升，诊为“营养不良”。用西药治疗效果欠佳，改用上方（山药60克，鸡内金24克，炒微黄研细末，加入适量面粉、红糖、芝麻、水和成面团，烙成烧饼。此药为10天量）。服上方一料后食欲增加，大便正常，三料

后，症状消失，体重增加，面色红润，血色素升至11.5克/100毫升，诸症悉除。(袁惠民，滨州卫校。)

按：鸡内金味甘性平，有消积滞、健脾胃之功。《滇南本草》载：“宽中健脾，消食磨胃。治小儿乳食结滞，肚大筋青，痞积疳积”。现代药理研究认为鸡内金能增强胃液分泌，使胃运动增强，加快胃排空等作用。山药甘平，具补脾止泻，养肺益肾之效，既能补气，又能养阴，补而不滞，养阴不腻，为培补脾胃最平和之品。二药合用，消补并行，食积消则胀满除，脾胃健则饮食增，气血旺盛则诸症悉除。此方还有制法简单，易于服用，无副作用等优点，对小儿疳积尤为适宜。

147. 小 儿 疳 积

方名：疳积散

来源：朱一峰，《新中医》，1981；(8):36。

组成：桃仁、杏仁、生山栀各等分，晒干研末，加冰片、樟脑少许，贮藏备用。

用法：取药末15~20克，用鸡蛋清调拌成糊状，干湿适宜，敷于双侧内关穴，然后用纱布包扎，不宜太紧，24小时后则去之。

主治：小儿疳积（面色萎黄，形体消瘦，烦躁易怒，好哭，时有低热，日轻暮重，口渴欲饮，但饮之不多，胃纳欠香，偏嗜香甜，大便稀溏，或不稀不稠，舌苔白腻等）。

疗效：疳症初、中期，一般1次见效，少数患儿2次，最多不超过3次，每次间隔二三天。病例：吴×，女，3

岁。胃纳欠香1个多月，偏嗜香甜，口渴微欲饮，饮并不多，面色萎黄，形体略瘦，毛发易脱，精神欠佳，烦躁好哭，时有低热，日轻暮重，腹微胀，大便干稀不调，舌苔白腻。用疳积散20克外敷内关穴，3日后复诊，诸症大减，胃纳已增，精神亦佳，低热悉除，腹胀消失，再外服1次，一周后随访，上症已愈，疗效满意。

验证：张氏用上方治疗多名小儿疳积，确有意想不到的效果。病例：于×，女，3岁，面黄肌瘦，胃纳欠香，饮食很少。经上方治疗2次果然胃纳大增，脸色日渐红润。(张安华，《新中医》，1982；(9):18。)

张氏按上方配制用于临床，不仅对小儿疳积有速效，而且意外地发现此散对便秘和痔疮也有良好的疗效。(张化南，《新中医》，1989；(3):封三。)

按：桃仁活血祛瘀润肠，杏仁宣畅气机，栀子消解郁热，共研末与芳香透达的冰片，樟脑用蛋清调后外敷内关，药效通皮肤到达经络脏腑，而起到消积除热，醒脾和胃等作用，其法使用方便，没有痛苦，对小兒尤为适宜。

148. 麻疹后下痢

方名：乌榄

来源：张季高，《新中医》，1979；(1):56。

组成：乌榄（盐腌）六枚。

用法：煮粥代餐，每天2次。

主治：麻疹后下痢。

疗效：疗效颇佳。病例：某男孩，4岁，1979年7月12

日就诊。因麻疹后下痢而入县医院留医。但痢仍未减，经用乌榄煮粥依法一服而痢止。

验证：李氏用上方验治2例麻后痢均获捷效。病例：马×，男，6岁，1989年2月11日就诊。症见患儿疹退3天，然下痢脓粘，日行7~8次，时腹隐痛纳差，西药治未见效，予乌榄6枚煮粥代餐日服2次次日症见，2日诸症悉退而愈。（李松娥，《新中医》，1990，（5）：56。）

按：乌榄为橄榄科植物乌榄的果实。酸涩性平，有止血，化痰、利水，消痈肿等作用。

149. 小儿脱肛

方名：乌龟头散

来源：张文海，《新中医》，1979，（5）：9。

组成：乌龟头。

用法：将乌龟头剥下放在瓦上，用温火焙干，注意不要烧焦，研成细末，每天服2个，早晚2次分服，白开水送下。一般服3~4天即可痊愈。

主治：小儿脱肛。

疗效：张氏用上方治疗小儿脱肛18例，收到良好效果。病例：范×，男，4岁，患肠炎约1个月，经治疗便次减少，但便后肛门脱出，开始尚能自动缩回，后越来越重，便后肛门脱出不能自行缩回，经用6个龟头而愈。

验证：王氏受上方启示，用乌龟头或鳖头粉外敷治疗小儿脱肛27例疗效满意。制作方法将龟头或鳖头剥下后，用湿透水的净纸包裹一层，再用胶泥封成2个5分硬币的厚度，纳

入文火烧存性，取出待凉，将泥与纸除去，研为细粉备用。用法是将脱出的肛门用盐水洗净，将药粉涂在周围，再托上即可。一般2~3次，严重者3~4次可愈。每个龟头或鳌头粉可用2次。(王金义，《新中医》，1980；(6)：63。)

按：《中药大辞典》载“治久痢脱肛产后子宫下垂阴疮。”

《日华子本草》曰：“鳌头，烧灰疗脱肛。”《千金方》载：“治脱肛历年不愈，鳌头一枚烧令烟缩治作屑，以敷肛门上，进，以手按之。”鳌龟同类，故龟头也可。经临床验证虽研末内服，外敷均有效，而以外敷为好。

150. 小儿疝气

方名：疝气汤

来源：程兴军，《新中医》，1988；(3)：55。

组成：乌梅肉、橘核仁、石榴皮、枳壳、川楝子、小茴香、向日葵杆内白心各10克，吴茱萸6克，肉桂3克。

用法：上药共为一剂量水煎，3岁以下小儿煎1次分3次服，每剂煎2次。每日服2~3次，三剂为一疗程。如无湿热去向向日葵杆内白心，寒盛加肉桂6克，气虚的加参芪类药。

主治：小儿疝气。

疗效：轻者3例痊愈，重则6~9剂。程氏用上方治小儿疝气40多例，疗效满意。病例：马×，男，3岁，1975年4月就诊。患疝气1年多，时轻时重，多方求治无效，为免手术求治于余。投上方六剂内服，并用上药研末以陈醋外敷，纱布固定。痊愈至今未复发。

验证：范氏用上方验证1例，确有良效。病例：姬××，男，11个月，患者右侧可复性疝气40天，于1988年6月19日来京求医。经用上方加黄芪10克，服二剂痊愈，至今未复发。（范长青，《新中医》，1988；(12)：封三。）

按：疝气多泛指体腔内容物向外突出的病证。包括多种病证。多伴有气痛的症状。一般认为疝气的发病多与肝经有关，故有“诸疝皆属于肝”之说。方中枳壳、川楝子、小茴香、吴茱萸、肉桂、橘核仁有暖肝行气止痛之功；乌梅、石榴皮取其酸敛收涩之性；向日葵内白心有祛湿热利小便之功。诸药合用对小儿疝气有一定疗效。

151. 小儿高热

方名：双解降热散

来源：陈先泽，《新中医》，1988；(3)：29。

组成：薄荷叶3.7%，蝉蜕，黑丑各5.6%，瓜蒌仁，山栀子各7.4%，生大黄，熟大黄，前胡，僵蚕，黄芩各11.1%，葛根9.2%等。

用法：共研极细末、分装于小瓶中，每瓶重5克，1周岁每次1/3瓶，每日2~3次，开水冲服，其余年龄酌量增减。

主治：小儿高热。

疗效：陈氏报道用上方治疗100例小儿高热，显效57例，有效27例，无效（高热持续不退超过一周）16例。病例：林××，男，10岁，1986年6月25日上午9时就诊。患儿2天来发热，时而升高，以午后至夜尤热，时而略低，经用药治

疗，发热不减，伴恶寒，肢厥，喉痛，咳嗽咯痰黄稠，腹痛呕吐，大便2天未行，小便赤，体温39.6℃，脉搏146次/分，呼吸48次/分，扁桃体（++），充血（++），面赤唇红，舌淡红，苔薄黄，脉滑数。白细胞19600/立方毫米。中性82%，淋巴17%，酸性1%。经用双解散四瓶，每6小时开水冲服一瓶，服后泻下2次，不恶寒，热退到37℃，仍有咳，扁桃肿大减退，充血（±），舌淡红，脉缓滑，继续调治而安。

验证：戴氏用上方验治12例高热急症，疗效卓著。不仅对小儿高热效佳，对成年人高热也有明显疗效。因散剂口服少数人导致恶心呕吐，若改成丸剂即可除去此弊。病例：刘××，男，22岁。1989年9月29日下午4时就诊。患者2天来畏寒发热，头痛伴咳嗽，咽痛，纳差，自服安乃近，头痛未除，热未退而来诊，体温39.4℃，咽充血，白细胞9500/立方毫米，中性57%，淋巴43%，诊为感冒，给予双解丸10克，每6小时1次，同时口服板蓝根冲剂。次日下午热退至37.3℃。调至数日而愈。（戴作明，《新中医》，1990；（6）：56。）

按：此方是儿科著名老中医许小士，参考《小儿药证直诀》、《幼幼新书》等书中有关退热方药研制的中药复方制剂，方中以薄荷、葛根、蝉退疏散风热，使热邪从表而解；以黑丑、大黄泻热通便，使热邪由大便而解；葵仁、前胡、僵蚕清化热痰；蝉蜕与僵蚕尚有熄风定惊防治抽风作用，诸药合用，有良好降热作用。

152. 婴儿湿疹

方名：飞扬外洗方（编者加）

来源：许洁，《新中医》，1985；(9)：2。

组成：新鲜大小飞扬全草30~50克。

用法：将上药洗净加水适量，水煎后洗患处，每日1~2次。

主治：婴儿湿疹。

疗效：许氏用上方治疗8例婴儿湿疹均愈。病例：蓝×，女，2个月。1984年4月25日诊。患儿面颊，腮部，头颈处初期散在红色粟粒样皮疹，后期部分融合成片，夜睡不安数天。诊为婴儿湿疹。即用上方，连用3天，皮疹尽退而能入睡。

验证：陈氏用上方验治7例湿疹，疗效满意。病例：龙×，男，5个月，1986年2月12日初诊。患儿面颊及腮部处，起散在红色粟粒样皮疹，部分融合成片，夜间哭闹不安，诊为婴儿湿疹，用上方连用2日，皮疹尽退而愈。(陈学连，《新中医》，1985；(5)：封三。)

按：大飞扬草为大戟科植物，味辛酸性寒《常用中草药手册》载“清热解毒，祛风止痒”。可治肿毒，湿疹，脚气，皮肤瘙痒等病证。小飞扬草也为大戟科植物，酸涩性凉，《生草药性备要》载：“治小儿飞痒疮满面头耳，脓水淋漓，敷洗消肿毒。”

五官部分

153. 春季卡他性结膜炎

方名：散风止痒汤

来源：山东省著名眼科老中医张皆春。

组成：麻黄 3 克，红花 6 克，茅根 12 克，炒苡仁 15 克，川乌 6 克。

用法：水煎服后熏洗双眼，风寒症状明显，奇痒不可忍者加细辛 3 克；以睑结膜型为主，结膜表面呈暗滞色者加川芎 6 克，云苓 9 克；角膜周围污秽，有膜高起，侵入角膜缘加木贼 9 克。

主治：春季卡他性结膜炎（奇痒症）。

疗效：上方是著名眼科老中医张皆春所创制的治该病的经验方，疗效甚捷。

验证：张氏在临床反复验治，每获良效。病例：郭××，女，15岁，学生，1982年3月25日初诊。患者自述双眼奇痒2年，每到春季必发时达半年，发时经抗过敏及激素治疗好转，但停药即复发。双眼结膜暗红，略显粗糙，角膜周围胶状隆起，给予上方加味（麻黄 6 克，细辛 3 克，红花 6 克，

当归 9 克，茅根 12 克，木贼 9 克，炒苡米 15 克，川乌 5 克，川芎 6 克。水煎，服后熏洗双眼，服用六剂痊愈，随访至 1986 年 10 月未见复发。(张存明，《中医杂志》，1987；(5):44。)

按：春季卡他性结膜炎多由于春暖季节空气中游离的花粉，或其他物质引起的过敏反应。以眼部奇痒，结膜充血，畏光，流泪及有粘稠丝状分泌物为主症。上方中以麻黄、川乌散风祛寒湿，红花活血祛瘀，茅根利尿渗湿，苡仁健脾利湿，合用而有散风止痒之功。

154. 红 眼 病

方名：柴胡麻芍汤

来源：杨灿，《中医杂志》，1987；(7):30。

组成：柴胡 10 克，麻黄 10 克，赤芍 20 克，白蒺藜 10 克，吴茱萸 5 克。

用法：表症明显有热者加银花 15 克，连翘 15 克，生石膏 40 克；白睛红甚者加桑白皮 30 克；脓性分泌物较多者，加黄连 8 克，公英 15 克；视物不清者加菊花 15 克；痒甚者加僵蚕 10 克，蝉蜕；羞明流泪者加山梔 12 克，龙胆草 10 克，谷精草 10 克。每日一剂，水煎分 2 次服。

主治：天行赤眼（红眼病）。

疗效：杨氏用此方治疗红眼病 129 例，服本方一至三剂后症状明显改善不再服第四剂者评为痊愈，共 128 例，另一例因年龄较大，服药 4 剂，并加用氯霉素眼药水点眼而愈。痊愈的 128 例中，服药一剂者 21 例，二剂者 94 例，三剂者 13 例。

验证：余用本方治疗红眼病 157 例，均三剂而愈。本方原名“麻芍柴胡汤”(上海中医药杂志，1964；(8):23)。此方原治急性结合膜炎，角膜炎等，后来杨氏取“火郁发之”之意，加大柴胡用量，以柴胡为君，移用于治疗天行赤眼，取得了较佳疗效。余在临床上用其方治疗急性结合膜炎、角膜炎效果也比较满意。(韩其江，博兴县中医院眼科。)

按：天行赤眼为时邪入侵于目，目为肝之窍，位于上部，方中用柴胡入肝，麻黄发表，吴茱萸善上行以散厥阴肝经之滞，配用清热解毒祛风明目之药，故取佳效。

155. 肝热目赤肿痛

方名：洗药方

来源：陈可冀等，《中医杂志》，1981；(8):16。

组成：蔓荆子 9 克，荆芥 6 克，蒺藜 6 克，冬桑叶 6 克，秦皮 3 克。

用法：水煎趁热洗。

主治：肝热目赤肿痛，外感风热，风火目痛等。

疗效：此方为慈禧治眼病的老佛爷洗药方。对于外感风热，风火目痛，信必有效。对肝热目赤肿痛亦验。

验证：刘氏用上方（也可加黄柏 10 克）加水 800 毫升，煎成 500 毫升后，用纱布过滤。等温度降至摄氏 50 度时，用于洗眼，每日 1 次，效果很好。(刘树翼，《中医杂志》，1982；(12):72。)

按：此方为疏散风热，清肝明目之洗眼医方。方中桑叶苦而微寒，长尤疏散风热以明目，秦皮苦涩而寒，人多识其

治泻痢之功,其疗赤肿痛肝热目亦效,蔓荆子、白蒺藜皆有散风明目作用,荆芥疏风理血解毒,合用外洗治热性目疾而奏效。

156. 化脓性中耳炎

方名: 治耳灵

来源: 李芷春,《新中医》,1981,(12):25。

组成: 川黄连粉 3 克, 黄柏粉 1.5 克, 紫草粉 1.8 克, 氯霉素 1 克, 四环素 0.75 克。

用法: 将以上各药粉末混合起来过 80 目筛后装瓶备用。先把患耳用 3% 双氧水洗拭, 再用细棉棒将耳擦干, 然后把“治耳灵”粉少许吹入耳腔中, 每日用药 1 次。

主治: 化脓性中耳炎。

疗效: 李氏几年来用“治耳灵”治疗化脓性中耳炎多例, 均收到满意疗效。病例: 梁××, 男, 16 岁, 学生。因患中耳炎 10 余年, 双耳流脓不止, 长期中西药治疗不愈。于 1970 年 11 月 1 日来诊。检查左耳: 洗耳后鼓膜中央部和边缘部时针 2 点处均有穿孔可见; 右耳: 耳道内有大量恶臭的脓性分泌物, 洗耳后见鼓膜大部缺如, 有红色肉芽组织增生, 听力减退。按上法治疗 10 天, 脓性分泌物大减, 续治 10 余次则无渗出物, 再施数日巩固疗效而愈。

验证: 韩氏用上方加减 (将紫草粉更换为青黛粉, 疼痛者加红花) 验证 3 例, 疗效满意。病例: 王××, 女, 35 岁。患中耳炎 5 年多, 长期双耳流脓不止, 时多时少, 常用棉球塞之, 伴耳底疼痛, 听力减退, 多次治疗效不显。经用

治耳灵加减治疗，2天后停止流脓，痛止，继用3天以巩固疗效，追访2年未复发，唯觉听力稍差。(韩志有,《新中医》, 1984, (10):封三。)

按：慢性化脓性中耳炎，往往屡用各种抗菌素及其他药物治疗，久治不愈，日久可影响听力或引起其他病症。上方中黄连、黄柏、紫草均属清热泻火燥湿解毒药，据现代药理研究均有抗菌消炎等作用，再与西药氯霉素、四环素同用，中西药配合相互促进，故对产生抗药性、耐药性的慢性化脓性中耳炎收到理想效果。

157. 化脓性中耳炎

方名：蛇蜕散

来源：韦秀伦,《广西中医药》,1978, (2):29。

组成：蛇蜕烧存性，研细末备用。

用法：临用时，先用75%酒精棉签把患耳道清洁干净，然后用细小筒管将药粉少许缓缓吹入耳内，每日1次，严重者每日2次，每次用药前务必要把耳道内清洁干净。一般用药1~2天即可见效。

主治：化脓性中耳炎。

疗效：韦氏应用上方10余年治疗中耳炎30多例，效果满意。病例：黄××，男，8岁。两耳经常流青黄脓液，耳内稍感胀痒不适，无其他全身症状。西医诊为中耳炎，曾用磺胺、抗菌素、滴耳油等药治疗，效果不好，反复发作，历时1年多不愈。后用蛇蜕末照上法用药3天即愈。随访6年未见复发。

验证：笔者用上方验治12例中耳炎患者，均获良效。病例：古××，男，25岁，滨州印染厂职工。患中耳炎10年余，两耳间歇性流黄白色脓液，耳内时常痛痒。每遇心情不畅、或劳累，或感冒后易复发，听力稍有减退。经几家医院检查诊为慢性化脓性中耳炎，曾用过多种抗生素治疗，仍缠绵不愈。改用蛇蜕散治疗2天，流脓即止，连续用药一周而愈，听力正常，随访3年未见复发。（孙仕田，惠民地区中医院。）

按：蛇蜕，又名蛇退或龙衣等，即蛇在野外自行脱下的皮。其性平，味甘咸，具有祛风消肿，解毒退翳等功效。研末外用治中耳炎，即方便又经济。

158. 酒 渣 鼻

方名：治酒渣鼻验方

来源：陈华显等，《新中医》，1983，（8）：35。

组成：百部、苦参、雷丸。

用法：上药各研成极细粉末，然后以5：2：2的比例混合，搅匀后取药粉15～20克，与雪花膏80～85克混合，制成15～20%的药物雪花膏霜。每晚睡前用硫磺皂清洗面部，然后外搽，翌日清晨洗去。20天为一疗程，可连用2～3个疗程。在初用本药数天皮损症状可加重，以后逐渐好转乃至痊愈。

主治：酒渣鼻（又名玫瑰痤疮）。

疗效：经多年应用，收到良好效果。病例：李××，男，48岁。患酒渣鼻20余年，皮损除鼻尖部外，鼻翼、颊

部、额部和前额均受累，患者曾到中山二院皮肤科诊为酒渣鼻。10多年来遍治无效，经用上方治疗3个疗程而愈，至今未发。

验证：杨氏用上方验治2例酒渣鼻患者，均用药一次即获痊愈。病例：邹××，女，21岁，职工，1983年8月27日诊。患酒渣鼻2年多，经治以肤轻松外涂擦，地塞米松肌注等均未效，后又经某院用中西药治疗效仍不显，经用上方试治，翌日患者欣然来告用药1次即干燥结痂，未再用药，7天后变软，皮损渐愈，红斑渐退，观察至今未见复发。（杨智章，《新中医》，1984；（10）：封三。）

按：酒渣鼻，又名玫瑰痤疮，俗称酒糟鼻、红鼻子。祖国医学称酒皰鼻、酒皰鼻。是青壮年男女均见的一种常见病，由于皮疹发生在颜面部而且经久不愈，因而影响容貌。陈氏通过广泛的病因学调查发现本病与毛囊虫（毛囊脂螨）感染有关，因此选用百部、苦参、雷丸等杀虫止痒的中药研末配成膏，局部外搽而收显效。

159. 过敏性鼻炎

方名：桂枝汤加味

来源：来春茂，《新中医》，1978；（1）：4。

组成：桂枝、白芍各9克，炙甘草4.5克，生姜3片，大枣5枚，葶苈子15克，蝉蜕9克。

用法：桂枝汤水煎，葶苈子、蝉蜕二味共研末分3次吞服，用汤药送下，1日服完。气虚者加黄芪、党参、白术，鼻流稠涕、色黄者，加黄柏、黄芩，头痛鼻塞甚者选加藜

本、川芎、白芷、僵蚕、辛夷花、苍耳子；鼻流清水难以休止者加五味、诃子、乌梅。

主治：过敏性鼻炎(鼻内发痒，鼻塞，打喷嚏，流清涕，淌眼泪，头胀痛，反复发作，嗅觉失常等)。

疗效：来氏用上方治疗过敏性鼻炎20例，疗效满意。病例：黄××，女，29岁，1975年1月14日来诊。患者自述，阵发性鼻痒，喷嚏连声，流白清涕，鼻塞，头痛，反复缠绵2年之久，冬季寒风刺激后尤重。经中西医多次治疗未效经用上方六剂而愈。

验证：罗氏用上方略作加减治疗过敏性鼻炎多例，追访2例，疗效确切。病例：章××，女，40岁，干部，1984年9月14日诊。自述多年苦于鼻痒，喷嚏，流涕，时轻时重，缠绵不愈，每遇风寒或烟雾刺激诸症加重，甚则不能低头或坐立，严重影响工作。经用上方加减(桂枝、防风、蝉蜕、白芍各9克，白术15克，黄芪30克，甘草6克，生姜3片，大枣5枚，若流稠涕，色黄再加黄芩、鱼腥草各9克)，服五剂后症减，继服七剂，诸症痊愈。追访半年余未复发。(罗克亮，《新中医》，1986；(6)：封三。)

按：过敏性鼻炎又称变态反应性鼻炎，多因对冷空气、烟雾等物质过敏所致。中医称“鼻渊”。来氏认为其所以奏效在于加葶苈子、蝉蜕二味。考葶苈子入肺、膀胱经，历能祛痰行水下气定喘，蝉蜕入肺肝二经，其质轻浮，有开肺平肝，散风清热之效。二药一降一升，治节有权，营卫和，风浪静，故鼻炎痊愈。上方是否有脱敏作用，有待于今后观察研究。

160. 梅核气

方名：金银花合剂

来源：张国卿，《中医函授通讯》，1987；（3）：67。

组成：金银花25克，胖大海10克，白芷15克，花粉15克，连翘20克，清夏15克，莱菔子15克，苏梗15克，厚朴15克，甘草10克。

用法：水煎服，早晚各服1次。

主治：咽部神经官能症（梅核气）。

疗效：张氏用上方治疗梅核气36例，治愈32例。病例：赵××，女，65岁，1973年2月诊，喉中不适有异物感2年，胸闷气短，咽干，咽喉觉梗塞如梅核，饮食无妨碍。经用消炎药及中药治疗效不佳。服上方12剂后症状消失，随访至今未复发。

验证：笔者应用上方治疗梅核气近10例，疗效卓著。病例：张××，50岁，工人。1985年5月初诊。有咽炎病史3年。咽部不适，咽干湿痛反复发作。近3日复发，咽部生疼，查咽赤，咽后壁滤泡增生，经服西药乏效，给予上方加知母、川贝母各12克，共服六剂，诸症悉除。（范立孝、魏会东，桓台县医院。）

按：本方综半夏厚朴汤之意，行气解郁，降逆化痰。另加双花、连翘清热利咽，加白芷、花粉消肿散结，胖大海开肺利咽，配莱菔子、苏梗以理气祛痰，合用对因气郁痰凝之梅核气而有效。

161. 寒性咽痛

方名：干姜附子汤

来源：李肇翬，《新中医》，1987；（3）：43。

组成：熟附子15克，干姜10克。

用法：文火久煎频服

主治：寒性咽痛（咽部不红不肿不渴不热，苔白，脉不数为主症）。

疗效：李氏用上方治疗阳虚寒滞咽痛症，疗效较佳。病例：李××，男，40岁，1986年4月16日诊。患者6天前患风寒感冒，经治诸症悉减，但遗留咽痛，曾口服红霉素及肌注青霉素，咽痛不但不减，反而加重，甚至不能进食及讲话，诊见患者面色觥白，身冷恶寒，口淡不渴，不思饮食，微有咳嗽，吐少许白色痰液。查咽峡部不红不肿，扁桃腺不大，咽后壁无滤泡增生，舌淡，苔白，脉沉紧，证属外感寒邪，滞结于咽部所致。投熟附子15克，干姜10克，二剂久煎频服。4月17日下午再诊，药未尽剂而咽痛大减，已能进食言谈，嘱其将原药服完遂告痊愈。随访至今未复发。

验证：霍氏素体阳虚，4月26日开窗午休，感邪致咽痛，不红、不热、不肿，扁桃体无肿大，口淡不渴，口吐丝状粘涎，疼痛每因遇寒刺激加重，舌淡苔白，边有齿痕，脉沉紧。期间屡用青霉素、病毒灵及广谱抗菌素治疗一周多，痛无减轻。后改内服中药清热解毒三剂，外吹冰硼散后咽痛反而加重，进食言谈均困难，苦不堪言。经用干姜10克，附子15克，久煎频服，二剂咽痛大减，三剂告愈，疗效卓然，

迄今未发。(霍建栋,《新中医》,1988;(4):封三。)

按:咽痛一症,属外感风热及阳盛阴虚者多见,但寒性咽痛也不罕见,临床以不红不肿,不肿不热为主症(如霉菌性咽炎等)。若不细心辨证,误用寒凉清热,非但不效,反而加重。由此可见辨证施治是何等重要。

162. 急性咽喉炎

方名:半夏散加味

来源:赵胜权,《新中医》,1984;(3):28。

组成:姜半夏12克,桂枝、白茯苓、炙甘草各10克,干姜5克。

用法:水煎服。

主治:急性咽喉炎,(喉痹,少阴寒邪凝滞咽喉)。

疗效:赵氏用上方治疗寒性咽痛多例,每收良效。病例:鲍××,男,33岁。咽痛涉旬,起于外感。西医诊为“急性咽喉炎。”曾用四环素、青、链、红霉素等药物治疗不效。转诊中医,按“炎症”投五味消毒饮加牛蒡子、桔梗、甘草之类,药进三剂,病势不衰。又以为“寒之不寒,是无水也”,改用玉女煎滋阴降火法,药后咽痛更甚,且增阻塞之感。诊见面色萎黄,精神不振,咽喉疼痛,充血不甚,唾液下咽,促额蹙眉,知饥畏食,舌苔薄白,脉弦缓。脉症合参,证属少阴寒邪凝滞咽喉,清阳欲升不能,两相搏结使然。治宜辛散通阳,予上方一剂后即觉咽痛大减,阻塞感消失,服尽二剂,病痛全瘥。饮食增,精神好,减轻药量,原方继进二剂以收全功。

验证：张氏用上方验治1例幼儿园女教师，因外感致咽喉痛，曾以西药百炎净及杜灭芬喉片治疗3天无效，经用普济消毒饮二剂也未效。贵刊喉痹一案与此证甚为合拍，顿开茅塞，即照原方先投一剂，次日复诊自述喉痛已好4~5成，再投一剂而愈。（张楚章，《新中医》，1984；（9）：封三。）

按：咽喉痛临床上属热证者多，上方所治之证是属少阴寒邪凝滞咽喉，若辨证不准，误苦寒清热泻火之药，则雪上加霜，寒上加寒，不但不效，反而加重，若辨证准确，大胆应用干姜、桂枝辛温散寒，通阳散结，用半夏、茯苓燥湿化痰，炙甘草甘缓和中利咽。使清阳升，痰浊降，阴霾散而咽痛除，故能收桴鼓之效。

163. 慢性咽炎

方名：利咽汤

来源：赵明亮，《大众中医药》，1987；（2）：27。

组成：天冬15克，麦冬15克，生地15克，元参15克，天竺黄9克，杏仁9克，桔梗20克，甘草20克，蝉衣8克。

用法：水煎服，每日一剂。咽部充血明显加山豆根10克，胸中窒闷者加瓜蒌15克。

主治：慢性咽炎。

疗效：上方是赵氏治慢性咽炎的自拟经验方，对主要表现为长期而持续的咽部干涩疼痛，舌红少苔等以阴虚为主的患者，收到满意效果。

验证：笔者患慢性咽炎，多方求治效果不佳。试用上方而获效。（周西林，《大众中医药》，1987；（4）：封三。）

按：慢性咽炎是一种常见病，多发于上呼吸道反复感染之后。其表现可见长期而持续的咽部干涩疼痛，有如异物堵塞之感，甚至胸中窒闷，咽部轻度或中度充血。祖国医学可分为热盛，阴虚、痰凝等证型。上方适于以阴虚为主症的患者。方中以天麦冬、生地、元参滋阴清热，润肺利咽；以桔梗、天竺黄祛痰散结；以杏仁、蝉衣宣肺利咽；甘草清热解毒；调合诸药，合用共奏养阴化痰，利咽散结之功。

164. 声带息肉

方名：会厌逐瘀汤加減

来源：赵兴周，《中医杂志》，1982；(3):32。

组成：当归15克，赤芍15克，生地15克，丹参15克，桔梗15克，玄参20克，柴胡15克，甘草10克，蝉衣10克，海浮石20克，红花10克。

用法：水煎服，每日一剂。

主治：声带息肉。

疗效：赵氏用上方治疗声带息肉兼有血瘀者3例，均治愈。

验证：查氏用上方加味治愈1例声带息肉患者。病例：宋××，男，23岁，干部。失音3年多，经西医确诊为“声带息肉”，先后手术摘除2次，术后息肉复生；曾服中西药甚多，息肉未消，声仍嘶哑，于1979年春来诊。检阅所服中药，不外清肺开音，清滋润肺，间用活血化瘀，化痰散结之品。切诊脉迟，尺部尤细。语声沙哑，咽喉干涩，喜进热饮，畏寒，足冷尤甚。追询3年前起病之由，则述因长时间领呼

口号后，即觉咽干，随即饮冷开水两大碗，次日渐觉声音嘶哑，继即语而无声。此证初因气阴伤而复加寒遏，更兼服清凉之剂以致寒凉冰伏，久而损及肾阳酿成痼疾。治以温肾阳，行瘀滞，投以会厌逐瘀汤加附子、肉桂服三剂后效果明显，继服七剂，声已不嘶，诸症消失。请五官科复查息肉已消除。后以喉科六味汤加味煎汤代茶以善其后，并嘱忌冷饮，追访至今未复发。(查华清,《中医杂志》,1983;(4):79。)

按：声带息肉是喉科常见病。多以声音嘶哑为主症，祖国医学认为病机是痰湿积滞，气滞血瘀。上方适宜于声带充血、瘀紫、肥厚属气滞血瘀者。方中红花、当归、赤芍、丹参活血化瘀，生地、玄参养阴清热，柴胡、海浮石开郁化痰散结，桔梗、甘草、蝉衣清利咽喉以开音，合用共奏活血化瘀养阴清热散结之效，故可使息肉消除而免于手术之苦。

165. 口腔溃疡

方名：双黄煎

来源：赵荣胜,《新中医》,1983;(8):20。

组成：黄连，元明粉各5克，黄柏，乌梅各10克。

用法：将黄连、黄柏、乌梅水煎2次，滤液混合，元明粉入药汁内溶化备用。每以上药漱口，每次含漱1分钟，每日10次左右。

主治：口腔溃疡（口疮）。

疗效：赵氏多年来用上方治疗口疮，效果满意。病例：王××，男，21岁，1978年10月25日初诊。外感发烧后口腔粘膜及舌尖出现绿豆或米粒大小溃疡近10处，焮热作痛，舌

质红，脉细数，曾用冰硼散及维生素C、维生素B₂等药治疗一周，未见好转，遂用上法治疗3天溃疡消失。

验证：俞氏用上方验治32例口疮（慢性口腔溃疡证）患者，均取得良好效果。若加入麦冬12克疗效更佳。病例：潘×，女，25岁，教师，素有口疮史，每当食辛热之物即发，多方医治均没根治，经用上方加麦冬12克，如法含漱一剂痛止，二剂症消，1年多未再复发。（俞瑜，《新中医》，1989，（10）：封三。）

按：口舌生疮，以阴津不足心脾积热者多见，故用黄连，黄柏、元明粉清热泻火，乌梅酸敛生津以养阴，标本兼顾。用含漱方法治疗，不仅能使药物直接发挥作用，而且对口腔起清洁消毒作用，利于溃疡面的愈合。

166. 溃疡性口腔炎

方名：蛋黄油

来源：肖志安，《新中医》，1983；（3）：18。

组成：鸡蛋2个。

用法：将鸡蛋煮熟，取蛋黄放入铁勺内。先用文火烤至蛋黄变黄，以后用武火烤出油，去渣取油，装瓶备用。局部用1:5000高锰酸钾溶液轻洗疮面，再用淡盐水把局部坏死组织及高锰酸钾液冲洗干净，然后把配好的蛋黄油涂搽患处，每日1~2次。

主治：溃疡性口腔炎。

疗效：肖氏用上方治疗20余例婴幼儿溃疡性口腔炎，一般搽1~2天可愈。病例：温×，男，2岁，发热2天，口不

能张，烦躁不安，进食时啼哭不止。查唇内，舌、颊、腭等处出现大小不等的溃疡，口角已溃破影响吸收和进食。曾用龙胆紫、冰硼散、维生素B等药治疗无效，改用蛋黄油外涂2天后痊愈。

验证：钱氏用上方治疗5例成年慢性口腔溃疡均获满意疗效，病例：戴×，男，23岁，战士，1983年5月16日来诊。患口腔溃疡并常发作(约每月发作1次)已2年余，曾多次用中、西药效不佳。发时灼痛异常，进食受刺激时尤甚，经上方治疗3天即愈，随访半年未复发。(钱圣益，《新中医》，1984，(10):封三。)

按：《本草纲目》载：“蛋黄补阴血，解热黄……”《日华子本草》曰：“炒取油和粉敷头疮。”据报道蛋黄油除治溃疡性口腔炎外，还能治烧伤、静脉曲张性溃疡、麻风溃疡及皮肤湿疹等病症，其作用机理有待于进一步研究。

167. 顽固性口腔溃疡

方名：治口腔顽固溃疡方

来源：许姜泽，《中医杂志》，1982，(9):33。

组成：党参15克，生黄芪30克，沙参10克，元参30克，麦冬30克，山豆根5克，当归6克，银花10克，生甘草10克。

用法：水煎分3~4次服，日一剂。

主治：顽固性感染性口腔溃疡。

疗效：许氏用上方治疗本病9例均治愈，平均每人服药33剂，经半年以上复查均良好。病例：一女性患者，40岁，1979年1月12日就诊。患者于1977年7月14日在咽后壁处出

现大面积溃疡，曾经几所医院用中西药物治疗未愈。诊见溃疡面积为25毫米×23毫米，表面有灰白色假膜，周围稍发红，口腔他处粘膜还有几个复发性小溃疡，口干咽燥，面色萎黄，纳差，消瘦，头晕心悸，腰膝酸软，畏寒乏力，手脚浮肿，舌质红，苔薄黄，脉象沉细数。服上方六剂后，溃疡明显好转，继服10剂溃疡完全愈合，其他症状明显减轻。咽部溃疡至今2年多未复发。

验证：陆氏用上方加减治愈1例投寒剂不愈的口疮。病例：陈××，男，25岁，1981年6月13日初诊。口疮发于舌边及口内两侧，时发时敛，已历二载，劳累或失眠为其诱因。近因连续加班，口疮又发，已逾一周，曾投寒剂，口疮不减，反增胃痞作胀。口腔及舌边可见大如黄豆，小似芝麻之溃疡多处，疮面不红，舌淡花剥，舌边多齿印，脉濡滑。症属中虚清阳上升，阴火乘脾胃元气之虚而上炎。治宜健脾益气升清，少佐苦温以敛阴火。处方：生黄芪12克，党参9克，白术9克，土炒山药12克，茯苓9克，炙甘草4克，当归6克，陈皮6克，柴胡4克，炙升麻6克，炮姜4克，服四剂后，口疮愈，花剥之舌已布薄苔，舌质仍淡，边多齿印，以补中益气汤加减善后。（陆惠铭，《中医杂志》，1982；（12）：73。）

按：许氏认为本病不是复发性口疮，也不是复发坏死性粘膜腺周围炎，更不是口腔恶性肉芽肿性溃疡。本病虽经长期治疗常不易愈合，血象检查有的白细胞增多，故暂名为顽固性感染性口腔溃疡。本病虽有炎症现象，但用目前的抗感染药物及加强营养仍不愈合，应用中药治疗确能收到满意效果。陆氏又将此方加减，用治慢性口疮，反复发作，用寒凉不减者也收到良效。

168. 复发性口腔溃疡

方名：滋阴丸

来源：许姜泽，《中医杂志》，1987；(4)：39。

组成：生山楂10克，麦冬、元参、天花粉、生地、生甘草、白芍各20克。

用法：按此比例制成水丸，日服2次，每次10克，温开水送服。对于消化能力较差者，可将丸药研末冲服，或用温开水浸泡丸药后服用。

主治：复发性口腔溃疡，舌痛、口干综合症，舌裂沟痛等。

疗效：许氏近年来应用上方治疗数种口腔疾患，效果较好。病例：刘××，男，68岁，1982年3月12日就诊，患者诉10多年来经常起口疮，间歇期很短，经某医院用抗生素、左旋咪唑、灭滴灵等乏效。检查：舌背前部左右皆有绿豆大溃疡，周围红晕，口干、疼痛，大便干，舌质红，苔白腻，脉弦滑。诊断为复发性口疮。内服滋阴丸240克，溃疡愈合，其后很少复发。口干及大便干亦除。

验证：笔者曾遇一男性患者，50岁，复发性口疮16年，每感冒后口疮必复发，经用抗生素、维生素等药疗效甚微。来诊时口腔内粘膜及舌面散布大小不等的溃疡面，口干，说话时疼痛难忍，舌质红，少苔，脉弦数。知系病后津液亏损，阴虚火旺所致。给予滋阴降火数剂，收效甚微。翻阅杂志，偶得此方，嘱其用上方加黄连10克，制成水丸，每次10克，每日2次，服用120克时，溃疡基本愈合，继服以固疗效。

后遇患者告之，自服用上方后，复发次数减少，有时高热时复发，但较轻微，服上药同样有效。（范立孝、魏会东，桓台县医院。）

按：方中用元参、麦冬、天花粉、生地、生甘草以滋阴降火治其本，生山楂消食化积以助脾胃运化，使阴津有生化之源，白芍酸寒，养血敛阴，诸药合用，滋阴降火，对阴虚火旺之口腔溃疡，确有疗效。

169. 口 腔 溃 疡

方名：口疮方

来源：张珍玉，《中医杂志》，1987；（12）：53。

组成：煅炉甘石2克，人中白（煅）1克，青黛2克，冰片0.3克，枯矾0.5克。

用法：上药共为极细末，放瓶中收贮，盖严勿受潮湿。用时将药末搽于患处，1日1次。

主治：口腔溃疡（口疮）。

疗效：上方为张教授祖传验方，临床应用收到满意效果。病例：李××，女，2岁，患口腔溃疡已半个月，吮奶困难，口流涎。经服核黄素及搽冰硼散无效。用本方搽涂一次即愈。病例：刘××，62岁，患口腔溃疡5~6年，时愈时发，经用本方治疗3次即愈，10余年未复发。

验证：笔者在临床中，常遇口腔溃疡，以婴幼儿多见。小儿服药困难，应用上方即方便，见效又快。病例：孙××，男，3岁，患口疮近1年，时愈时发，经常服用核黄素、维生素C及西瓜霜外涂，疗效甚微，经用上方治疗5次即愈，

未再复发。(魏会东、范立孝,桓台县医院。)

按:本方对无论何种原因引起的口疮均可应用。方中煅炉甘石有燥湿消肿收斂生肌之功,据药理分析,其主要成份为氧化锌,有中度的防腐、收斂,保护创面的作用,青黛清热解毒,有抑菌作用,二药配合能增强防腐生肌的功效。人中白降火、散瘀血,善治咽喉、口舌生疮;枯矾清热燥湿解毒杀虫;冰片消风散郁火,清热止痛。诸药配合,燥湿收斂,化腐生肌,清热止痛,促进溃疡愈合。

170 牙周炎、牙髓炎

方名:牙痛验方

来源:苏晓燃,《新中医》,1983;(1):50。

组成:生石膏30克,鲜生地12克,牡丹皮10克,川黄连9克。

用法:水煎服,每日一剂,痊愈为止。

主治:胃火牙痛,齿龈肿胀出血等。(牙周炎、牙髓炎等)。

疗效:苏氏用上方治疗50余例牙痛患者均收到满意疗效。病例:陈××,男,28岁,工人。牙痛间断发作半年,服用四环素、维生素C,症状稍见缓解,停药又复发。1981年8月前来诊治。自诉因牙痛不能进食,夜间不能入睡已经2天,诊视左腮肿胀,口舌糜烂,牙龈红肿伴有点状溃疡,舌红苔黄厚,脉洪略数,症属胃有积热,胃火过盛上冲,投予上方一剂,次日牙痛止,续二剂诸症悉除而愈。近期随访未见复发。

验证：王氏用上方验治15例牙痛患者，全部治愈。(王金学,《新中医》,1984;(11):封三。)

按：牙痛的原因很多，上方所治的牙痛是以胃有积热，火盛上冲所致。方中石膏专清胃经实热，生地、丹皮清热凉血，黄连清热泻火解毒，诸药合用故对胃火过盛，循经上炎而致的牙痛及齿龈肿胀疼痛、流血均有良效。

171. 各种牙痛

方名：牙痛灵

来源：李细茂,《新中医》,1988;(6):54。

组成：沉香、丁香、木香、小茴香各20克，杏仁、陈皮各15克，香附、川楝子各25克。

用法：将上药浸泡于70%酒精500毫升，密封贮存1个月，加入冰片、薄荷脑、麝香少许，溶化后即可使用。用时取棉签点少许药液涂搽患牙周围即止痛，1分钟后连口水一同吐出(切勿吞下)，每日3~4次，无不良反应。

主治：各种牙痛。

疗效：李氏用上方治疗各种牙痛52例，均涂药2~4次而愈，个别病人仅1~2次愈。病例：姚××，男，52岁，1985年12月20日左上侧牙痛，面部肿胀2天多。经用青霉素、去痛片治疗无效而来诊。经用“牙痛灵”药水少许涂擦后，疼痛即减轻，因牙龈发炎，配以牛黄解毒片内服。经多次涂擦，第二天下午肿痛全消而愈。

验证：罗氏用上方验治72例各类型牙痛患者效果特别好。一般涂擦1次痛止，最多涂擦3次，虽肿不消，但牙已

不痛。病例：郭××，女，54岁，农民，装全口牙，全下牙龈痛，于1989年20日来诊，仅涂擦2次肿消痛止，数日无复发。(罗洪武，《新中医》，1990；(9)：封三。)

按：李氏自制“牙痛水”中沉香、丁香、木香、香附、小茴香、麝香及川楝子均有明显的止痛作用，杏仁、陈皮疏畅气机，冰片、薄荷脑，即能散热止痛，又能防腐消肿，经酒精浸泡后，药液局部涂擦故起止痛速效。

172. 各种类型牙痛

方名：牙痛验方

来源：徐成林，《新中医》，1984；(2)：56。

组成：闻药、木鳖子(去壳)，草蓰各100克，冰片10克。煎剂：花椒、细辛各3克，白芷、防风各10克。

用法：将闻药研末后混合均匀，装瓶密闭，备用。患者就诊时取备好的小药瓶一只，装入闻药贴近鼻孔，吸入其气味，二鼻交替进行，5~10分钟后即可止痛。用后盖封，以备再用。

将煎剂药用水300毫升，煎取100毫升，如牙痛因热刺激痛加重者，待药凉后含漱，因冷刺激加重者趁热时含漱，1~2分钟后可咽下。

主治：各种类型的牙痛。

疗效：徐氏用闻药与煎剂含漱并用于治疗牙痛50例，疗效满意。病例：李×，男，30岁。因持续牙痛3天，进冷食及夜间疼痛加剧，经服止痛片效不显。查—| $\frac{1}{6}$ —远中面现一龋洞，无明显红肿及叩疼，即用上闻药吸入5分钟后痛止，并

含服中药二剂后痊愈。

验证：文氏用上方验治1例长期牙痛病人，疗效甚好。
病例：阎×，女，30岁，常牙痛影响工作，进热食水均可加剧疼痛。夜不能入睡，用西药效欠佳。—— $\frac{7}{6}$ 可见米粒大小空洞，经用上方四剂后痊愈。（文小平，《新中医》，1988；（5）：封三。）

按：木鳖子苦寒有毒具散热消肿，化毒止痛之功，葶藶辛热温中散寒，行气止痛，冰片散热消肿止痛，上药为散通过嗅气味而起止痛作用。川椒味辛而温，借辛辣麻醉之性而起止痛杀虫作用，细辛、白芷、防风皆能祛风止痛，水煎含漱后内服以止牙痛。外用内服，功同力专，故对各种牙痛均有效。

173. 三叉神经痛

方名：曙光三叉神经痛方

来源：马瑞寅，《中医杂志》，1980；（12）：27。

组成：荆芥炭9克，炒元胡12克，白蒺藜9克，嫩钩藤（后下）12克，生石决（先煎）30克，白僵蚕9克，蔓荆子（炒）9克，香白芷4.5克，广陈皮4.5克，全蝎粉（吞服）3克。

用法：水煎服，每日一剂。可以短期服用，也可长期服用，并无特殊不良反应。

主治：三叉神经痛。

疗效：马氏报道用上方治疗本病32例，治疗期间停用其它药物，经长期观察随访，显效占62.5%。（即在1个月内疼痛发作停止者为显效。停月1年以上未复发者8例，有复发

者12例，但程度较前为轻，平均缓解期为6个月，效果较满意。病例：李××，男，44岁。右侧颜面口颊部发作性刺痛已5年，每于讲话、喝水时辄发，5年中病势逐渐发展又屡治少效，于1977年4月来我院神经科门诊诊治。神经系统检查阴性。拟诊：右三叉神经痛。经服本方七剂后痛止，续服14剂，直至1980年4月右颜面又见复发，其间疼痛静止3年整。

验证：笔者用上方验治3例，有显效者2例，好转1例。

病例：张××，男，48岁，农民。右面颊刺痛有2年，时有如刀割样感，逐渐发展呈阵发性抽痛，历时数10秒，或一二分钟，遇凉热刺激均促发剧痛。经到地区人民医院检查，神经系统阴性。拟诊：三叉神经痛。1989年3月2日来诊，服上方，五剂后好转，后连用15剂疼痛消失，又继服五剂以固疗效。1991年2月随访，未见复发。（朱培训，博兴县阎坊分院。）

按：三叉神经痛是神经科的常见病，在祖国医学中叫“面痛”、“头风”、“偏头痛”等。因多偏在一侧面部，又为阵发性抽痛，故认为阴虚阳亢，肝胆之火升腾无度所致。今用生石决，钩藤镇肝清热，滋阴潜阳，息风解痉；白蒺藜、蔓荆子，香白芷祛风疏肝行气止痛；元胡、全蝎活血散瘀通络止痛；白僵蚕化痰止痉；陈皮理气。共凑以达阴滋阳潜，风息络通之功。

174. 面神经麻痹

方名：牵正膏

来源：段成华，《中医杂志》，1981；（4）：61。

组成：蓖麻仁10克，松香30克。

用法：将上药分别研细末。取净水2斤煮沸后，倒入蓖麻

仁,煮5分钟,入松香,小火煮3~4分钟,倒入备2斤冷水盆中,捻收成膏。切成糖块状(约3克)备用。用时将膏药用热水烫软(不溶于水),捻摊在小圆布上,贴敷患侧下关穴,用胶布固定,每贴7~10天,一般三贴见效。

主治:面神经麻痹(面瘫)。

疗效:上方是王振明老中医治面瘫的经验方。20余年来治愈近100例。

验证:刘氏用上方验治4例面瘫,效果很好。但须将原配方改变为按原药量先将蓖麻仁捣成膏状,再把松香末放沸水中煮3~4分钟,将水倒出,乘松香呈粘状时,快速与生蓖麻仁膏融合一起即成“牵正膏”;再切成糖块状(约3克)使用,这样更能充分发挥药力。(刘瑞起,《中医杂志》,1982;(4):77。)

按:蓖麻子甘辛性平,有毒。《本草纲目》曰:“其性善走,能开诸窍经络,故能治偏风失音,口噤,口目喎斜、头风,七窍诸病。”松香具有祛风燥湿拔毒生肌等功效,二药制成膏药外贴对面瘫有较好效果。

175. 面神经麻痹

方名:面瘫方

来源:张文明,《新中医》,1983;(12):27。

组成:当归、川芎各10克,蜈蚣3条,蝉蜕6克,甘草6克,鲜地龙10条(焙干酒炒同煎),乌附片(先煎半小时)、防风、钩藤、僵蚕各13克。

用法:上药水煎3次,分3次温服,每日一剂,饭后服。

主治:面瘫(面神经麻痹及面肌痉挛)。

疗效：张氏用上方治疗面瘫24例，治愈20例，无效4例（其中1例由脑瘤所致，2例由化脓性中耳炎所致，1例病程已达3年之久）。病例：郭××，男，58岁，1977年8月3日就診。当天下午觉头晕，突然仆倒在地，扶起后先觉右侧手足不能动，随即面肌肉有跳动感，口眼向左侧歪斜，神识清楚，检查合作，语言微有不利，尚能少量饮食，舌质淡，苔白厚腻，脉沉滑。证属风痰之邪闭阻经脉，痰浊上扰清窍，治以面瘫方合补阳还五汤加味，共服12剂，诸症恢复。

验证：孙氏用上方验治2例面肌痉挛患者，取得满意疗效。病例：王××，男，54岁，于1年前，曾患面神经麻痹症，经治病情好转。约半年后出现左侧面肌痉挛，发作无时，精神紧张或激动时发作尤频，挛缩程度亦明显加重，发作时症见面肌抽搐，眼裂变小，口角喎斜，露齿，约半分钟左右自行缓解，饮食二便正常，脉弦缓有力。拟面瘫方略作加减，服八剂而愈。追访5个月未见复发。（孙巨文，《新中医》，1984；（12）：56。）

按：方中以蜈蚣、地龙、僵蚕等虫类药搜剔经络风邪，防风、蝉蜕、钩藤祛肌肤之风邪，当归、川芎养血活血，以取“治风先治血”之意，附子祛风散寒温经通络，甘草调和缓急，诸药合用，共奏祛风散寒养血通络之功，故对面神经麻痹和面肌痉挛均有一定疗效。

176. 面肌痉挛

方名：解痉汤

来源：王永安，《山东中医杂志》，1982；（1）：19。

组成：党参、黄芪、鸡血藤、酸枣仁、柏子仁各15克，

白术、内金、砂仁、当归、白芍、五味子、木香、山药、茯神各9克，甘草6克，朱砂、琥珀各1.5克(冲)。

用法：水煎服。伴有头痛者加白芷、蔓荆子；耳鸣者加蝉蜕；恶心呕吐者加竹茹、半夏；头晕者加天麻。

主治：面肌痉挛。

疗效：王氏用上方治疗41例面肌痉挛，其中治愈11例，好转28例，无效2例。病例：王××，男，42岁，干部，1980年3月7日初诊。患者右侧面部肌肉抽搐，掣动目唇已5年，呈阵发性，抽搐最多可达每分钟50余次，发作时右眼睑闭合，伴有心烦易怒，经××医院诊为“面肌痉挛”，曾用安定、鲁米那、利眠宁、谷维素，针灸等治疗，均无明显效果，患者有肝炎史。检查：舌苔白厚、脉弦、右侧面部肌肉频繁抽搐，心肺(-)，腹软，肝脾(-)，给解痉汤治疗，服药8剂，病情略有好转。检查：舌苔脉象同前。续服上方治疗。1980年3月28日面肌抽搐已停止。至1981年2月25日面肌抽搐未发作。

验证：李氏用上方验治于临床，疗效可靠。病例：王某，男，46岁，右侧面部抽搐3个月，经某医院用安定，维生素B₁，潘生丁，局部封闭，无明显效果，近日又增患侧耳鸣，听力减退，因用西药无效，随来中医治疗。初诊患者右脸抽搐，兼口唇掣动，发作时约每分钟50余次，右侧眼球略小。夜间睡觉也抽搐，并有失眠，心烦等症，舌淡，苔白，脉沉弦。当即针灸合谷、四白、地仓、颊车、风池等穴，并给予顺风匀气散合牵正散6剂，每日1剂，针灸隔日1次。一周后症状略有改善，抽搐次数减少，心烦、失眠稍好，考虑病程长，治疗时间也必须相应长一些。又治疗二周，症状无甚

进展,而我行医10几年,临床见此症为首例,故查一些杂志,也未得见,后在贵刊见有王永安医师治疗抽搐的报告,便停用针药,改用解痉汤治疗,服6剂,症状大为改善,继服12剂痊愈。(李长春,《山东中医杂志》,1988;(7):36.)

按:面肌痉挛又称面肌抽搐,为阵发性不规则的半侧面部肌肉抽搐。西医药对此病治疗效果不理想。王氏用中药治疗该病,取得较为满意的效果。因脾主肌肉,其荣在唇,故用党参、白术、内金、山药、砂仁健脾调胃;黄芪补气,当归、白芍补血;鸡血藤温经通络;酸枣仁、柏子仁、五味子、茯神、朱砂、琥珀、养心安神。也可随证加减治疗。

177. 流行性腮腺炎

方名:治腮腺炎方(编者加)

来源:杨增昌,《新中医》,1987;(1):27。

组成:内服方:银花、连翘、板蓝根、玄参、蒲公英、白僵蚕、升麻、柴胡、甘草。

外用方:生大黄、青黛各等分。

用法:内服方酌定用量,水煎服,轻型每日一剂,重型每日二剂。外用方先将大黄研为细末,再加青黛研至均匀,用鸡蛋清或米醋调为稀状,外敷患处,每日换药1~3次。

主治:流行性腮腺炎(痒腮)。

疗效:杨氏报道用上方加减治疗本病79例,均全部治愈。其中66例用药3天而愈,其余13例均用药4~6天而愈。病例:夏×,女,7岁,于1983年11月29日就诊。3天前因发热,咳嗽,咀嚼时有酸涩感,经用链霉素、鱼腥草等治疗2天,症

状加重而来诊。证见两侧腮部肿如鸡卵大，皮色光亮，边缘不清，触之腮部灼热胀痛，拒按，咀嚼困难，憎寒壮热，体温 38.6°C ，咳嗽痰黄，舌红，苔黄，脉弦数，经用上方加减内服和外敷，3天而愈。

验证：韩氏用上法验治10例腮腺炎，疗效甚佳，均治愈。病例：陈×，男，6岁，1987年3月1日就诊。发热伴咀嚼时有酸涩感，经用中药治疗2天未见好转。查：两腮部肿如碗口大。局部皮肤光亮，边缘不清，触之腮部有胀痛感，拒按，咀嚼困难，憎寒壮热，体温 39.5°C ，舌红，苔黄厚，脉滑数，经用上加减内服和外敷，治疗3天而愈。(韩树华，《新中医》，1989；(12)：封三。)

按：流行性腮腺炎属中医的“痄腮”。是由病毒引起的传染病。中医认为是风温时毒外侵，肺卫受邪，郁结于少阳所致。上方为银翘散和普济消毒饮化裁，具有疏风透表，清热解毒，软坚散结等功效，再配大黄，青黛局部外敷，内外同治，具有收效快、病程短，无并发症等特点，其效果优于抗菌素等西药。

178. 流行性腮腺炎

方名：二味拔毒散

来源：郑丙戌，《新中医》，1989；(2)：38。

组成：明雄黄、白矾各等分。

用法：将上药同研极细面，用米醋拌匀(醋药之比3:1)，每日外涂患处4~6次。

主治：流行性腮腺炎(痄腮)。

疗效：郑氏多年来用上法治疗疳腮200余例，有效率达90%以上。病例：刘××，女，5岁，1976年3月诊。患者于2天高热不退，继之两腮部肿痛难忍，触之肿物，左侧2×3厘米，右侧1.5×2厘米，体温39℃，经用西药无效，遂改用上法外涂。翌日，热退痛除，继用1日，肿块全无。

验证：贾氏用上法验治8例疳腮患者，疗效甚佳。病例：刘××，男，5岁，1989年3月4日就诊。其母代诉：发病3天，发热，右侧腮部肿痛难忍，查体温39.2℃，右腮肿物2×3厘米，用上方如法外涂，次日热退痛止，续用2日肿块即消。（贾焕成，《新中医》，1990；(11)：封三。）

按：二味拔毒散出自《医宗金鉴》。本云“此散治风湿诸疮，红肿痛痒、疥癬等疾。”方中雄黄解毒杀虫，治疮痈疗毒。本品含三硫化二砷，其水浸剂对皮肤真菌有抑制作用。白矾解毒杀菌，治痈疽疗疮恶疮。本品主含碱性硫酸铝钾，对金黄色葡萄球菌、炭疽杆菌、白喉杆菌，绿色链球菌等细菌均有效。醋有解热毒，消痈肿，散瘀止痛之功。对白色葡萄球菌，流行病毒等有杀灭作用。

179. 流行性腮腺炎

方名：复方柴胡注射液

来源：徐腊金，《新中医》，1986；(6)：14。

组成：柴胡等。

用法：肌肉注射柴胡液，每次2毫升，每日2次（10岁以上首此3毫升）。连用1~3天。

主治：流行性腮腺炎（疳腮）。

疗效：徐氏报道单用柴胡注射液治疗该病28例，治愈27例，其中24小时治愈的有7例，48小时的有15例，72小时的有5例。合并颌下淋巴结炎1例疗效不显。

验证：薛氏用上法验治腮腺多例，疗效确切。病例：奇××，男，9岁，学生。1986年10月27日就诊。两侧腮腺部肿胀，疼痛，腮腺管口红肿。体温39℃，有接触传染史。经用柴胡注射液4毫升肌注，每日2次，连用3日，热退肿消病愈。（薛来福，《新中医》，1987；（5）：56。）

李氏在腮腺流行期，用柴胡注射液验治18例，快则1天，慢则3天获愈，其效迅速，为一般药物所不及。（李建中，《新中医》，1987；（5）：56。）

按：流行性腮腺炎祖国医学称为“腮”。由于风邪外袭，内有积热，肝胆之火与胃热壅阻少阳经络，郁结不散而致。柴胡味苦性微寒，归肝胆二经，体质轻清，气味具薄，具升发之性，能疏散肝胆胃经郁热。现代药理研究认为具有明显的解热降温，镇静镇痛，抗炎镇咳等作用。故对“腮”有效。但对并发颌下淋巴结炎等细菌感染时，应及时应用抗菌素或采用其他方法治疗。

180. 腮 腺 炎

方名：治腮方

来源：陈培阳，《新中医》，1981；（7）：53。

组成：柴胡12克，葛根9克，天花粉9克，生石膏15克，黄芩9克，炒牛蒡子9克，连翘9克，桔梗9克，升麻9克，甘草9克。

用法：水煎服，每日一剂。

主治：腮腺炎。(痄腮)

疗效：陈氏几年来用上方治疗痄腮儿童几十人次，轻者一剂即愈，重者二~三剂。病例：张××，15岁，学生。开始寒热往来，日轻夜重，两腮逐渐肿起，如鸡子大之硬块，若用齿嚼饭两腮酸痛，舌质红，苔黄厚腻，脉象弦数，经用青链霉素，病情未减，改服上述中药二剂而痊愈。

验证：经李氏临床验证，疗效显著。1982年腮腺炎大流行，发病者数十人经用抗菌素，抗病毒等药治疗无效，改用上方治疗，轻则一剂，重者不过三剂而愈。病例：张××，男，13岁，学生，1982年9月5日初诊。寒热往来，日轻夜重，两腮肿痛，触之有硬块，舌红、苔黄厚腻、脉弦数，经用西药治疗病情不减，服上方二剂告愈。(李生岐，《新中医》，1988；(6):56。)

按：痄腮即腮腺炎。是由病毒引起的一种儿童常见传染病。用抗菌素、磺胺类药等效果均不好。应用清热解毒的中药每收良效。上方中石膏、黄芩、牛蒡子、连翘、升麻清热泻火以解瘟毒；柴胡、葛根、桔梗宣解表热；甘草既能解毒又能调和诸药。诸药合用而收清热解毒疏表退热之效。

181. 腮 腺 炎

方名：外敷方

来源：叶长青，《山东中医杂志》，1983；(5):42。

组成：大黄二份，芒硝一份，食醋适量。

用法：把大黄、芒硝研碎为细末，用醋调成糊状。应用

时先将患部皮肤洗净，然后将药糊涂于患处，面积略大于肿胀部位，每日敷1次。

主治：腮腺炎、急性乳腺炎等阳性疮疡初期及带状疱疹等。

疗效：叶氏用上方治疗腮腺炎、乳腺炎，带状疱疹等多例，轻者2~3次，重者3~4次即可愈。

验证：孙氏用上方验治3例腮腺炎，均用3~4次痊愈。（孙世福，《山东中医杂志》，1984；（5）：27。）

按：大黄、芒硝皆有清热泻火，消肿散结等功效，用醋调后局部外敷，不仅对腮腺炎有效，对其他急性炎症也有一定疗效。局部外敷即无痛苦，又收效快。

182. 流行性腮腺炎

方名：冰片豆腐膏

来源：张桂宝，《中医函授通讯》1987；（3）：封三。

组成：鲜豆腐一块，冰片3克。

用法：视腮腺肿大的部位，取新鲜豆腐适量拌成糊状，然后撒上冰片，用纱布包敷于患处，每天3次，连用3天。

主治：流行性腮腺炎（痄腮）。

疗效：张氏用该法治疗流行性腮腺炎40例，效果较好。

病例：杜某某，男，7岁，1983年1月29日诊，患腮腺炎2天，发烧，寒战，体温39.2℃，两侧腮腺红肿，扣之硬痛，用上法外敷治疗2天肿消而愈。

验证：笔者在临床上，尝试用该法治疗流行性腮腺炎3例，效果也佳。病例：孙某，5岁，男，1989年11月诊，左

侧腮红肿1天，触之疼痛，发烧，经用上法处理3天即愈。另发现，如发热病人同时食用生豆腐其效更佳。(范立孝、魏会东，桓台县医院。)

按：流行性腮腺炎病因是湿邪所受，发病较急，愈后一般较好。冰片苦、凉、是一治痈肿疔的药，本方好在用豆腐，豆腐本为食品，用生豆腐性凉，质润，且含有点浆用的生石膏，变化用之，化腐朽为神奇，清热消肿，治疗腮腺炎妙不可言。